

**Pq**

**18<sup>a</sup>**  
**ed**

Manual de  
**Psiquiatría**

---

**AMIR**

---

**Dirección editorial**

EDUARDO FRANCO DÍEZ (5)  
AIDA SUÁREZ BARRIENTOS (37)  
MIKEL MAEZTU RADA (27)  
PILAR PÉREZ GARCÍA (8)  
JAIME CAMPOS PAVÓN (9)

---

**MANUAL AMIR**  
**Psiquiatría**  
**(18.ª edición)****ISBN**

978-84-19592-85-9

**DEPÓSITO LEGAL**

M-22221-2023

**ACADEMIA DE ESTUDIOS MIR, S.L.**

[www.academiamir.com](http://www.academiamir.com)

[info@academiamir.com](mailto:info@academiamir.com)

**DISEÑO Y MAQUETACIÓN**

Equipo de Diseño y Maquetación AMIR

La protección de los derechos de autor se extiende tanto al contenido redaccional de la publicación como al diseño, ilustraciones y fotografías de la misma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso del propietario de los derechos de autor.



Este manual ha sido impreso con papel ecológico, sostenible y libre de cloro, y ha sido certificado según los estándares del FSC (*Forest Stewardship Council*) y del PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*).

PQ

**Psiquiatría**



# Orientación MIR

**[1,46]**  
**Rendimiento por asignatura**  
(preguntas por página)

Disciplina de importancia media en el examen MIR en cuanto al número de preguntas, con una media de **9 preguntas** en los últimos 10 años. En la última convocatoria el número de preguntas aumentó a 12.

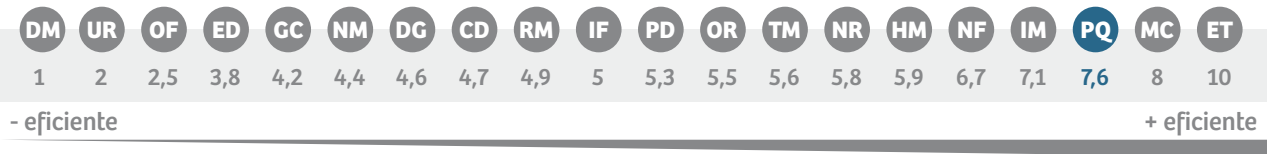
No es una asignatura en la que las preguntas se repitan de manera literal, pero sí los temas sobre los que estriban (trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos

**[9]**  
**Número medio de preguntas**  
(de los últimos 11 años)

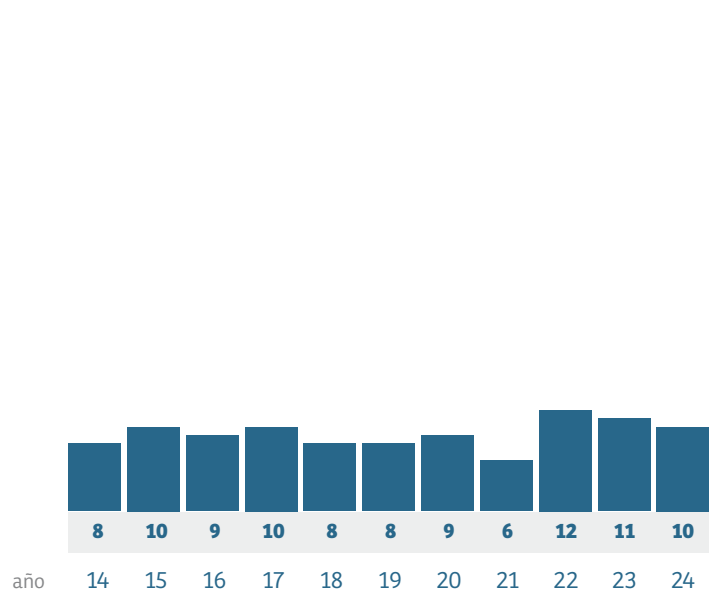
**[7,6]**  
**Eficiencia MIR**  
(rendimiento de la asignatura  
corregido por su dificultad en el MIR)

psicóticos y síndrome confusional agudo). También son fundamentales las nociones básicas de epidemiología (las preguntas más complicadas que se pueden esperar de esta asignatura), diagnóstico (cada vez son más frecuentes las preguntas en formato de caso clínico) y tratamiento (cada vez se preguntan más los psicofármacos; estudia bien sus nombres y sus principales efectos adversos).

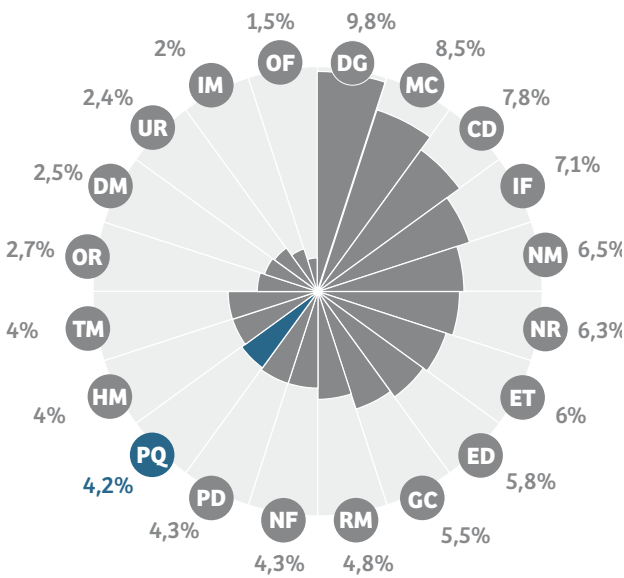
## Eficiencia MIR de la asignatura



## Tendencia general 2014-2024



## Importancia de la asignatura dentro del MIR



## Distribución por temas

[illegible]

|                |                                                                                       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tema 1</b>  | <b>Introducción</b>                                                                   | <b>11</b> |
| 1.1.           | Clasificaciones en psiquiatría                                                        | 11        |
| 1.2.           | Principales modelos de psicoterapia                                                   | 11        |
| 1.3.           | Psicopatología                                                                        | 12        |
| 1.4.           | Otros conceptos preguntados                                                           | 14        |
| 1.5.           | Pruebas de neuroimagen en Psiquiatría                                                 | 14        |
| <b>Tema 2</b>  | <b>Trastornos psicóticos</b>                                                          | <b>15</b> |
| 2.1.           | Esquizofrenia                                                                         | 15        |
| 2.2.           | Trastorno delirante crónico, paranoia o trastorno por ideas delirantes persistentes   | 18        |
| 2.3.           | Otros trastornos psicóticos                                                           | 19        |
| 2.4.           | Antipsicóticos o neurolépticos                                                        | 20        |
| <b>Tema 3</b>  | <b>Trastornos del estado de ánimo</b>                                                 | <b>23</b> |
| 3.1.           | Síndrome depresivo                                                                    | 23        |
| 3.2.           | Suicidio                                                                              | 26        |
| 3.3.           | Síndrome maniaco                                                                      | 28        |
| 3.4.           | Trastorno bipolar                                                                     | 29        |
| 3.5.           | Otros trastornos del estado de ánimo                                                  | 31        |
| 3.6.           | Tratamientos                                                                          | 31        |
| <b>Tema 4</b>  | <b>Trastornos de ansiedad</b>                                                         | <b>39</b> |
| 4.1.           | Trastorno de angustia ( <i>panic disorder</i> o trastorno de pánico)                  | 39        |
| 4.2.           | Trastornos fóbicos                                                                    | 40        |
| 4.3.           | Trastorno de ansiedad generalizada                                                    | 41        |
| 4.4.           | Trastorno por estrés postraumático (TEPT)                                             | 41        |
| 4.5.           | Trastorno obsesivo-compulsivo                                                         | 42        |
| 4.6.           | Benzodiacepinas                                                                       | 44        |
| <b>Tema 5</b>  | <b>Trastornos somatomorfos</b>                                                        | <b>46</b> |
| 5.1.           | Trastorno de somatización (síndrome de Briquet)                                       | 46        |
| 5.2.           | Trastorno somatomorfo indiferenciado                                                  | 46        |
| 5.3.           | Trastorno por dolor                                                                   | 46        |
| 5.4.           | Trastorno de conversión                                                               | 47        |
| 5.5.           | Trastorno de ansiedad por enfermedad (hipocondría)                                    | 47        |
| 5.6.           | Trastorno somatomorfo no especificado                                                 | 47        |
| <b>Tema 6</b>  | <b>Trastornos disociativos</b>                                                        | <b>48</b> |
| <b>Tema 7</b>  | <b>Trastornos facticios y simulación</b>                                              | <b>49</b> |
| 7.1.           | Trastornos facticios                                                                  | 49        |
| 7.2.           | Simulación                                                                            | 49        |
| <b>Tema 8</b>  | <b>Trastornos del control de impulsos</b>                                             | <b>50</b> |
| <b>Tema 9</b>  | <b>Trastornos de la conducta alimentaria</b>                                          | <b>51</b> |
| 9.1.           | Anorexia nerviosa                                                                     | 51        |
| 9.2.           | Bulimia nerviosa                                                                      | 52        |
| 9.3.           | Otros trastornos de la conducta alimentaria                                           | 54        |
| <b>Tema 10</b> | <b>Trastornos relacionados con sustancias y otras adicciones</b>                      | <b>55</b> |
| 10.1.          | Conceptos básicos                                                                     | 55        |
| 10.2.          | Alcoholismo                                                                           | 56        |
| 10.3.          | Tabaquismo                                                                            | 60        |
| 10.4.          | Opiáceos                                                                              | 60        |
| 10.5.          | Cocaína                                                                               | 62        |
| 10.6.          | Otras drogas                                                                          | 64        |
| 10.7.          | Adolescencia y adicciones                                                             | 65        |
| 10.8.          | Adicciones sin sustancia                                                              | 65        |
| <b>Tema 11</b> | <b>Trastornos mentales orgánicos o trastornos neurocognitivos</b>                     | <b>66</b> |
| 11.1.          | <i>Delirium</i> o síndrome confusional agudo                                          | 66        |
| 11.2.          | Pseudodemencia depresiva. Diagnóstico diferencial con las demencias de causa orgánica | 67        |
| 11.3.          | Clínica neuropsiquiátrica de la demencia                                              | 67        |

|                                               |                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tema 12</b>                                | <b>Trastornos del sueño .....</b>                                                     | <b>69</b> |
| 12.1.                                         | Sueño normal.....                                                                     | 69        |
| 12.2.                                         | Disomnias.....                                                                        | 70        |
| 12.3.                                         | Parasomnias.....                                                                      | 71        |
| <b>Tema 13</b>                                | <b>Trastornos de la personalidad .....</b>                                            | <b>72</b> |
| 13.1.                                         | Trastornos de la personalidad grupo A.....                                            | 72        |
| 13.2.                                         | Trastornos de la personalidad grupo B.....                                            | 72        |
| 13.3.                                         | Trastornos de la personalidad grupo C.....                                            | 73        |
| <b>Tema 14</b>                                | <b>Trastornos de la infancia y adolescencia .....</b>                                 | <b>74</b> |
| 14.1.                                         | Discapacidad intelectual (DSM-V) o trastorno del desarrollo intelectual (CIE-11)..... | 74        |
| 14.2.                                         | Trastornos del espectro autista.....                                                  | 75        |
| 14.3.                                         | Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).....                        | 75        |
| 14.4.                                         | Trastornos del lenguaje.....                                                          | 76        |
| 14.5.                                         | Trastornos del aprendizaje.....                                                       | 76        |
| 14.6.                                         | Trastornos de la eliminación.....                                                     | 77        |
| 14.7.                                         | Trastornos de tics.....                                                               | 77        |
| 14.8.                                         | Trastornos de ansiedad infantiles.....                                                | 77        |
| <b>Valores normales en Psiquiatría.....</b>   |                                                                                       | <b>79</b> |
| <b>Reglas mnemotécnicas Psiquiatría .....</b> |                                                                                       | <b>80</b> |
| <b>Bibliografía .....</b>                     |                                                                                       | <b>82</b> |





## Curiosidad

Sigmund Freud (1856-1939) es conocido fundamentalmente por haber sido el fundador del psicoanálisis, disciplina que rompía con el conocimiento vigente y generó una perspectiva novedosa respecto a la génesis y tratamiento de la enfermedad mental (no llamada así en el psicoanálisis). Lo que es menos conocido es que Freud era neurólogo y un tiempo fue discípulo del francés J. M. Charcot. Es considerado una de las figuras intelectuales más notables del siglo XX, fue nominado en múltiples ocasiones para el Premio Nobel de Fisiología o Medicina y, curiosamente, en 1.936, para el Premio Nobel de Literatura; no fue galardonado en ninguna de las nominaciones.



## Tema 1

# Introducción

**Autores:** Florencio García-Escribano Martín (21), Berta Pinilla Santos (21), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Kazuhiro Tajima Pozo (10), Rubén Galerón Guzmán (44).

### ENFOQUE MIR

Lo más importante de este tema es el **tema 1.3. Psicopatología**.

La psiquiatría es una especialidad un poco distinta. Hay pocas exploraciones complementarias, pocos signos patognomónicos y los tratamientos se confunden con facilidad.

### 1.1. Clasificaciones en psiquiatría

Las dos clasificaciones que hay que conocer son:

#### DSM

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la edición más reciente es el DSM-5 (quinta edición) publicada en 2013.

Frente a su edición anterior, de 2002, los cambios más notables son:

- Desaparece el sistema de clasificación multiaxial de los trastornos mentales (ejes I a V).
- Reubicación de algunos trastornos mentales en nuevos grupos.
- Se requieren especificadores así como el grado de severidad.
- Incluye una sección 3 donde introduce propuestas de investigación y herramientas diagnósticas.

#### CIE-11

Clasificación Internacional de Enfermedades-Undécima Revisión. Es la clasificación europea, utilizada por la OMS. Su última edición entró en vigor en 2022.

### 1.2. Principales modelos de psicoterapia

El tratamiento combinado de psicoterapia y psicofármacos obtiene resultados superiores a los de cada uno de estos por separado (**MIR 23, 94**).

### Psicoanálisis o terapia psicodinámica

Centrado en el inconsciente y en los mecanismos intrapsíquicos de resistencia, transferencia y deseo. Se parte del supuesto de explorar en el sujeto mecanismos inconscientes que han dejado conflictos intrapsíquicos sin resolver, que dan lugar a síntomas psiquiátricos. Se usa en trastornos neuróticos, más en América que en Europa. El principal autor y creador de esta corriente es Sigmund Freud.

### Humanística

Se centra en la búsqueda de la integración, del sentido y del lugar social y personal del ser humano. Derivada del psicoanálisis, se separó de éste.

### Conductual

Basada en la teoría del aprendizaje, se centra en cambios de conducta ante situaciones de conflicto. Busca resolver situaciones concretas sin explorar sus causas sino centrándose en cambiar conductas que pueden ser desadaptativas. Muy usada en fobias, trastornos de angustia, trastornos alimentarios, adicciones, trastornos de control de impulsos, trastornos obsesivos.

### Cognitiva

Basada en la identificación de pensamientos erróneos y corrección de las distorsiones irracionales. Buscan cambiar la manera que el sujeto tiene de interpretar la realidad, de forma que se ofrezcan pensamientos alternativos que puedan ser más útiles para resolver conflictos. No pretende encontrar los orígenes de los trastornos sino buscar su solución. Suele combinarse con la terapia conductual. Tiene las mismas indicaciones que aquella y además se usa también mucho en trastornos depresivos y en trastornos de personalidad.

## Sistémica

Centrada en el sistema de relaciones del sujeto, básicamente familiares. Deriva del psicoanálisis y busca intervenir en el sistema familiar para centrarse en resolver los conflictos de adaptación.

### 1.3. Psicopatología

La exploración psicopatológica es un examen sistemático de las distintas esferas de las funciones psíquicas:

#### Trastornos de la orientación

Deben valorarse los distintos campos de la orientación:

- Respecto al **lugar**.
- Respecto al **tiempo**.
- Respecto de la **propia persona**: se refiere a la conciencia sobre la unidad, la continuidad y la identidad de cada uno.

#### Trastornos de la psicomotricidad

- **Inhibición psicomotriz**: desde un ligero enlentecimiento psicomotor, hasta el estupor o la catatonía.
- **Agitación psicomotriz**: desde la inquietud hasta una verdadera agitación.

#### Trastornos de la memoria y atención

##### Alteraciones cuantitativas de la memoria

- **Hipermnesia/hipomnesia**: aumento/disminución de la capacidad de memorizar.
- **Amnesia**: es la pérdida de la capacidad de almacenar nueva información o de recordar lo ya aprendido. Puede ser **retrograda** (impide recordar lo sucedido en un periodo anterior a un suceso –normalmente un trauma–), o **anterógrada** (de fijación, impide aprender nuevos datos tras el trauma).

##### Alteraciones cualitativas de la memoria

- **Paramnesia** o alucinación del recuerdo: se toman como recuerdos reales lo que tan sólo son fantasías en su imaginación; se incluyen la **fabulación** (producciones imaginarias tomadas como recuerdos), **confabulación** (subtipo de fabulación que tiene lugar en pacientes con lagunas mnésicas; típica de los alcohólicos –síndrome de Korsakov–) y la **pseudología fantástica** (los hechos a los que se refiere el paciente son claramente inventados, normalmente debido a una necesidad afectiva, con la intención de obtener un reconocimiento social).
- **Criptomnesia** o alteración en el reconocimiento: incluye los fenómenos “*dejà vu*” o “*jamais vu*” y el síndrome de Capgras (delirio de dobles).

## Alteraciones de la atención

- Hablamos de **hiperprosexia**, **hipoprosexia** y **aprosexia** refiriéndonos al aumento, disminución o abolición de la atención respectivamente.

#### Trastornos del lenguaje

Algunos de los términos se solapan con los de la psicopatología del pensamiento, ya que el lenguaje es la expresión de éste.

- **Taquilalia o taquifasia**: aceleración del lenguaje.
- **Bradilalia o bradifasia**: enlentecimiento del lenguaje.
- **Disartria**: problemas en la articulación del lenguaje.
- **Ecolalia**: repetición de palabras dichas anteriormente por el interlocutor.
- **Verbigeración**: repetición continua de las mismas palabras o frases.
- **Lenguaje prolijo o circunstancial**: aporta numerosos detalles innecesarios en su discurso.
- **Disfemia o tartamudez**.
- **Tangencialidad**: la respuesta no se adapta exactamente a la pregunta.
- **Pararrespuesta**: respuesta que no tiene ninguna relación con la pregunta formulada.
- **Neologismo**: creación de nuevas palabras que incluye en su discurso.

#### Trastornos de la percepción

- **Alucinación negativa**: imposibilidad de percibir un determinado estímulo en sujetos con sistema fisiológico intacto.
- **Ilusión**: mala interpretación de una experiencia sensorial externa real. Puede darse en personas normales en situación de ansiedad, en estados tóxicos o en esquizofrenia (interpretar un ruido como un insulto). Las ilusiones desencadenadas por emociones son catatímicas; las desencadenadas por deseos son desiderativas o pareidolias.
- **Alucinación (MIR)**: percepción aparente de un objeto externo cuando no existe el real correspondiente. Pueden aparecer por enfermedad cerebral orgánica, enfermedad metabólica, drogas y agentes químicos. Hay conciencia de realidad.
- **Pseudoalucinación**: percepción de objeto irreal, con conciencia de realidad, únicamente en el espacio interior: por ejemplo, en las voces oídas en la esquizofrenia, cuando sólo se oyen “dentro de la cabeza”. Puede ser también un fenómeno de “sonorización del pensamiento”.
- **Alucinosis**: percepción de objeto irreal, en espacio exterior, con conciencia de irrealidad. Normalmente son visuales. Aparece en alcoholismo y en estados de disfunción cerebral orgánica. Otro ejemplo puede ser la alucinosis del miembro fantasma.

(Ver tabla 1)

|                    | OBJETO REAL | CONVENCIMIENTO DE REALIDAD | ESPACIO DE LA PERCEPCIÓN | ENFERMEDAD                      | EJEMPLO                                                  |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ALUCINACIÓN        | Inexistente | Sí                         | Exterior                 | Enfermedad metabólica<br>Drogas | Ver personas de pie a tu lado                            |
| PSEUDO-ALUCINACIÓN | Inexistente | Sí                         | Interior                 | Esquizofrenia                   | Oír voces dentro de tu cabeza                            |
| ALUCINOSIS         | Inexistente | No (¡pide ayuda!)          | Exterior                 | Alcoholismo                     | Algo me pasa, veo enanitos                               |
| ILUSIÓN            | Existente   | Sí                         | Exterior                 | Ansiedad                        | Creer que una persona es un abrigo colgado en una percha |

Tabla 1. Trastornos de la percepción.

## Trastornos del pensamiento

### Alteraciones del contenido

- **Delirio o idea delirante:** idea o creencia falsa de contenido imposible, convicción irrefutable, e inmodificable por la experiencia o la evidencia empírica. Según el contenido pueden ser de perjuicio o persecución, de referencia (sentirse observado o vigilado), celotípicos (de celos), erotomaniaco (de enamoramiento), megalomaniacos (de grandeza), de culpa o condenación, de ruina o pobreza, de infestación, de enfermedad, de alienación del pensamiento (robo, inserción, control, lectura, o difusión del pensamiento).

Un **delirio primario** aparece de forma brusca, con convicción completa, y sin ninguna otra alteración mental que le haya conducido a él. Es característico de la esquizofrenia.

Un **delirio secundario** surge comprensiblemente de una experiencia anormal previa. Esta experiencia suele ser generalmente secundaria a un estado de ánimo (ideas de ruina, de culpa, enfermedad en el caso de la depresión, e ideas megalómanas en las manías).

#### Recuerda...

Delirio **no** es sinónimo de esquizofrenia.

| TEMÁTICA DELIRANTE         | ENFERMEDAD                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Persecución/perjuicio      | Esquizofrenia paranoide<br>Trastorno delirante |
| Megalomaniaco (grandeza)   | Trastorno bipolar (manía)                      |
| Ruina/culpa                | Depresión delirante                            |
| Celotipia                  | Trastorno delirante crónico/alcoholismo        |
| Erotomaniaco (Clerambault) | Trastorno delirante crónico                    |

Tabla 2. Delirios en psiquiatría.

- **Idea sobrevalorada:** aquella que no llega a ser tan inaceptable (según procedencia cultural o social) o que no es defendida con tanta intensidad como la idea delirante.

### Alteraciones del curso del pensamiento

- **Fuga de ideas:** disminución de la fuerza conductora de la idea directriz, apareciendo un **pensamiento saltigrado**, con cambios constantes de tema, todo ello a gran velocidad.
- **Pensamiento inhibido:** se observa bradipsiquia (**pensamiento enlentecido**) y pobreza ideativa. Mutismo: inhibición completa del habla.
- **Pensamiento bloqueado (bloqueo del pensamiento):** interrupción brusca del curso del pensamiento, con pérdida de la idea directriz. El paciente lo vive como incapacidad para terminar sus pensamientos, como si estos desapareciesen.
- **Pensamiento disgregado (MIR 15, 156):** pérdida reiterada de la idea directriz, apareciendo como falto de lógica. Típico de la esquizofrenia.
- **Pensamiento incoherente:** mezcla de las alteraciones del curso y el contenido del pensamiento apareciendo una pérdida del hilo argumental junto con la incompreensión semántica del lenguaje.
- **Pensamiento prolijo o circunstancial:** sobreabundancia de datos innó una escasez ideativa con una repetición monótona de las ideas, expresadas con un lenguaje reiterativo.

## Trastornos de la afectividad

- **Ánimo depresivo:** los síntomas predominantes son la tristeza, desesperanza e infelicidad, junto con una disminución del impulso vital y desinterés por el entorno. La **anhedonia** es la incapacidad para disfrutar o sentir placer con las situaciones que anteriormente lo producían. En los casos más graves se produce una auténtica **anestesia afectiva**.
- Cuando la respuesta afectiva no se adecúa al contexto emocional se denomina **paratimia** y, a la incapacidad

para encontrar palabras que definan sus sentimientos, **alexitimia**.

- **Humor hipértímico o maníaco:** elevación del estado de ánimo o **euforia**, asociada a taquipsiquia e hiperactividad psicomotriz. Suelen mostrarse distraídos, expresando dificultades para poner freno a su hiperactividad.

## Trastornos de la conducta alimentaria y del sueño

### Respecto a la ingesta

- Hablamos de **hiperfagia** (aumento sostenido de la ingesta), **bulimia** (incremento episódico), **anorexia** (disminución de la ingesta).

#### Recuerda...

Hablamos de anorexia como síntoma, es decir, estrictamente como la disminución o ausencia de ingesta. Lo que es diferente de la enfermedad de anorexia nerviosa.

- Si nos referimos a líquidos, **adipsia** y **polidipsia**, **potomanía** (hábito de beber grandes cantidades de líquido, de origen psicógeno) y **dipsomanía** (ingesta de líquido de carácter impulsivo, irresistible y transitorio).

### Respecto al sueño

- **Insomnio:** de conciliación, de mantenimiento o de despertar precoz. Muy rara es la **agripnia** o ausencia total de sueño.
- **Hipersomnias.**

## 1.4. Otros conceptos preguntados

- **Psicosis:** término general que engloba enfermedades en las que existe una alteración del juicio de realidad, y por tanto una incapacidad para discernir entre la reali-

dad interna y la externa, y característicamente donde los delirios y alucinaciones son lo más llamativo de la clínica (**MIR**). Ejemplos: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno delirante, psicosis tóxica.

- **Neurosis:** término general para designar las alteraciones funcionales del psiquismo. En ellas **no** hay **pérdida** del juicio de **realidad**. Agrupa los trastornos del estado de ánimo –excepto el trastorno bipolar–, los somatomorfos, disociativos, los de ansiedad, los alimentarios y los de la personalidad.

El uso de estos términos está desfasado.

- **Transferencia:** sentimientos que el médico proyecta en el enfermo; pueden ser utilizados a través de la terapia.
- **Contratransferencia:** sentimientos que el enfermo provoca en el médico. Es importante intentar que no influyan en la relación terapéutica (**MIR**).

Ambos pueden ser positivos o negativos en función del sentimiento subjetivo que se produzca entre enfermo y terapeuta.

## 1.5. Pruebas de neuroimagen en Psiquiatría

Las indicaciones para la realización de pruebas de neuroimagen en Psiquiatría son cada vez más amplias, y no se limitan a la realización de diagnóstico diferencial con trastornos de causa no psiquiátrica. Además de trastornos médicos y neurológicos con potencial de generar patología psiquiátrica, la TC y RM aportan un claro valor diagnóstico en pacientes con (**MIR 22, 91**):

- Delirium y/o demencias de causa desconocida.
- Primer episodio de síntomas psicóticos de etiología desconocida.
- Trastorno de la conducta alimentaria tipo anorexia.
- Catatonía prolongada.
- Primer episodio de trastorno afectivo o cambio de personalidad, en pacientes >50 años.
- Historia de abuso de alcohol.

## Tema 2

# Trastornos psíquicos

**Autores:** Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Berta Pinilla Santos (21), Rafael Baena Mures (10), Florencio García-Escribano Martín (21).

### ENFOQUE MIR

Lo fundamental: la esquizofrenia, especialmente, los factores pronósticos y los efectos secundarios de los antipsicóticos.

## 2.1. Esquizofrenia

### Concepto

La esquizofrenia es un trastorno **psíquico** que produce una alteración mental global y desestructurante. Se caracteriza por la aparición de alteraciones en la forma y contenido del pensamiento, la sensopercepción y la conducta y es **deteriorante** en sentido de afectación del funcionamiento social y laboral del sujeto afecto (**MIR**). Su curso es **crónico** y generalmente oscilante (remitencias-recurrencias).

La esquizofrenia, como psicosis que es, conlleva una alteración del juicio de la realidad con **ausencia de conciencia de trastorno (MIR)**.

### Epidemiología

La prevalencia de esquizofrenia en población general es del 0,7% y su incidencia anual media es de 20-40 casos por 100.00 habitantes.

No hay diferencias entre sexos, culturas ni etnias.

Mayor frecuencia en estratos socioeconómicos bajos, por factores diversos (intrínsecos y extrínsecos).

La esquizofrenia se inicia principalmente en la edad adulta, entre los 18-25 años en hombres y entre los 25-35 en mujeres. El inicio precoz (antes de los 18 años) es más frecuente en varones (**MIR 24, 83**), y el inicio tardío (más allá de los 40 años), en mujeres.

### Etiología

Intervienen factores de diversa índole:

- Factores genéticos: genética compleja que determina su componente de heredabilidad con riesgo del 8% en hermanos, 12% para hijo de un progenitor afecto, 40% si los 2 progenitores están afectados y 47% en gemelos monocigóticos.
- Neuroquímica: se produce un desequilibrio en la neurotransmisión de diferentes vías, la más replicada, la dopaminérgica, concretamente el exceso dopaminérgico de la vía mesolímbica (síntomas positivos). La

alteración en serotonina se ha relacionado con las alucinaciones y síntomas afectivos, y hay otros implicados (GABA, glutamato).

- Alteraciones neuroanatómicas estructurales y funcionales, detectadas y descritas por técnicas de neuroimagen, fundamentalmente RM.
- Factores ambientales: un ambiente estresor en la gestación y el parto (infección vírica durante el embarazo, sufrimiento fetal) o durante el desarrollo infantojuvenil (negligencia, malos tratos y abusos, eventos vitales adversos) se consideran factores de riesgo.

**Hipótesis del neurodesarrollo:** englobaría todos los factores relacionados. Hay evidencias de una migración anormal de las neuronas del lóbulo frontal durante el segundo trimestre de gestación. Alteraciones de la mediación glutamatérgica del desarrollo neuronal en la adolescencia darían lugar a la aparición de la clínica. Esta teoría es una de las que despierta mayor interés.

### Clínica

Los síntomas de la esquizofrenia se clasifican en **positivos y negativos**.

### Síntomas positivos

Son distorsiones de funciones psíquicas normales. Diferenciamos:

- **Ideas delirantes.** De contenido variado:
  - De persecución.
  - De referencia (el sujeto cree que medios de comunicación o personas desconocidas aluden a él).
  - De perjuicio.

Estas tres anteriores son las más frecuentes (**MIR**).

- Otras: somáticas (creencia en cambios corporales); religiosas (comunicación con Dios); de robo, inserción, control del pensamiento; o de grandiosidad (creencia en que se le reserva un destino especial, o que es un personaje privilegiado).

- **Alucinaciones:** las principales y más frecuentes son las alucinaciones y pseudoalucinaciones **auditivas (MIR)**: voces que hablan del sujeto o que se dirigen a él (**MIR**).

Mucho menos frecuentes, las cenestésicas (táctiles, como ser tocado, o penetrado en el interior del organismo) y en raras ocasiones visuales, cuya presencia obliga, de hecho, a descartar cuadros exógenos: consumo de alucinógenos o presencia de enfermedad orgánica cerebral o sistémica (**MIR**).



- **Trastornos del lenguaje/desorganización del pensamiento:** ha sido considerada como la característica más importante de la esquizofrenia (MIR).

- **Descarrilamiento:** discurso que pierde el hilo, asociaciones laxas entre las frases.
- **Incoherencia:** desorganización profunda que hace el discurso incomprensible. En este punto es donde se identifican neologismos, paralogías y otras alteraciones sintácticas y semánticas.
- Respuestas tangenciales, que no guardan relación con la pregunta.
- Verbigeración: repetición de palabras o frases sin propósito claro.
- A nivel de la conducta es posible encontrar estereotipias y, menos frecuentemente, manierismos.

### Síntomas negativos (MIR 19, 186; MIR)

Suponen un déficit de funciones normales, son:

- **Aplanamiento afectivo:** el sujeto se muestra indiferente, apático y distante.
- **Alogia:** déficit de la producción del pensamiento y fluidez verbal; el lenguaje se empobrece y se hace ininteligible.
- **Anhedonia:** presentan una menor respuesta emocional, a veces suficientemente grave como para justificar la denominación de anhedonia.
- **Déficit de atención.**
- **Abulia:** déficit del comportamiento dirigido a un objetivo concreto.
- **Pérdida del funcionamiento social:** con tendencia al aislamiento (autismo esquizofrénico).
- **Bloqueos del pensamiento:** producto del empobrecimiento cognitivo. En alguna clasificación se considera este fenómeno como una consecuencia de la desorganización del pensamiento y del lenguaje y por lo tanto, un síntoma positivo.

#### Regla mnemotécnica

##### Síntomas negativos de esquizofrenia

Las **A**:

**A**patía  
**A**bulia  
**A**logia  
**A**nhedonia  
**A**planamiento afectivo  
**A**tención disminuida  
**A**utismo  
**A**islamiento social (pérdida de funcionamiento social)

### Signos neurológicos menores (MIR)

Además de lo anterior, los pacientes con esquizofrenia muestran una prevalencia mayor que la de la población general de **signos neurológicos menores**. Éstos representan realizaciones anómalas en tests neurológicos no

específicos (no se corresponden con una lesión claramente localizable a diferencia de los signos neurológicos mayores). Algunos ejemplos de estos signos son la distinción derecha-izquierda, la estereognosis, la grafestesia, la alteración en la oposición del pulgar y movimientos en espejo en la mano contraria, la disidiadococinesia, etc.

#### Curso

Se distinguen tres fases:

- **Prodrómica** (trema): meses antes del inicio del trastorno, problemas inespecíficos: cambios en el estado de ánimo, dificultades de interacción social, ansiedad.
- **Psicótica:** alteraciones de pensamiento y conducta con los síntomas reseñados. La clínica suele cursar en forma de episodios psicóticos, de forma remitente-recurrente. Es cuando suceden estos episodios o descompensaciones psicóticas cuando suele ser necesaria la hospitalización para el tratamiento; ésta se acostumbra a realizar en unidades específicas y es limitada en el tiempo (Agudos, Hospitalización Breve o Corta Estancia) (MIR).
- **Residual:** son más marcados los síntomas negativos y el defecto en el área sociolaboral y del autocuidado.

#### Subtipos de esquizofrenia

Los subtipos son presentaciones clínicas particulares. Sin embargo, no se han encontrado correlaciones anatómicas, marcadores ni estrategias de tratamiento específicas, de ahí el cambio a un enfoque dimensional de las nuevas clasificaciones.

#### Recuerda...

Tanto en la CIE 11 como en el DSM 5 desaparece la clasificación por subtipos y se introduce la especificación por curso (primer episodio, múltiples o continuo) y gravedad de los síntomas en el momento actual. Además la catatonia pasa a considerarse un síndrome independiente y transdiagnóstico.

- **Esquizofrenia paranoide:** se caracteriza por la presencia de trastornos del pensamiento y senso-perceptivos (delirios y alucinaciones) (MIR 12, 155), y la ausencia de un comportamiento muy desorganizado, aplanamiento afectivo o lenguaje incoherente. Respecto a otros subtipos, es el más frecuente y el de mejor pronóstico (por ser menos marcados los síntomas negativos y ser más eficaces los antipsicóticos), y suele debutar a mayor edad.

#### Regla mnemotécnica

En la esquizofrenia **P**aranoide predominan síntomas **P**ositivos, y es **P**ositivo tener este tipo de esquizofrenia (mejor pronóstico).

*Autora: Cintia Viktória Rétháti*



- **Esquizofrenia desorganizada o hebefrenia:** predominio de síntomas de desorganización y negativos, (MIR). Es de inicio precoz en la adolescencia, presentando peor respuesta a tratamiento y mal pronóstico (MIR).

- **Esquizofrenia catatónica:** el síndrome catatónico se puede dar en la esquizofrenia (en cuyo caso, y si es la manifestación principal, nos referimos a esquizofrenia catatónica, tratándose de un subtipo raro de esquizofrenia) pero también en otros trastornos psiquiátricos y neurológicos, siendo más prevalente en los trastornos del estado de ánimo y en los trastornos psicoorgánicos que en la propia esquizofrenia.

Su prevalencia aproximada es de un 10% de los ingresos psiquiátricos, en forma de uno o más síntomas catatónicos, si bien el síndrome completo es actualmente poco frecuente.

Consiste en (MIR): mutismo, inmovilidad, negativismo, adopción de posturas fijas (catalepsia), flexibilidad cerea, conductas estereotipadas (verbigeración, palilalia), obediencia automática, ambitendencia, ecofenómenos (ecolalia, ecopraxia (MIR 10, 153)) y manierismos. Puede aparecer estupor, con ausencia de reactividad a estímulos externos (MIR 14, 224). El síndrome catatónico responde escasamente a los antipsicóticos y mejora con benzodiacepinas (lorazepam) a dosis altas o TEC.

- **Esquizofrenia simple (CIE):** denominada en el DSM “trastorno deteriorante simple”, ya que no se la incluye, a diferencia de la CIE, dentro de los subtipos de esquizofrenia. Se caracteriza por una pérdida gradual y lenta de los instintos y de la iniciativa, consistiendo su cuadro clínico en el retraimiento de todas las situaciones sociales y laborales sin apenas manifestar síntomas psicóticos (MIR 17, 184; MIR). Es poco frecuente y su pronóstico es malo.
- **Esquizofrenia residual:** persistencia de síntomas negativos habiendo desaparecido los positivos. Respuesta insuficiente a tratamientos y mal pronóstico.
- **Esquizofrenia indiferenciada:** cuando reúne características de varios subtipos sin uno dominante.
- **Esquizofrenia de inicio tardío** (antes llamada parafrenia, actualmente es un término en desuso): es una forma de aparición tardía (más de 45 años) con delirios muy estructurados y complejos, alucinaciones y escasa clínica negativa y deterioro. Es como una forma tardía de esquizofrenia paranoide (MIR).

### Otra clasificación

Existe otra clasificación, poco o nada usada en la práctica, pero que conviene conocer:

|                           | TIPO I    | TIPO II   |
|---------------------------|-----------|-----------|
| SÍNTOMAS                  | Positivos | Negativos |
| VENTRÍCULOS               | Normales  | Dilatados |
| RESPUESTA A NEUROLÉPTICOS | Buena     | Peor      |

Tabla 1. Tipos de esquizofrenia.

## Diagnóstico

Para el diagnóstico es necesario:

- Síntomas característicos: dos o más de los siguientes, cada uno presente durante un periodo significativo de **un mes** (o menos, si se realiza tratamiento con éxito):
  - Delirios.
  - Alucinaciones.
  - Desorden del lenguaje.
  - Desorganización extrema o comportamiento catatónico.
  - Síntomas negativos (aplanamiento afectivo, alogia, disminución de la motivación).
- Disfunción social/ocupacional: durante un periodo significativo de tiempo a partir de la aparición de la enfermedad, una o varias de las áreas principales de actuación tales como el trabajo, relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están marcadamente por debajo del nivel logrado antes de la aparición de la enfermedad (MIR).
- Duración: signos continuos de perturbación durante al menos **seis meses** (MIR). Este periodo de seis meses debe incluir al menos un mes de síntomas (o menos, si se trata con éxito), que cumplen con el criterio A.

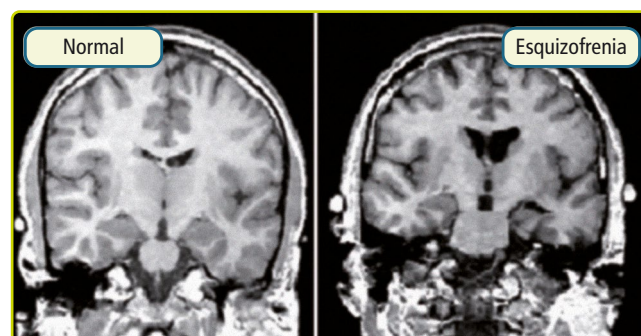


Figura 1. Alteraciones neuroanatómicas en la esquizofrenia.

### Pruebas complementarias

No existen marcadores biológicos diagnósticos de esquizofrenia. Los hallazgos de neuroimagen más comunes son:

- Dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales.
- Hipofrontalidad.
- Atrofia.

## Pronóstico

Se dice que sigue la “regla de los tercios”: un tercio permanece prácticamente asintomático y conserva adecuado rendimiento global; en otro tercio hay descompensaciones con recuperación, pero existe impacto en el funcionamiento social y laboral; y en el último tercio, los síntomas

son persistentes, tanto positivos como negativos, con necesidad de atención y soporte e interrupción del desarrollo personal, laboral y social.

Es importante recordar los factores pronósticos en la esquizofrenia.

La **comorbilidad** más frecuente de la esquizofrenia es el abuso de sustancias, que empeora el curso y pronóstico. Alrededor del 30-50% de los casos de esquizofrenia cumplen con criterios de dependencia o abuso de alcohol. A la presencia conjunta de un trastorno por abuso de sustancias y una enfermedad psiquiátrica grave se le denomina patología dual.

### Recuerda...

Tener factores de buen pronóstico atendiendo a la historia natural de la esquizofrenia no implica tener un riesgo bajo de suicidio. El riesgo de suicidio aumenta, paradójicamente, en pacientes con datos de mejor pronóstico: varones, jóvenes, con diagnóstico reciente de esquizofrenia y capacidad afectiva preservada. Estos pacientes tienen un riesgo alto de depresión postpsicótica (hasta 80%), que es el factor de riesgo de suicidio más importante.

### FACTORES DE BUEN PRONÓSTICO

- Infancia normal y buen nivel de introspección previo (los más importantes).
- Buen ajuste premórbido.
- Inicio brusco con acontecimientos precipitantes (MIR).
- Predominio de síntomas positivos.
- Síntomas residuales mínimos.
- Síntomas afectivos prominentes (historia familiar de trastorno bipolar o depresión) (MIR 16, 220).
- Ausencia de familiares con esquizofrenia.
- Alto CI previo y buen funcionamiento sociolaboral.
- Buen apoyo familiar (casados).
- Ausencia de anomalías neurológicas.

### FACTORES DE MAL PRONÓSTICO

- Mala adaptación escolar o familiar previa.
- Comienzo insidioso (MIR).
- Predominio de síntomas negativos (MIR).
- Aislamiento social tras el brote, larga duración del episodio, síntomas residuales intensos.
- Embotamiento afectivo.
- Historia familiar de esquizofrenia.
- Bajo CI previo o mal funcionamiento sociolaboral.
- Escaso apoyo familiar (solteros o divorciados).
- Presencia de anomalías neurológicas.
- Sexo masculino (MIR 10, 149).

Tabla 2. Factores pronósticos de la esquizofrenia.

## Tratamiento

### 1. Antipsicóticos

Son el tratamiento de elección (MIR) tanto para el episodio psicótico **agudo** como para el tratamiento de **mantenimiento**. Ningún antipsicótico es completamente eficaz en síntomas negativos (MIR).

El tratamiento de mantenimiento se recomienda de **1 a 2 años** después de **un primer episodio psicótico** (MIR). La **sucesión de episodios**, persistencia de la clínica o existencia de factores de riesgo para la descompensación son criterios para recomendar **tratamientos de más larga duración**, siempre buscando la mínima dosis eficaz; en práctica, en estos casos el tratamiento se mantiene de por vida y se tienen muy presentes los riesgos y signos de alarma con la retirada.

La interrupción debe hacerse escalonada. La interrupción brusca aumenta las recaídas y la discinesia tardía.

Dada la escasa conciencia de enfermedad, los pacientes abandonan el tratamiento por iniciativa propia con frecuencia. Para poder hablar de una esquizofrenia resistente al tratamiento debemos verificar que el paciente estuviera cumpliendo el tratamiento prescrito (MIR).

### 2. Terapia electroconvulsiva (TEC) (MIR)

La TEC es eficaz en las formas catatónicas (la catatonía como síndrome es una de sus indicaciones), y se reserva para los casos de resistencia a antipsicóticos con persistencia de síntomas positivos o alteraciones de conducta.

### 3. Tratamientos no farmacológicos

- Terapias de familia: dirigidas a educación sobre enfermedad y afrontamiento de la convivencia.
- Terapias de rehabilitación cognitiva: dirigidas a recuperación de déficit causados por la enfermedad.
- Terapias de conducta: afrontamiento de situaciones sociales, familiares, laborales.
- Terapias de grupo.
- Intervenciones sociales destinadas a la integración y readaptación comunitaria y ayuda en la autonomía: talleres o centros de día, cursos, formaciones o trabajos adaptados, recursos de residencia o pisos tutelados.

### 2.2. Trastorno delirante crónico, paranoia o trastorno por ideas delirantes persistentes (MIR 18, 203)

### ENFOQUE MIR

Lo más preguntado son las diferencias con la esquizofrenia.

Trastorno psicótico caracterizado por la presencia de un delirio bien sistematizado, rico y estructurado (MIR 12, 160; MIR), monotemático, habitualmente sin otros síntomas asociados. El sujeto vive su delirio en buena parte aislado del resto de su vida, que no queda afectada.

La edad de inicio suele situarse alrededor de los 40 años (MIR 13, 173), pero su rango varía de los 18 a 90 años. Hay una ligera preponderancia de pacientes de sexo femenino.

Según el contenido del delirio, se distinguen (MIR):

- Tipo persecutorio (el más frecuente): el sujeto cree ser perseguido, espiado, envenenado o drogado, o bien obstaculizado sistemáticamente.
- Tipo erotomaniaco (síndrome de Clerambault): el sujeto cree que alguna persona, a menudo famosa, se ha enamorado de él (MIR).
- Tipo de grandiosidad: convicción de poseer algún talento o poder extraordinario, o haber hecho algo importante. Puede referirse a contenidos religiosos (haber sido distinguido por Dios).
- Tipo celotípico (de Otelo): convicción de que el cónyuge o amante le es infiel (MIR).

Es un tipo frecuente, con mayor presentación en hombres. Característico y frecuente en alcoholismo (MIR 16, 219).

- Tipo somático: ideas delirantes referidas a alteraciones corporales. Puede creer estar infectado de parásitos (MIR) (síndrome dermatozoico senil o de Ekbom, que tiene como tratamiento de elección el pimocida (MIR) – un antipsicótico clásico–), emitir un olor peculiar, padecer alguna malformación, o creer que hay órganos en su cuerpo que no funcionan.

|                             | PARANOIA                                      | ESQUIZOFRENIA                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PREVALENCIA                 | 0,03%                                         | 1%                                             |
| PERSONALIDAD PREVIA         | Paranoide                                     | Normal                                         |
| INICIO                      | Insidioso (años)                              | Rápido (meses)                                 |
| DETERIORO PERSONAL Y SOCIAL | Nulo o escaso                                 | Grave                                          |
| DELIRIOS                    | Estructurados, complejos                      | Mal sistematizados, pobres                     |
| ALUCINACIONES               | Raras<br>Táctiles u olfativas                 | Frecuentes<br>Auditivas                        |
| RESPUESTA A TRATAMIENTO     | Escasa en delirio<br>Mejora adaptación social | Buena en delirio<br>Peor en síntomas negativos |

Tabla 3. Diferencias entre esquizofrenia y trastorno delirante crónico.

## Curso y tratamiento

El curso de la enfermedad es crónico. Se consigue un control sintomático con el tratamiento, disminuyendo la intensidad de la ideación delirante (encapsulación del delirio) y por tanto la repercusión de la misma –tanto las alteraciones de conducta asociadas como la reacción emocional del paciente–.

Los **antipsicóticos** son el **tratamiento** de elección. La adherencia al tratamiento en este trastorno suele ser baja debido a la escasa conciencia, recomendación de mantenimiento farmacológico y los efectos indeseables del mismo.

## 2.3. Otros trastornos psicóticos

### ENFOQUE MIR

No preguntados directamente. A veces la nomenclatura cambia con las clasificaciones.

## Trastorno esquizoafectivo

Clínica de **esquizofrenia conjunta con depresión mayor o manía**, que aparecen de forma simultánea o próxima en el tiempo. El tratamiento farmacológico suele ser mediante combinación de antipsicóticos, eutimizantes y antidepresivos.

## Trastorno psicótico breve (o agudo y transitorio)

Cuadro psicótico que puede cursar con toda la clínica característica de la esquizofrenia pero que aparece de forma **repentina** y no dura mucho tiempo (generalmente menos de **1 mes**). Los síntomas suelen ser cambiantes mientras dura.

## Trastorno esquizofreniforme

En resumidas cuentas, una esquizofrenia que todavía no ha alcanzado los 6 meses para su diagnóstico.

## Trastorno psicótico compartido (*folie a deux*)

Muy infrecuente. Se produce cuando se comparte un delirio entre dos personas, generalmente siendo una de ellas la inductora, que suele padecer un trastorno delirante crónico de elevada sistematización, y otra la receptora, dependiente, sugestionable o con cociente intelectual limitado. Para el tratamiento habrá que proceder a la separación de los afectados.

## 2.4. Antipsicóticos o neurolépticos

### ENFOQUE MIR

Suelen preguntarse efectos secundarios.

### Recuerda...

El DSM-5 también incluye el **trastorno esquizotípico de la personalidad** entre los trastornos psicóticos, aunque su descripción sigue encontrándose en el capítulo sobre trastornos de personalidad.

El mecanismo de acción fundamental de estos fármacos es el **bloqueo dopaminérgico** (concretamente, antagonismo del receptor de dopamina D2 postsináptico). El beneficio terapéutico es principalmente en los síntomas positivos (control agudo y de prevención de reaparición); no existe tratamiento farmacológico específico y único para la clínica negativa.

El propio bloqueo dopaminérgico es asimismo responsable de los principales **efectos secundarios**, entre los que destacan los **extrapiramidales** (disonía aguda, parkinsonismo, discinesia tardía y acatisia -también por otros mecanismos-).

Los antipsicóticos se dividen en típicos o de primera generación, y atípicos o de segunda generación. Como norma general (aunque no completamente cierto), todos se consideran igualmente efectivos y sus diferencias vendrán dadas principalmente por el perfil de tolerancia; en este sentido, se suelen considerar de **primera elección los atípicos o de segunda generación**.

Algunas características diferenciales son:

- Típicos o de primera generación: antagonistas potentes del receptor de dopamina y por tanto considerados incisivos para el control de síntomas positivos (por ejemplo, el haloperidol). Elevado riesgo de **efectos extrapiramidales** y empeoramiento de síntomas negativos (efectos cognitivos).
- Atípicos o de segunda generación: antagonismo dopaminérgico y modulación de otras vías aminérgicas (serotonina, noradrenalina). Mejor tolerancia por menor incidencia de efectos secundarios, especialmente los extrapiramidales. Como grupo, el efecto adverso más preocupante es la **alteración sobre el metabolismo y el aumento de peso (MIR 23, 93)**, que puede conllevar desarrollo de síndrome metabólico u otras patologías específicas y por tanto derivar a un mayor **riesgo de eventos cardiovasculares**.

La **clozapina** es un antipsicótico atípico que ha demostrado mejor eficacia global que el resto. Sin embargo, es un fármaco con elevada incidencia de efectos secundarios (no extrapiramidales), de los que preocupa fundamentalmente el riesgo de neutropenia y agranulocitosis (notificado de hasta 1%), lo que obliga a la monitorización linfocitaria (**MIR 22, 52; MIR 21, 84**).

Respecto a la farmacocinética general, presentan buena absorción oral y algunos de ellos también intramuscular (acción rápida para tratamiento de la agitación; acción lenta, de liberación prolongada, como mantenimiento); la absorción disminuye con antiácidos, café y té. Atraviesan la barrera hematoencefálica y el metabolismo es hepático (citocromo

### Regla mnemotécnica

La **O**lanzapina y el resto de antipsicóticos atípicos producen **O**besidad y síndrome metabólico.

La **C**lozapina produce **C**itopenia en la serie blanca (agranulocitosis).

**A**ripiprazol es el único antipsicótico **A**gonista dopaminérgico.

P450), con eliminación básicamente renal. Los inductores enzimáticos de P450 (como el tabaco o el alcohol), por tanto, disminuye sus niveles plasmáticos (**MIR 20, 90**).

|                                 | EFFECTO CLÍNICO                 | EFFECTOS SECUNDARIOS                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BLOQUEO DOPAMINÉRGICO D2</b> | Acción antipsicótica            | Efectos extrapiramidales<br>Hiperprolactinemia (galactorrea, amenorrea)                             |
| <b>ACCIÓN SEROTONINÉRGICA</b>   | Acción antipsicótica            | Somnolencia                                                                                         |
| <b>BLOQUEO HISTAMÍNICO</b>      |                                 | Somnolencia, aumento de apetito y peso                                                              |
| <b>BLOQUEO COLINÉRGICO</b>      | Reduce efectos extrapiramidales | Confusión, midriasis, sequedad de piel y mucosas, retención urinaria, estreñimiento, visión borrosa |
| <b>BLOQUEO NORADRENÉRGICO</b>   | Sedación                        | Hipotensión                                                                                         |

Tabla 4. Mecanismo de acción de antipsicóticos.

(Ver tabla 5)

## Indicaciones de los antipsicóticos

### Trastornos psicóticos

### Trastornos afectivos

- Depresión con delirios o agitación grave.
- Episodios maníacos.

### Otras indicaciones

- Síntomas psicóticos, agitación o agresividad en otros contextos (lesiones cerebrales orgánicas, demencias, drogas de abuso, fármacos...).

|                                                                         | APS TÍPICOS                                                                                                           |                                    | APS ATÍPICOS                                      |                                                                              |                                |                                                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | SEDATIVOS<br>O DE BAJA<br>POTENCIA                                                                                    | INCISIVOS<br>O DE ALTA<br>POTENCIA |                                                   |                                                                              |                                |                                                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                                       |
| FÁRMACO<br>TÍPICO                                                       | Clor-<br>promacina,<br>tioridacina<br>(retirado<br>en 2005)                                                           | Haloperidol                        | Clozapina                                         | Olanzapina                                                                   | Quetiapina                     | Risperidona                                                                                         | Ziprasidona                                                 | Amisulpride       | Aripiprazol                                                                                                                           |
| EFFECTO APS                                                             | Bloqueo D2                                                                                                            |                                    | Bloqueo D1, D2, D4 y serotoninérgico              |                                                                              |                                | Bloqueo D2 y<br>serotoninérgico                                                                     |                                                             | Bloqueo<br>D2, D3 | Agonista<br>parcial de<br>receptores<br>dopami-<br>nérgicos                                                                           |
| ACCIÓN                                                                  | Mejora síntomas positivos                                                                                             |                                    | Mejora síntomas positivos, negativos y cognitivos |                                                                              |                                |                                                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                                                       |
| SEP                                                                     | ++                                                                                                                    | ++++                               | Casi nulos                                        |                                                                              | Casi nulos                     | Pocos                                                                                               | Casi nulos                                                  |                   |                                                                                                                                       |
| SEDACIÓN                                                                | ++++                                                                                                                  | ++++                               | +++                                               | ++++                                                                         | +++                            | +++                                                                                                 | -                                                           | +                 | -                                                                                                                                     |
| OTROS<br>EFECTOS<br>SECUN-<br>DARIOS /<br>OTRAS<br>CARACTE-<br>RÍSTICAS | Hipotensión,<br>anticolinér-<br>gicos<br>Tioridacina:<br>retinitis<br>Clorpro-<br>macina:<br>alteraciones<br>cutáneas |                                    | Agranulo-<br>citosis<br>( <b>MIR</b> )            | Síndrome<br>metabólico<br>(↑ peso<br>y LDL,<br>resistencia<br>insulínica...) | De<br>elección en<br>Parkinson | El<br>antipsicótico<br>atípico con<br>más riesgo<br>de producir<br>efectos<br>extrapira-<br>midales | Necesario<br>control ECG,<br>por alarga-<br>miento<br>de QT |                   | Escasa<br>ganancia<br>ponderal.<br>Único<br>antipsicótico<br>con<br>mecanismo<br>de acción<br>agonista<br>dopaminér-<br>gico parcial. |

Tabla 5. Características de los antipsicóticos.

- Síndrome confusional agudo.
- Insomnio resistente.
- Hipo incoercible.
- Antiemético en quimioterapia.
- Coadyuvante en el tratamiento del dolor.
- Corea de Huntington.
- Gilles de la Tourette.

## Efectos secundarios de los antipsicóticos

### 1. Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)

#### ENFOQUE MIR

Aunque es un trastorno raro se pregunta muy a menudo en el MIR. Casi siempre como caso clínico: en un cuadro de fiebre alta, rigidez y alteración de conciencia de aparición brusca, donde se cite el uso previo de neurolépticos o litio, contestar diagnóstico de SNM.

Es una reacción idiosincrásica que se presenta en aproximadamente el 0,5% de los pacientes tratados con neurolépticos. La base patogénica es una disminución de la transmisión dopaminérgica, que afecta especialmente las vías nigroestriada e hipotalámica.

Es más frecuente cuando se usan antipsicóticos de alta potencia, especialmente haloperidol y flufenacina. Sin embargo, pueden causarlo otros productos –cualquier antipsicótico, litio, cocaína, benzamidas, antidepresivos tricíclicos, IMAO– o presentarse tras la supresión brusca de antiparkinsonianos (MIR).

Existe relación entre el SNM y la mayor potencia antidopaminérgica de un fármaco y la dosis empleada.

El SNM es más frecuente en varones y el riesgo aumenta en presencia de enfermedad cerebral orgánica, deshidratación, agotamiento físico y uso de neurolépticos de larga duración.

#### Clínica (MIR)

- **Hipertermia** con fiebre alta, hasta 41 °C.
- Hipertonía y **rigidez** muscular intensa.



- *Delirium*: alteración del **nivel de conciencia**, desde la confusión al coma.
- Alteraciones autonómicas: **taquicardia**, diaforesis, tensión arterial elevada o fluctuante.
- Disfagia.
- Incontinencia de esfínteres.
- Analítica: **leucocitosis** y elevación muy alta de **CPK**.

El SNM es más frecuente al inicio del tratamiento con neurolépticos durante el primer mes. Es un trastorno grave con **mortalidad del 10 a 20%**, sobre todo por fallo renal agudo por el aumento de CPK.

Recuerda que el **cerebelo** es un órgano especialmente sensible a la hipertermia (**MIR 14, 172**). De ahí que el **parkinsonismo** sea una secuela permanente relativamente frecuente del SNM.

### Regla mnemotécnica

El **Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)** se caracteriza por 3 cosas:

Superfiebre

Nivel de consciencia alterado

Afectación Muscular (rigidez, hipertonia, CPK)

### Tratamiento

- Suspensión inmediata de la medicación neuroléptica.
- Ingreso en UCI y medidas de soporte (suele ser necesaria la intubación y ventilación mecánica).
- Disminución de la temperatura corporal mediante anti-térmicos y medidas físicas.
- Sueroterapia (por la deshidratación; en caso de hipotensión la sueroterapia suele ser suficiente).
- La diálisis puede ser necesaria en presencia de insuficiencia renal grave.
- Medicación específica para casos graves: **dantrolene** (relajante muscular) o **bromocriptina** (agonista dopaminérgico).

## 2. Síntomas Extrapiramidales –SEP– (trastornos motores inducidos por neurolépticos)

### ENFOQUE MIR

Muy preguntados actualmente en el MIR, especialmente la **acatisia** y su tratamiento.

Todos se relacionan con las propiedades antidopaminérgicas de los fármacos (**MIR**). Aparecen resumidos en la tabla 6, únicamente comentar la **acatisia**, que se define como la

incapacidad para mantenerse quieto; con movimientos de piernas característicos (balanceo) que se alivian con la deambulación y empeoran con el reposo. Se asocia a inquietud psíquica y ansiedad. Es muy importante no confundir con la agitación psicótica (**MIR 18, 201; MIR**). Los antipsicóticos no son los únicos fármacos que pueden producir acatisia; también se ha relacionado con antidepresivos (principalmente por su acción serotoninérgica), antieméticos como la metoclopramida y los calcioantagonistas, por ejemplo.

El tratamiento se basa en la disminución de la dosis del neuroléptico o en la utilización de benzodiacepinas y/o betabloqueantes (**MIR 21, 87**).

|                 | AGUDOS                                                                                                                         | SUBAGUDOS                                                                                                                                                                                                 | TARDÍOS                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS | Distonía ( <b>MIR</b> )                                                                                                        | Parkinsonismo y acatisia                                                                                                                                                                                  | Discinesia                                                                                               |
| INICIO          | 1.ª semana                                                                                                                     | 3-4 meses                                                                                                                                                                                                 | Tras años de tratamiento                                                                                 |
| CLÍNICA         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisis oculógiras</li> <li>• Tortícolis</li> <li>• Riesgo espasmo laríngeo</li> </ul> | <b>Parkinsonismo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temblor</li> <li>• Discinesia</li> <li>• Rigidez</li> </ul> <b>Acatisia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquietud</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimientos bucolinguo-faciales</li> <li>• 15% grave</li> </ul> |
| F. RIESGO       | Jóvenes<br>varones<br>APS incisivos                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Mujeres,<br>ancianos<br>Deterioro del SNC previo<br>Síntomas afectivos<br>¿Tratamiento anticolinérgicos? |
| TRATAMIENTO     | Anti-colinérgicos (biperideno)                                                                                                 | <b>Parkinsonismo:</b><br>Anticolinérgicos amantadina<br><b>Acatisia:</b><br>beta-bloqueantes ( <b>MIR 21, 87</b> )<br>BZD                                                                                 | Malo (clozapina o deplecionantes de dopamina)                                                            |

Tabla 6. Efectos extrapiramidales de los antipsicóticos.

## Tema 3

# Trastornos del estado de ánimo

**Autores:** Rafael Baena Mures (10), Berta Pinilla Santos (21), Florencio García-Escribano Martín (21), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33).

### ENFOQUE MIR

Tema muy importante. Son muy frecuentes las preguntas de clínica y diagnóstico diferencial. Repetidísimas las de suicidio. Poco importantes las prevalencias.

El término **humor** se refiere al estado anímico dominante en un periodo largo: semanas o meses.

El término **afecto** se refiere al estado anímico presente en un momento concreto.

El término **emoción** es el componente somático del afecto. Se distinguen **dos grandes síndromes**, el depresivo y el maníaco, cuyas variaciones y combinaciones darán lugar a los diversos trastornos.

### 3.1. Síndrome depresivo

Este síndrome reúne una serie de síntomas que en mayor o menor grado son comunes a todos los trastornos de tipo depresivo.

Los síntomas han de estar presentes un periodo mínimo de **dos semanas**, ya que menos tiempo puede entrar en una tristeza normal (**MIR**).

Dos síntomas son imprescindibles para hablar de depresión y al menos uno de ellos ha de estar presente siempre que se use ese término: el estado de ánimo depresivo y/o la pérdida de interés o capacidad de sentir placer.

#### Depresión endógena vs. reactiva

Hace referencia a la distinción entre depresiones biológicas o endógenas y depresiones psicosociales o reactivas en función de su etiología. Las endógenas presentan mayor gravedad clínica, así como riesgo de suicidio; además, típicamente las depresiones endógenas tienen síntomas vegetativos, hiporexia, insomnio por despertar precoz y **mejoría vespertina** (es decir, el paciente mejora conforme progresa el día) (**MIR 23, 90**).

#### Depresión psicótica vs. neurótica

Esta distinción hace referencia a la gravedad clínica. En las primeras existe clínica psicótica con delirios (de culpa, ruina, enfermedad...) y alucinaciones (voces), y en la segunda se designan depresiones "ligeras", secundarias a trastornos de la personalidad u otro tipo de trastorno. Poco utilizada esta distinción en la actualidad.

#### Depresión unipolar vs. bipolar

Es una distinción meramente descriptiva, en los trastornos unipolares únicamente hay episodios depresivos sin que existan episodios de manía. La depresión bipolar tiene más riesgo de psicosis y suicidio que la unipolar.

#### Depresión primaria vs. secundaria

Primario se refiere a que aparece de forma independiente a un cuadro clínico afectivo, mientras que secundario se refiere a que aparece tras una alteración médica o psicológica. Mayor riesgo de suicidio en los trastornos primarios.

### Clínica (MIR)

#### Síntomas anímicos

- **Tristeza:** estado de ánimo bajo la mayor parte del día, sintiéndose vacío, desanimado, desesperanzado o bien con signos objetivos de tristeza, como llanto frecuente e inmotivado. En episodios graves, la tristeza puede dar paso a una "anestesia afectiva" con indiferencia hacia el entorno e incapacidad para implicarse emocionalmente en nada.
- **Irritabilidad:** más frecuente en niños o adolescentes.
- **Anhedonia:** incapacidad absoluta para experimentar placer, abandonando toda actividad en este sentido (**MIR**). Casi siempre incluye disminución de la libido y del interés sexual. La anhedonia se considera **equivalente al humor depresivo**. A estos cuadros clínicos donde la tristeza está aparentemente ausente, y que suelen consistir en sensaciones físicas de malestar (cansancio, apatía, fatiga, pérdida de interés, en ocasiones dolor...) se les ha denominado en ocasiones "depresión sin depresión" (*depressio sine depressione*) o "depresiones enmascaradas".

#### Síntomas somáticos

- Pérdida acusada de peso o apetito.
- Alteración del sueño: **insomnio** (lo más frecuente). En las depresiones más graves o melancólicas hay varios signos típicos, como despertar precoz y **empeoramiento matutino** del estado de ánimo, que mejora hacia la última hora de la tarde (**MIR**), coincidiendo con el ritmo circadiano de **cortisol**. La hipersomnia es mucho menos frecuente, formando parte de los síntomas atípicos.
- Fatiga o pérdida de energía diaria y persistente.
- Alteraciones sexuales.

De forma coherente con los síntomas somáticos, puede haber un aumento de quejas físicas, referidas a molestias, dolores y trastornos vagos e inconcretos:

- **Depresión con síntomas atípicos:** se caracteriza por una **reactividad** del estado de ánimo –es decir, que dentro de la tristeza el sujeto es capaz de alegrarse o entristecerse según los acontecimientos de su entorno–. Aparecen dentro de depresiones de baja intensidad en personas con rasgos previos de personalidad anómalos (dependiente, histriónico). Otros síntomas atípicos son:
  - Aumento de peso y apetito.
  - Hipersomnia.
  - Sensación de pesadez corporal.
  - Sensibilidad al rechazo social.

Tradicionalmente se ha descrito la eficacia de los antidepresivos **IMAO** en la depresión atípica, si bien su uso en general está muy limitado hoy en día dado sus efectos secundarios.

### Síntomas del pensamiento

- **Visión negativista** del presente, el pasado y el futuro.
- Pensamientos recurrentes de **muerte**, o ideas **suicidas**, sin planes específicos para suicidarse.
- **Ideas de inutilidad o de culpa excesivas**, que pueden ser incluso delirantes: el paciente puede creer que está arruinado, o que le han despedido del trabajo, o negar su propia capacidad de autocuidado.

Estos contenidos son en general **congruentes** con el estado de ánimo depresivo, y pueden extenderse al entorno: creer, por ejemplo, que se está en guerra o que hay una catástrofe nuclear o el fin del mundo (**MIR**).

- En los trastornos afectivos el **delirio** es **secundario** al trastorno del humor, son ideas deliroides que se explican como un grado máximo de exageración de las que provoca el propio trastorno del estado de ánimo (**MIR 13, 169**): de “encontrarse mal” puede llegar a “encontrarse muerto” (**MIR**).
- El grado máximo del delirio depresivo es el **síndrome de Cotard** o delirio nihilista, en que el paciente cree que carece de una o más partes del cuerpo, o que está muerto. Puede haber alucinaciones auditivas u olfativas coherentes con los delirios: oler a podrido, o escuchar voces que hablan de la muerte, etc. (**MIR**).
- Con menor frecuencia los delirios son **incongruentes** con el estado de ánimo, parecidos a los de la esquizofrenia o paranoia.
- Los síntomas psicóticos son más frecuentes en las fases depresivas del trastorno bipolar.

### Recuerda...

Las ideas delirantes **primarias** se dan característicamente en los trastornos psicóticos: esquizofrenia y paranoia.

Las ideas delirantes **secundarias** son consecuentes a trastornos afectivos (depresión psicótica o manía), a intoxicaciones o a disfunción cerebral orgánica (*delirium* o demencia).

### Síntomas conductuales

- Alteraciones en la concentración, atención y memoria.
- Alteración psicomotriz: agitación o enlentecimiento psicomotriz que puede llegar a una inhibición máxima, con catatonía, como en la esquizofrenia catatónica. El tratamiento de elección de la catatonía es la TEC.

### Clasificación

La duración y la intensidad del síndrome depresivo nos permite diferenciar unos trastornos de otros:

| TIPO DE SÍNTOMA                 | ALTERACIÓN                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síntomas anímicos</b>        | Tristeza<br>Irritabilidad<br>Anhedonia<br>Apatía                                                                    |
| <b>Síntomas somáticos</b>       | Peso y apetito<br>Sueño<br>Pérdida de energía<br>Quejas somáticas<br>Sexuales                                       |
| <b>Síntomas del pensamiento</b> | Visión negativista<br>Ideas de inutilidad y culpa<br>Depresión delirante<br>(presencia de delirios y alucinaciones) |
| <b>Síntomas conductuales</b>    | Concentración y atención<br>Memoria<br>Psicomotricidad<br>Descuido del aseo/<br>cuidado personal                    |

Tabla 1. Clínica del síndrome depresivo.

### Episodio depresivo mayor (según CIE 10) o trastorno depresivo mayor (según DSM-5)

(**MIR 24, 88; MIR 23, 89; MIR 14, 220; MIR 12, 158**)

Se requiere de una duración de al menos 2 semanas, de un mínimo de cinco síntomas depresivos, con una intensidad suficiente para producir un deterioro del funcionamiento global del paciente.



### Trastorno depresivo recurrente

Episodios depresivos de ritmo recurrente, normalmente de más de tres meses de duración, con recuperación entre ellos completa, sin síntomas residuales, separados por periodos libres de síntomas de al menos doce meses.

### Trastorno afectivo estacional

Episodios depresivos recurrentes característicamente en los meses de invierno en que hay menos horas de sol. Más frecuente en países del hemisferio norte. Responde a terapia lumínica y a antidepresivos.

### Distimia o trastorno distímico

Presencia de síntomas depresivos de **menor intensidad** que en la depresión mayor, durante un periodo continuo superior a **dos años**, en el que nunca se llega a una recuperación completa (MIR). Se trata de un humor crónicamente deprimido (o irritable en niños y adolescentes) (MIR). En niños y adolescentes la clínica debe estar presente durante al menos 1 año (MIR).

A menudo estos pacientes presentan, en el curso de la enfermedad, episodios depresivos mayores superpuestos, con agravamiento de sus síntomas habituales, lo que se conoce como “**depresiones dobles**” (MIR).

La distimia corresponde a la llamada “depresión neurótica” de la psiquiatría clásica. Se relaciona más con factores psicosociales y, en menor grado, endógenos, lo que la distingue del trastorno depresivo mayor (MIR).

|                | DISTIMIA O DEPRESIÓN NEURÓTICA              | TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR O DEPRESIÓN ENDÓGENA        |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ETIOLOGÍA      | Factores psicosociales y personalidad       | Factores hereditarios y constitucionales              |
| CURSO          | Continuo, fluctuante, sin remisión completa | Recurrente o fásico, si es parte de trastorno bipolar |
| RITMO          | Empeoramiento vespertino                    | Empeoramiento matutino                                |
| PSICOTERAPIA   | Eficaz                                      | Poco eficaz                                           |
| ANTIDEPRESIVOS | Menos eficaces                              | Más eficaces                                          |
| SUICIDIO       | Raro (MIR)                                  | Posible                                               |

Tabla 2. Características diferenciales entre la distimia y el trastorno depresivo mayor.

### Trastornos adaptativos (MIR 15, 152; MIR 11, 144)

Los trastornos adaptativos se definen como el desarrollo de síntomas emocionales y/o comportamentales en respuesta a un factor psicosocial identificable. Los síntomas más habituales de los trastornos adaptativos son los síntomas **ansiosos** y los **depresivos** de carácter leve.

El **estrés como etiología** es fundamental para su diagnóstico, cosa que les diferencia de casi todo el resto de trastornos psiquiátricos (formando parte del capítulo de Trastornos relacionados con el estrés, como el TEPT, según la clasificación DSM 5) en los que el estrés actúa únicamente como desencadenante.

Sólo pueden diagnosticarse si el cuadro no cumple los criterios de otro trastorno específico, como una depresión mayor o un trastorno de ansiedad.

### Epidemiología

En población general la prevalencia es:

- 2-3% hombres.
- 5-9% mujeres.

El 8% de los pacientes atendidos en atención primaria podría recibir un diagnóstico de depresión mayor. Aproximadamente el 15% de la población sufre un episodio depresivo mayor a lo largo de la vida, y hasta un 15% de ellos son secundarios a una enfermedad médica somática o al abuso de sustancias. Sin tratamiento, el 15% de los pacientes con depresión mayor comete suicidio (MIR).

Globalmente, la depresión es más frecuente en estratos económicos bajos, en separados, viudos y solteros, y en mujeres casadas; sin embargo, centrándonos únicamente en el trastorno depresivo mayor, no hay diferencias.

### Trastorno depresivo mayor

#### Etiología

- Tres veces más frecuente en familiares de primer grado de enfermos. Se suponen por tanto causas genéticas. Los familiares de primer grado tienen mayor riesgo de alcoholismo y de trastornos de ansiedad.
- Existen alteraciones de **neurotransmisores**: disminución de la actividad de serotonina y de la noradrenalina, de la dopamina, acetilcolina y GABA.
- Alteraciones **neuroendocrinas**: aumento de la secreción de cortisol y respuesta baja o nula al test de supresión con dexametasona (MIR).
- Niveles bajos de hormona del crecimiento y de TSH.
- **Neuroimagen**: aumento de flujo en regiones límbicas y disminución en córtex prefrontal.
- **EEG** del sueño: aumento de la latencia del sueño. Disminución de la latencia REM. Aumento de la duración y la actividad de las fases REM. Reducción del sueño NO-REM (fases 3 y 4).

En resumen, el sueño es más superficial, con pocas fases profundas y mucha actividad REM: habrá ensueños, pesadillas y sensación de no haber descansado.

- Los factores psicosociales (acontecimientos estresantes, entorno hostil) pueden actuar como precipitantes o mantenedores del trastorno.

Al igual que ocurre en muchos trastornos psiquiátricos, las enfermedades médicas y los fármacos pueden causar cuadros de depresión (**depresión secundaria**). Destacamos las siguientes:

| ENFERMEDADES QUE CURSAN CON DEPRESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FÁRMACOS CAUSANTES DE DEPRESIÓN (MIR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplasias, especialmente la de páncreas.</li> <li>• Ictus en hemisferio izquierdo.</li> <li>• Demencias en fases iniciales, especialmente la vascular.</li> <li>• Enfermedad de Parkinson.</li> <li>• Esclerosis múltiple.</li> <li>• Hidrocefalia normotensiva.</li> <li>• Enfermedades reumáticas.</li> <li>• Enfermedades de causa autoinmune.</li> <li>• Hipotiroidismo, y menos frecuente, hipertiroidismo.</li> <li>• Diabetes.</li> <li>• Enfermedad de Cushing.</li> <li>• Infecciones, especialmente víricas.</li> <li>• SIDA.</li> <li>• TBC.</li> <li>• Mononucleosis infecciosa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corticoides (MIR).</li> <li>• ANTI (MIR):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anticonceptivos orales.</li> <li>- AntiHTA: <math>\alpha</math>-MetilDopa.</li> <li>- <math>\alpha</math> y <math>\beta</math>-bloqueantes.</li> <li>- Antiparkinson: L-Dopa.</li> <li>- Antineoplásicos.</li> </ul> </li> <li>• Indometacina y AINE (MIR).</li> <li>• Procainamida.</li> </ul> |

Tabla 3. Etiología de depresión secundaria (MIR 22, 99).

### Curso

La edad promedio de inicio es la tercera década de la vida, pero puede presentarse a cualquier otra.

Es muy **recurrente**: al menos un 60% de los pacientes tendrán más de un episodio. Cuantos más presenten, mayor posibilidad de recurrencia existirá.

Los síntomas pueden remitir por completo o pueden dar lugar a una distimia.

La duración del episodio es larga.

El trastorno depresivo mayor tiene una **mortalidad** por suicidio del 15%. Asimismo, un 15% de las depresiones mayores se acompañan de síntomas psicóticos (depresiones psicóticas o delirantes).

El trastorno depresivo mayor aumenta significativamente la morbilidad y mortalidad médica en mayores de 55 años, probablemente mediante un efecto de inmunodepresión.

### Tratamiento

- **Antidepresivos** (MIR 23, 88; MIR 19, 188; MIR 11, 147) (tricíclicos, IMAO, ISRS): en el tratamiento con antidepresivos han de tenerse en cuenta dos factores: el primero es que la acción antidepresiva tarda en alcanzarse entre **4-6 semanas**; en segundo lugar, debe mantenerse el tratamiento, una vez alcanzada la respuesta, un mínimo de **6-12 meses** en todos los casos; si no se hace así, el riesgo de recaída es muy alto (MIR).
- **Tratamientos psicoterapéuticos**: terapia cognitiva-conductual, familiar (en niños y adolescentes), psicodinámica, TIP (Terapia Interpersonal de la Depresión). Muy utilizada es la psicoterapia de apoyo en la que se ayuda al paciente y familia a adaptarse a la enfermedad y al medio, explicando el carácter transitorio del problema y no dejando que se deje llevar de su estado de ánimo actual para tomar decisiones de las que podría arrepentirse después (vender una casa, retirarse a vivir a un geriátrico, solicitar una invalidez total, etc.) (MIR).
- **El ingreso hospitalario** se efectúa cuando hay riesgo de suicidio, síntomas psicóticos graves o inhibición psicomotriz intensa (catatonia).
- **Antipsicóticos**: asociados al uso de antidepresivos en el caso de las depresiones delirantes.
- **Terapia Electro Convulsiva (TEC)**: se usa en los cuadros catatónicos, en depresiones resistentes, cuando los síntomas psicóticos son graves (MIR), y puede ser la indicación en gestantes con depresión muy grave en las que no puedan usarse antidepresivos.
- **Estimulación magnética transcraneal (EMT)**: indicado en casos de depresión resistente de carácter leve o moderado (no graves, ni urgentes).

(Ver figura 1)

### 3.2. Suicidio

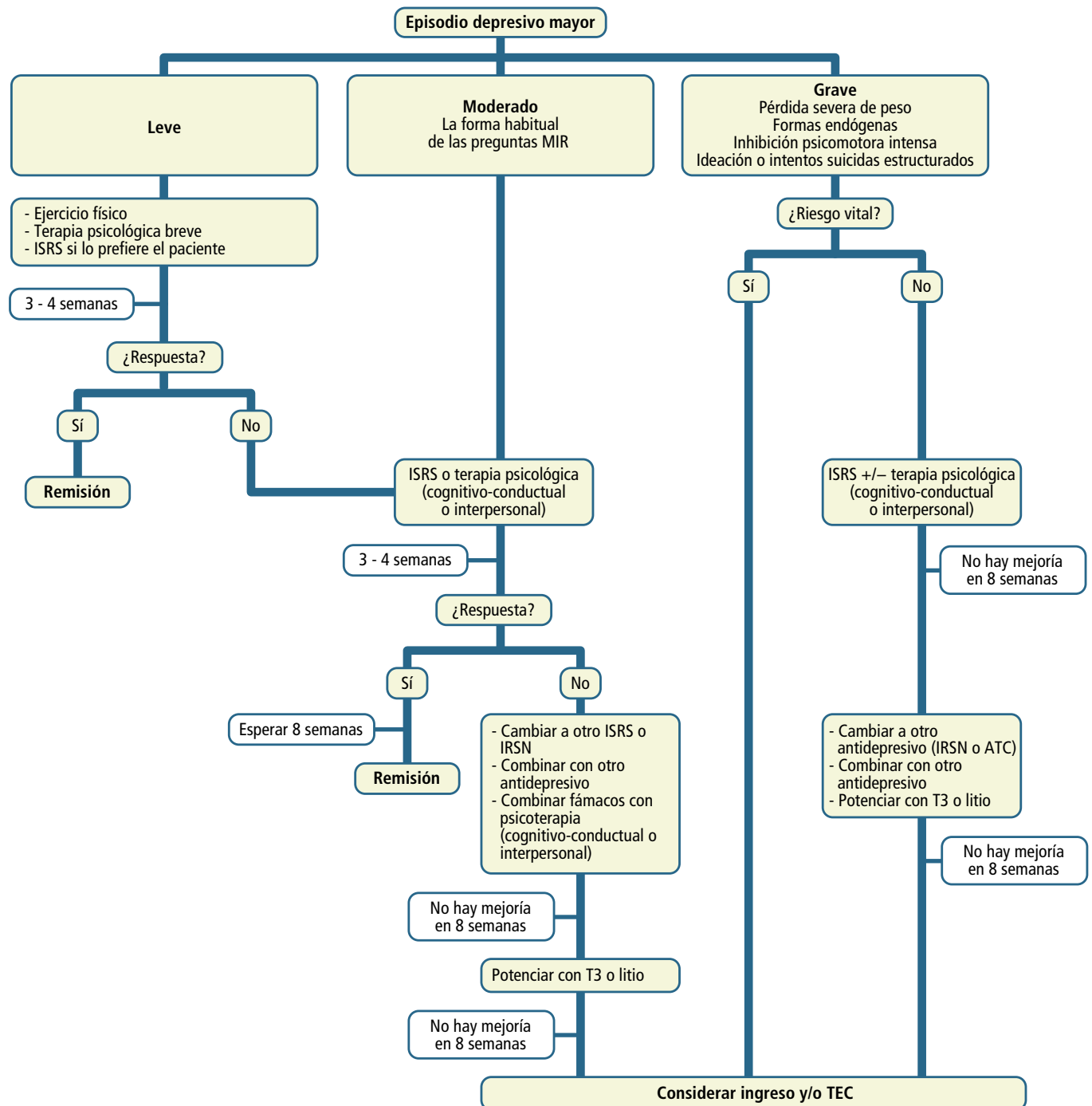
#### Recuerda...

La religión es un factor protector.

Constituye la **principal causa de muerte en psiquiatría**.

Enfermedades asociadas:

- En el 80% de los suicidios hay diagnóstico de trastorno mental (ordenados de mayor a menor frecuencia):
  - Depresión con síntomas psicóticos: el más frecuente, muy a menudo formando parte de un trastorno bipolar (MIR).
  - Comorbilidad con alcoholismo (15%).
  - Esquizofrenia ( $\approx$  5%; las cifras de prevalencia varían según el estudio) (MIR 11, 143): los factores de riesgo de suicidio en la esquizofrenia son en general similares a los de la población general (hombre, soltero, desem-



ISRS: inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina; IRSN: inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina; ATC: antidepresivo tricíclico; TEC: terapia electroconvulsiva.

Figura 1. Tratamiento del episodio depresivo mayor.

pleado, con historia personal y familiar de tentativas suicidas), pero existen diferencias respecto a la edad (el suicidio es más frecuente durante los primeros años de enfermedad). Otros factores como los síntomas positivos, los síntomas depresivos, la buena conciencia de enfermedad y un alto nivel educativo e intelectual aumentan el riesgo de suicidio (el prototipo clásico es el de un varón joven con un buen nivel de inteligencia previo que padece un primer episodio psicótico y a continuación un cuadro depresivo post-psicótico con una conciencia exagerada del deterioro que la enfer-

medad conlleva). Los síntomas negativos disminuyen el riesgo de suicidio.

- Anorexia nerviosa (6%).
- Trastornos de personalidad: antisociales y límite (5%).

Existe mayor riesgo al comienzo de la enfermedad y existencia de una sintomatología depresiva (depresión pospsicótica).

Los trastornos de ansiedad, aunque por sí mismos no tienen elevado riesgo suicida, a menudo se encuentran

asociados a otros trastornos (depresivos, consumo de sustancias...) que potencian la tendencia suicida (MIR 22, 96).

Los **gestos autolíticos** son actos autolesivos sin una verdadera intencionalidad suicida. Son frecuentes y en la gran mayoría de ocasiones se producen en pacientes con trastornos de personalidad en situaciones de estrés, básicamente en el área de las relaciones personales. Suelen emplear medios poco letales (ingesta de medicamentos, cortes en antebrazos) y hacerlo en circunstancias que aseguran la probabilidad de rescate por familiares. Las heridas de tanteo o de vacilación son heridas autoinflingidas, superficiales y paralelas entre sí, y en ocasiones también pueden encontrarse próximas a la herida más profunda y mortal en suicidios consumados (MIR 22, 190). A menudo el propósito es, mucho antes que el suicidio, el **manipular** situaciones de conflictos personales. A veces estos gestos pueden sin embargo darse en pacientes con enfermedades psiquiátricas graves. Por ello es muy importante valorar el **riesgo suicida** (MIR).

El 75% de los suicidas habla previamente de estas ideas, con lo cual, preguntar por ellas y detectarlas, puede ser útil para evitar el suicidio (MIR). Además, preguntar sobre las ideas suicidas no aumenta el riesgo de suicidio (MIR 13, 172).

#### FACTORES DE RIESGO SUICIDA

- Sexo masculino (en las mujeres, más intentos de suicidio; en los hombres, más suicidios consumados) (MIR).
- Edad avanzada (>65 años) (MIR); en adolescentes es la 3.<sup>a</sup> causa de muerte.
- Presencia de enfermedad física crónica, dolorosa o incapacitante.
- Desempleo.
- Viudedad, separación, divorcio.
- Presencia de síntomas psicóticos (depresión delirante) (MIR).
- Aislamiento social. Medio rural.
- Medios de alta letalidad: precipitación, ahorcamiento, etc.
- Falta de medidas de autorrescate.
- Otros: abuso de alcohol, nivel sociocultural alto, raza blanca, antecedentes familiares...

Tabla 4. Factores de riesgo suicida (MIR).

#### Regla mnemotécnica

**Orden de frecuencia (de mayor o menor) de riesgo de suicidio según patologías psiquiátricas**

**DESI** fue a **ALCOH**ete ya que **Estuvo** **Antes** **Al** **LÍMITE** del suicidio (Alcohete es un hospital psiquiátrico de Guadalajara)

**DE**presión pSclótica

**ALCOH**olismo

**ES**quizofrenia

**Anorexia** **Nerviosa**

Trastorno **Antisocial** de personalidad

Trastorno **LÍMITE** de personalidad

## Tratamiento

Lógicamente es el del trastorno concomitante. El riesgo suicida elevado es causa de ingreso hospitalario que puede hacerse incluso en contra de la voluntad del paciente (MIR).

Se usan ansiolíticos y antidepresivos.

La TEC está indicada en depresiones graves con alto riesgo suicida.

### 3.3. Síndrome maníaco

Los episodios maníacos forman parte del trastorno bipolar. Según el DSM-5, un paciente con un único episodio maníaco, aunque no haya presentado ninguno depresivo, puede ser diagnosticado ya de trastorno bipolar.

La manía es como un reverso extremo de la depresión.

#### Clínica (MIR)

El síntoma nuclear de la manía es el humor eufórico o irritable de más de una semana de duración, o de menos si es necesaria la hospitalización.

En este humor se observan:

- Autoestima exagerada o **grandiosidad**: el paciente se ve capaz de cualquier cosa, emprendiendo múltiples proyectos, o siente que su potencial se ha desarrollado extraordinariamente.
  - **Disminución** de la necesidad de **sueño** (MIR), con insomnio casi completo.
  - **Verborrea**, con habla exageradamente rápida, que puede llegar a perder el hilo.
  - **"Fuga de ideas"** o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado (MIR).
  - **Distraibilidad**, dificultad para mantener la atención sin dispersarse hacia estímulos irrelevantes: al acelerarse el ritmo del pensamiento, el paciente "no sabe hacia dónde atender" (MIR).
  - **Aumento** de la **actividad** intencionada –social, laboral o en estudios– o agitación psicomotriz.
  - Implicación excesiva en actividades placenteras que tiene un alto potencial de riesgo: compras irrefrenables y a menudo absurdas, promiscuidad sexual (hay aumento de libido), inversiones económicas alocadas. Al sentirse incapaz de equivocarse, el paciente puede dedicar todos sus recursos o endeudarse de forma totalmente irreflexiva.
  - Los **síntomas psicóticos** son mucho más frecuentes que en la depresión: ideas delirantes de grandeza (tener, p. ej., la solución de los problemas mundiales, o conocer la curación de enfermedades, etc.), de identidad (ser un personaje importante, un líder, alguien designado por el cielo) o bien ser incongruentes con el estado de ánimo, con contenidos de persecución o perjuicio, parecidos a los de la esquizofrenia y menos elaborados que en la paranoia.
- Puede haber alucinaciones auditivas como en esquizofrenia (MIR).

- Puede haber una **labilidad afectiva** con cambios bruscos y continuos de estado de ánimo, superficiales y vacíos: pasar de reír a llorar.
- En la manía hay casi siempre **ausencia de conciencia de enfermedad**: lejos de admitir estar enfermo, el paciente se encuentra “mejor que nunca”.
- En la inmensa mayoría de los casos el tratamiento del episodio maníaco requiere hospitalización.
- Los síntomas maníacos pueden aparecer, además de en el curso de un trastorno bipolar, inducidos por sustancias de abuso o por fármacos, o bien ser secundarios a enfermedades médicas. La aparición muy brusca de un episodio maníaco intenso sin antecedentes de trastorno del humor obliga a descartar causa tóxica. Si se produce bruscamente en un paciente de edad superior a 45 años sin antecedentes afectivos, hay que descartar causa médica (MIR).

| CAUSAS DE MANÍA SIN TRASTORNO BIPOLAR |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fármacos                              | Esteroides (MIR)<br>Isoniácida<br>Antiparkinsonianos<br>Anticolinérgicos<br>Agonistas dopaminérgicos                                 |
| Tóxicos                               | Cocaína<br>Anfetaminas y otros estimulantes                                                                                          |
| Enfermedades neurológicas             | Demencias, especialmente frontotemporal (Pick)<br>Neurosífilis<br>Encefalitis<br>ACV de localización frontal o en hemisferio derecho |
| Enfermedades endocrinológicas         | Hipertiroidismo<br>Tumores carcinoides                                                                                               |
| Otras enfermedades                    | Uremia y síndromes postdialíticos<br>Déficit B <sub>12</sub>                                                                         |

Tabla 5. Causas de manía sin trastorno bipolar.

## Clasificación

### Episodio hipomaniaco (MIR 16, 223)

Episodio de exaltación anímica similar a la manía pero de menor intensidad y duración (MIR 21, 86). Tiene que tener una duración mínima de 4 días. Habitualmente no es tan grave como para requerir hospitalización.

### Episodio mixto

Se inscribe en el curso del trastorno bipolar. Se refiere a pacientes que cumplen simultáneamente los criterios diagnósticos de episodio maníaco y depresivo, pues sus cambios de estado de ánimo son intensos y rápidos.

Combinaciones como, por ejemplo, irritabilidad, inquietud motriz, verborrea e ideas de muerte, son posibles. Es poco frecuente.

### Ciclotimia

Periodos prolongados (más de 2 años) de humor depresivo de escasa intensidad que alternan con otros caracterizados por humor exaltado, sin llegar a presentar tampoco criterios de manía (MIR). El fenómeno central es la inestabilidad del estado de ánimo y la levedad de los síntomas. Suele comenzar en la edad adulta.

## Tratamiento

Dado que el episodio maníaco suele transcurrir dentro de un diagnóstico previo de trastorno bipolar (excepto si es el primer episodio), el ajuste de los fármacos **estabilizadores del humor** (aumentar la dosis) es lo principal. El episodio maníaco no deja de ser una entidad de características y sintomatología **delirante**, por lo tanto, se deben añadir **antipsicóticos** (MIR 18, 202) al tratamiento, teniendo en cuenta los efectos secundarios, las características y los criterios de elección de este grupo de la misma manera que en otros trastornos (como la esquizofrenia).

Si repasamos los síntomas típicos de la manía, es lógico pensar que los **antidepresivos** están **contraindicados** durante el tratamiento de la fase maníaca (MIR 14, 221; MIR).

En episodios maníacos graves, con síntomas psicóticos y gran agitación psicomotora, con resistencia al tratamiento habitual, puede estar indicada la TEC (MIR 22, 97).

| EUTIMIZANTES   | Litio<br>Ácido valproico                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTIPSICÓTICOS | Clorpromazina<br>Aripiprazol<br>Olanzapina<br>Quetiapina<br>Risperidona<br>Ziprasidona |

Tabla 6. Tratamiento farmacológico de la manía (fármacos aprobados por la FDA).

## 3.4. Trastorno bipolar (MIR 17, 190)

### Recuerda...

El DSM-5 describe en dos capítulos separados los trastornos depresivos y el trastorno bipolar, aunque para su mejor comprensión los vamos a explicar juntos.

Este trastorno, llamado clásicamente **psicosis maníaco-depresiva**, se da cuando en un enfermo se suceden uno o más episodios depresivos que alternan con episodios maníacos.



Habitualmente, entre ambos el paciente llega a recuperarse por completo. No existe un ritmo regular en la presentación de nuevos episodios.

El **DSM** establece dos tipos de trastorno bipolar:

- Trastorno bipolar I: los criterios del **DSM** solo exigen la presencia de un episodio maníaco, aun sin que haya habido nunca depresión. Es decir, que la manía no es en sí misma una enfermedad como es la depresión, sino que siempre forma parte de un trastorno bipolar. Por otro lado, los criterios de la **CIE** exigen que para establecer este diagnóstico hayan existido dos tipos de episodios, al menos uno maníaco y otro depresivo.
- Trastorno bipolar II: tanto el DSM como la CIE coinciden en que para diagnosticar este trastorno deben estar presentes episodios depresivos y al menos un episodio hipomaníaco.

Ambos pueden seguir algunas variantes de ritmo que cabe destacar:

- Patrón estacional: recaídas cíclicas en primavera u otoño.
- Inicio en el posparto: es frecuente que el trastorno bipolar se inicie en mujeres durante el puerperio, bien con un episodio maníaco o uno depresivo. Son más frecuentes en primíparas.
- Ciclación rápida: pacientes que presentan cuatro o más episodios de manía o depresión en un año. Supone un 5-15% del total de pacientes con trastorno bipolar. Responden mejor a carbamacepina (**MIR**) y peor a litio (**MIR**).

Existen otros tipos de trastorno bipolar aún en estudio, el trastorno bipolar III, en el que se asocia la depresión con manía/hipomanía farmacógena; el trastorno bipolar IV, donde se incluiría la ciclotimia; y el tipo V, caracterizado por la asociación de depresión con antecedentes familiares de trastorno bipolar.

## Epidemiología

La prevalencia del trastorno bipolar tipo I es del 0,5-1,5% en la población general, sin que existan diferencias en cuanto al sexo. Los episodios maniacos son más frecuentes en varones. La prevalencia del trastorno bipolar tipo II es algo menor (del 0,5%) y es más frecuente en mujeres (**MIR 10, 147**).

El puerperio es siempre una situación de riesgo de recaída.

(Ver tabla 7)

## Curso

Crónico y recurrente. El 90% de los pacientes presentan recaídas. El intervalo entre los episodios tiende a disminuir con la edad. Aunque clásicamente se afirmaba que los intervalos entre episodios son asintomáticos, un 30% de pacientes tiene labilidad afectiva y problemas interpersonales entre episodios.

| INFANCIA<br>(PORCENTAJE APROXIMADO)                                   | EDAD ADULTA<br>(PORCENTAJE APROXIMADO)                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. TDAH (87%).                                                        | 1. Trastornos de ansiedad (75%), principalmente el trastorno de pánico y la agorafobia.        |
| 2. Trastornos de conducta / trastorno oposicionista desafiante (80%). | 2. Trastorno por consumo de sustancias (60%):<br>- Alcohol (49%).<br>- Otras sustancias (41%). |
| 3. Trastornos de ansiedad (55%).                                      | 3. Trastornos de personalidad (36%), principalmente el trastorno límite de la personalidad.    |

Tabla 7. Comorbilidades en el trastorno bipolar (**MIR 19, 185; MIR 10, 235**). La presencia de comorbilidades es un hecho frecuente (coexistencia con otro trastorno mental en hasta 2/3 de casos).

## Edad de inicio

Puede iniciarse a cualquier edad, aunque la media está entre los 20 y 30 años.

Presentan alto riesgo de suicidio.

## Etiología

- Genética: la herencia no es mendeliana, sino **poligénica** (**MIR 11, 142**) (como en la mayoría de trastornos psiquiátricos).

El trastorno bipolar es el trastorno psiquiátrico con mayor agregación familiar (**MIR**). Hasta un 50% de enfermos tiene al menos un familiar de primer grado con un trastorno psiquiátrico grave. La concordancia en gemelos monocigóticos es mayor en el trastorno bipolar (40-90%) que en la depresión (>50%).

- Alteraciones neuroquímicas.
  - Dopamina: disminuida en depresión y aumentada en manía.
  - Serotonina: alteraciones en transmisión y receptores.
  - Noradrenalina: alteraciones en transmisión y receptores.

## Tratamiento (**MIR 17, 188**)

El tratamiento fundamental son los **estabilizantes del estado de ánimo** (normotímicos o eutimizantes) (**MIR 23, 87**): sales de litio (**MIR**), valproato, carbamacepina, lamotrigina (para prevención y tratamiento de la fase depresiva del trastorno bipolar) y otros anticomiciales. Su uso es habitualmente crónico, planteándolos como un tratamiento continuado de por vida. En una mujer embarazada podrían utilizarse antipsicóticos de segunda generación, que han demostrado ser estabilizadores del estado de ánimo. El ácido valproico y el litio estarían contraindicados ante el riesgo de teratogenicidad (**MIR 23, 53**).

En episodios depresivos graves se usan **antidepresivos**, siempre combinados con estabilizadores del humor y bajo vigilancia por el riesgo de viraje a manía.

En los episodios maníacos se usan **antipsicóticos** con buena respuesta (MIR). Estando contraindicado el uso de antidepresivos (MIR).

Se utilizan hipnóticos y ansiolíticos sólo como coadyuvantes y en periodos cortos.

### 3.5. Otros trastornos del estado de ánimo

#### Trastorno disfórico premenstrual

Trastorno caracterizado por la presencia de al menos 5 síntomas depresivos (labilidad emocional, irritabilidad, tristeza, síntomas físicos y pérdida de concentración) que aparecen durante la última semana antes de la menstruación y desaparecen una semana después de terminar ésta. Este síndrome se estudia con más detalle en el **manual de Ginecología y Obstetricia, tema 33. Síndrome premenstrual**.

#### Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo

Consiste en accesos de cólera graves y desproporcionados, con una frecuencia de 3 o más por semana, y un ánimo persistentemente irascible e irritable. Su inicio ha de ser entre los 6 y los 18 años.

#### Duelo

El duelo es la reacción emocional derivada de la pérdida, fundamentalmente de un ser querido. Se trata de un problema de salud no atribuible a trastorno mental, es decir, una reacción considerada normal, un proceso y vivencia necesarias para hacer frente a la nueva situación. Por este motivo, no existe indicación de tratamiento farmacológico con antidepresivos. Se valorará el acompañamiento psicológico del proceso de duelo o, si fuera preciso, un tratamiento sintomático y temporal.

Los casos de **duelo patológico** se engloban dentro de los trastornos de adaptación (experiencias alucinatorias mantenidas, ideación suicida, alteraciones funcionales graves y prolongadas...); en estos casos está indicado tratamiento farmacológico (MIR 22, 94).

### 3.6. Tratamientos

#### Fármacos estabilizantes del estado de ánimo

Los principales fármacos estabilizadores del humor son:

1. Litio.
2. Carbamacepina.
3. Valproato o ácido valproico.

Los **niveles plasmáticos** (MIR 13, 166) de litio, valproato, carbamacepina se miden periódicamente para comprobar que el fármaco está en niveles terapéuticos, y para evitar efectos secundarios derivados de una posible sobredosificación.

### 1. Litio

#### ENFOQUE MIR

¡Ojo! Son frecuentes las preguntas sobre litio.

Las sales de litio son el estabilizante anímico más usado en Europa (MIR).

El litio es una sustancia extraña al organismo humano. La idea de que el trastorno bipolar proviene de una falta de litio en el organismo es un **error**.

#### Farmacocinética

- Absorción intestinal.
- Nivel plasmático máximo a los 60-90 minutos.
- Vida media 20 horas.
- Eliminación **renal** (MIR): no necesita pruebas de función hepática.
- Pasa la barrera placentaria y es excretado por leche materna.

#### Indicaciones

- Trastorno bipolar I y II.
- Se usa en el mantenimiento (evita en un 80% las recaídas en el trastorno bipolar tipo I) y ambas fases, aunque es más eficaz como antimaníaco que como antidepresivo (MIR).  
Tiene un periodo de latencia de 7-10 días, por lo que al principio del tratamiento de un episodio maníaco se asocia a neurolepticos (MIR).
- Trastornos depresivos recurrentes resistentes a terapia con antidepresivos, en combinación con éstos.

#### Niveles terapéuticos

El litio tiene ventana terapéutica estrecha (MIR 21, 83): para el mantenimiento en el trastorno bipolar debe mantener niveles entre 0,6-1,2 mEq/l (MIR). Niveles inferiores son clínicamente ineficaces y niveles superiores son tóxicos.

Hay que monitorizar los niveles de litio, con análisis regulares (MIR).

#### Dosificación

Habitualmente entre 800-1200 mg/día (MIR).



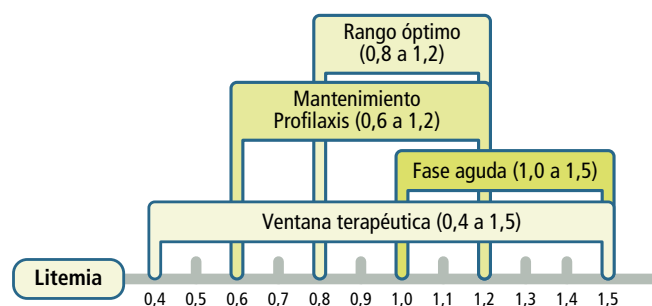


Figura 2. Niveles de litio.

| AUMENTAN NIVELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DISMINUYEN NIVELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diuréticos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiazídicos (<b>MIR</b>).</li> <li>- De ASA.</li> <li>- Ahorradores de potasio.</li> </ul> </li> <li>• AINE excepto aspirina (<b>MIR</b>) y paracetamol.</li> <li>• IECAS y ARAII.</li> <li>• ATB:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metronidazol.</li> <li>- Tetraciclinas.</li> </ul> </li> <li>• Dietas hiposódicas (<b>MIR</b>).</li> <li>• Carbamacepina.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diuréticos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osmóticos: manitol.</li> <li>- Inhibidores de la anhidrasa carbónica: acetazolamida.</li> </ul> </li> <li>• Xantinas: teofilina y cafeína.</li> <li>• Cloruro sódico.</li> <li>• Bicarbonato sódico.</li> </ul> |

Tabla 8. Interacciones farmacológicas del litio.

### Efectos secundarios y su tratamiento (**MIR**)

Los más frecuentes: alteraciones **gastrointestinales** y **temblor**.

- Alteraciones gastrointestinales: diarrea, sabor metálico, náuseas, anorexia, vómitos. Como opciones terapéuticas, se puede reducir dosis o darlo con alimentos.
- Neurológicas: **temblor fino distal** (**MIR 12, 161**) 8-10 ciclos/s. El tratamiento consiste en disminuir dosis, o tratar con propranolol o benzodiazepinas. El temblor debe hacer sospechar intoxicación.
- Renales:
  - Poliuria y polidipsia (diabetes insípida nefrogénica): debemos disminuir la dosis de litio y reponer líquidos o añadir amiloride reduciendo la dosis de litio a la mitad.
  - Glomerulonefritis y/o nefritis intersticial.
- Endocrinas: puede producir hipotiroidismo, aunque no implica la retirada del fármaco, únicamente es necesario el control de las hormonas tiroideas y tratamiento sustitutivo si precisa (**MIR 15, 150; MIR**).
- Teratígeno: puede provocar anomalía de Ebstein (implantación baja de la válvula tricúspide, con ventrículo derecho pequeño y aurícula derecha grande).
- Otros:
  - Trastornos cardiacos: alteraciones en la conducción y el ritmo.
  - Acné: no necesita retirada de litio. Se emplean tratamientos tópicos (eritromicina).

- Psoriasis.
- Alopecia areata.
- Aumento de peso.
- Edemas: se debe reducir la dosis. Si son graves, podemos añadir espironolactona además de reducir la dosis de litio y controlar los niveles.
- Debilidad muscular y fasciculaciones: desaparecen progresivamente sin que sea necesario tratamiento.

Es necesario **retirar** el fármaco si aparece:

- Psoriasis.
- Nefritis intersticial.
- Alteraciones del ritmo cardiaco.

### ALTERACIONES ANALÍTICAS EN EL TRATAMIENTO CON LITIO

|                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiperglucemia<br>Leucocitosis<br>Hipercalcemia<br>Aumento de hormonas paratiroides<br>Aumento de magnesio | Hipopotasemia<br>Hipofosfatemia<br>Disminución de tiroxina<br>Disminución de cortisol<br>Disminución de ácido úrico |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 9. Alteraciones analíticas en el tratamiento con litio.

### Contraindicaciones

| ABSOLUTAS                                                          | RELATIVAS                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Insuficiencia renal grave ( <b>MIR</b> )<br>Nefropatía<br>Embarazo | Miastenia gravis<br>Leucemia<br>Disfunción del nodo sinusal |

Tabla 10. Contraindicaciones para el uso de litio.

### Precauciones de uso

- El litio aumenta la excreción renal de sodio: ello hace importante el advertir que mientras se lleve tratamiento con litio, no se disminuirá la ingesta de sal.
- Evitar el uso de diuréticos (**MIR**).
- Evitar la sudación excesiva (**MIR**).
- Antes de usar litio, realizar estudio de ECG, analítica con hormonas tiroideas, test de gestación.
- Periódicamente hay que realizar determinaciones de niveles plasmáticos, de función renal, hormonas tiroideas, hemograma, analítica urinaria y ECG (**MIR**).

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangre: hemograma, glucemia, uremia, creatinina, colesterol, triglicéridos, GOT, GPT, fosfatasa alcalina, ionograma, TSH, T3.</li> <li>2. Test de embarazo.</li> <li>3. Análisis de orina: proteinuria, aclaramiento de creatinina.</li> <li>4. ECG y EEG si antecedentes de cardiopatía o epilepsia.</li> </ol> |
| <b>DURANTE EL 1.º MES</b>              | Litemia semanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HASTA LOS 6 MESES</b>               | Litemia mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CADA 6 MESES</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangre: hemograma y bioquímica general.</li> <li>2. Litemia.</li> <li>3. Análisis de orina.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ANUAL</b>                           | TSH, T3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla 11. Controles en el tratamiento con litio.

### Intoxicación por litio

- Es un problema que puede ser causa de muerte en caso de alcanzar concentraciones superiores a 2,5 mEq/l.
- La causa más frecuente es la pérdida de sodio y agua (dieta, deshidratación, diuréticos, vómitos, fiebre...).
- Los primeros síntomas son temblor y diarrea, náuseas y vómitos. Si progresa habrá hiperreflexia, convulsiones, disminución del nivel de conciencia con coma y muerte por fracaso renal agudo.
- Tratamiento de la intoxicación (**MIR 17, 185**):
  - Medidas de soporte (mantenimiento de constantes vitales).
  - Hidratación intensa.
  - Lavado gástrico (si es por una sobredosis).
  - Diálisis en intoxicaciones graves o niveles superiores a 4 mEq/l (**MIR 20, 89**).

### 2. Carbamacepina

Es un anticonvulsivante usado también como eutimizante. Precisa monitorización de niveles plasmáticos (8-12 µg/ml). Es **tratamiento** de elección en cicladores rápidos (más de 4 episodios al año). Puede combinarse con litio, aunque vigilando niveles.

Es un inductor enzimático, por lo que tiene numerosas interacciones con otros fármacos.

Los **efectos secundarios** más importantes (y susceptibles de preguntarse) son:

- Agranulocitosis y leucopenia.
- Hiponatremia.
- Alteraciones gastrointestinales.

### 3. Valproato o ácido valproico

Sustancia anticonvulsivante que se usa como eutimizante. Precisa monitorización de niveles plasmáticos (50-100 µg/ml). Presenta **efectos idiosincrásicos** que pueden ser preguntados:

- Hepatopatía severa.
- Pancreatitis.
- Agranulocitosis.
- Trombopenia.
- Poliquistosis ovárica.
- Alopecia.
- **Teratogenia**: alteración del tubo neural.

### 4. Otros eutimizantes

- **Lamotrigina**: anticonvulsivante eficaz en la prevención y tratamiento de las **fases depresivas** del trastorno bipolar.
- **Clonazepam**: benzodiacepina utilizada como coadyuvante de los estabilizadores del humor. Principalmente utilizada para la fase maníaca y usada también en **cicladores rápidos**.
- **Antipsicóticos (MIR 24, 82)**: los únicos antipsicóticos indicados como estabilizadores del estado del ánimo son la olanzapina, la quetiapina y el aripiprazol.
- **Otros anticonvulsivantes de última generación** (gabapentina, topiramato), **verapamilo**, **clonidina**.

### Antidepresivos

#### ENFOQUE MIR

Preguntados con frecuencia, principalmente los ISRS, al ser los más usados en la práctica clínica. De éstos hay que saber los nombres de los principales principios activos.

Son fármacos usados en depresión y en otros trastornos psiquiátricos. Ejercen su acción en la sinapsis neuronal a nivel de diferentes áreas cerebrales, de forma que modifican la neurotransmisión.

Actúan fundamentalmente sobre dos sistemas de neurotransmisores:

- **Serotoninérgico**: aumentando su liberación o actuando sobre los mecanismos de degradación, a fin de aumentar la cantidad disponible, o modificando sus receptores.
- **Noradrenérgico**: mecanismo similar al anterior.
- En menor grado actúan sobre **otros neurotransmisores**, como Dopamina, Acetilcolina, Histamina, y sobre receptores pre y postsinápticos alfa y betaadrenérgicos.

Los antidepresivos ejercen su acción de forma lenta, de manera que la respuesta clínica se inicia aproximadamente entre dos y cuatro semanas después del inicio del tratamiento. No crean tolerancia ni dependencia.

La absorción es **oral**.

La metabolización hepática.

La eliminación es básicamente renal.

Tienen una alta liposolubilidad.

Atraviesan la barrera hematoencefálica y la placentaria.

Existen varios grupos de antidepresivos.

| IMAO                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tranilcipromina<br>Fenelcina<br>Moclobemida (reversible)                                   |
| ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS                                                                 |
| Imipramina<br>Desimipramina<br>Amitriptilina<br>Nortriptilina<br>Clomipramina              |
| ISRS                                                                                       |
| Paroxetina ( <b>MIR 16, 175</b> )<br>Fluoxetina<br>Citalopram<br>Sertralina<br>Fluvoxamina |
| INHIBIDORES DE RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y NORADRENALINA                                   |
| Venlafaxina<br>Duloxetina<br>Desvenlafaxina                                                |
| ISRN                                                                                       |
| Reboxetina                                                                                 |
| ANTIDEPRESIVOS ATÍPICOS                                                                    |
| Trazodona<br>Nefazodona<br>Mianserina<br>Mirtazapina<br>Bupropion                          |

Tabla 12. Clasificación de los antidepresivos.

### 1. Inhibidores de la MonoAminoOxidasa (IMAO)

La MAO es una enzima que ejerce su acción en el espacio sináptico. Su misión es degradar la serotonina y la noradrenalina. Los inhibidores bloquean esta función de manera irreversible, con lo que aumentan la disponibilidad de ambos neurotransmisores. Sin embargo, inactivan también la MAO hepática e intestinal (son **no selectivos**),

por lo que son fármacos con muchos efectos secundarios y problemas de manejo. En la práctica no son apenas usados.

Los más conocidos son:

- Tranilcipromina (**MIR**): es el único disponible en España.
- Fenelcina.
- Moclobemida: es el único comercializado en España. La inhibición de la moclobemida sobre la MAO es reversible, a diferencia de los IMAO clásicos. No interacciona con alcohol ni requiere limitaciones en la dieta.

| ALIMENTOS PROHIBIDOS EN TRATAMIENTOS CON IMAO                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bebidas alcohólicas, sobre todo vino y cerveza ( <b>MIR</b> )                                                     |                                                                              |
| Patés e hígado<br>Embutidos fermentados<br>Quesos fermentados<br>Habas                                            | Setas<br>Plátanos y aguacates<br>Arenques y caviar<br>Conservas y escabeches |
| FÁRMACOS INCOMPATIBLES CON IMAO                                                                                   |                                                                              |
| Antigripales<br>Descongestivos nasales<br>Antipiréticos<br>Anestésicos locales<br>Antidepresivos serotoninérgicos |                                                                              |

Tabla 13. Interacciones de los IMAO.

### Efectos secundarios

- **Crisis adrenérgica o crisis hipertensiva:** en un paciente tratado con IMAO, las aminas contenidas en determinados alimentos (tiramina) no pueden catabolizarse (**MIR**) y llegan puras a las terminaciones neuronales, causando una crisis adrenérgica por liberación masiva de noradrenalina y serotonina (**MIR**):
  - Taquicardia.
  - Arritmias.
  - Hipertensión.
  - Hipertermia.
  - Diaforesis.

Esta característica obliga a los pacientes tratados con IMAO a prohibir el consumo de determinados alimentos (en su mayoría curados o fermentados, pudiendo ingerir alimentos frescos).

**Otros efectos** son: hipotensión postural, insomnio, inquietud y disfunción sexual.

Para cambiar a otro grupo de antidepresivos desde un IMAO o bien al revés, cuando queremos introducir un IMAO como cambio de tratamiento antidepresivo, hay que pasar un periodo de **lavado**, libre de fármaco, de **2 a 5 semanas**.

## Indicaciones

- Depresión atípica.
- Son de segunda elección en TOC, trastornos depresivos y trastorno de angustia resistentes a otros tratamientos.

## Contraindicaciones

- Hepatopatía avanzada.
- Insuficiencia cardíaca.
- Hipertensión arterial.
- Diabetes.

## 2. Antidepresivos tricíclicos

Los principales son:

| PERFIL SEDANTE                                    | PERFIL ACTIVADOR                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Amitriptilina (MIR)<br>Clorimipramina<br>Doxepina | Imipramina<br>Desimipramina<br>Nortriptilina |

Tabla 14. Antidepresivos tricíclicos.

## Mecanismo de acción

Actúan en la sinapsis neuronal inhibiendo la recaptación de las monoaminas por la neurona presináptica (MIR). De este modo, aumenta la disponibilidad de las sustancias transmisoras en la sinapsis, lo que modifica a medio plazo los receptores postsinápticos.

Además, bloquean los receptores de muchos otros neurotransmisores, de ahí que al tiempo que son más eficaces tienen muchos más efectos secundarios. Éstos limitan bastante su uso práctico, por ejemplo, en pacientes ancianos (MIR 21, 85), que serán muy susceptibles de padecerlos (MIR).

| Regla mnemotécnica                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antidepresivos tricíclicos que se usan en ancianos<br><i>DESI Mir A al NORte</i><br><b>DESI</b> mipramina<br><b>MIA</b> nserina<br><b>NORT</b> riptilina |

## Efectos secundarios

- **Anticolinérgicos.** Los más frecuentes:
  - Centrales.
    - Episodios confusionales.
    - Defectos de memoria.
    - Agitación psicomotriz y alucinaciones.

- Periféricos:
  - Náuseas y vómitos (MIR).
  - Visión borrosa y midriasis.
  - Sequedad de boca.
  - Estreñimiento y en menor frecuencia íleo paralítico (MIR).
  - Disminución de la motilidad esofágica.
  - Hipoclorhidria.
  - Retención urinaria más acusada en prostáticos (MIR).
  - Retardo en la eyaculación.

Por estos efectos, están contraindicados (contraindicación relativa) en:

- **Glaucoma** de ángulo cerrado.
- **Hipertrofia prostática.**
- Debe evitarse su uso junto con otros fármacos de acción anticolinérgica (antihistamínicos y buscapina).

### • Efectos cardiovasculares.

- Por bloqueo alfaadrenérgico:
  - Hipotensión ortostática (MIR).
  - Taquiarritmias.
- Por su parecido con la quinidina:
  - Alteraciones del ECG: aplanamiento de la onda T, depresión segmento S-T, ensanchamiento QRS, (MIR) aumento del intervalo P-R (MIR). Son cambios parecidos a los de la hipopotasemia.
- Contraindicación absoluta en el IAM reciente.
- Además, evitar su uso con:
  - Antihipertensivos centrales (metildopa...).
  - Vasodilatadores: intensifican su efecto hipotensor.
  - Hormonas tiroideas: arritmias.

### • Otros efectos secundarios.

- Aumento de peso y de apetito, por bloqueo histamínico.
- Náuseas y vómitos, por estimulación serotoninérgica (MIR).
- Disfunción sexual, por estimulación serotoninérgica.
- Leucopenia, eosinofilia.
- En general contraindicados en embarazo y lactancia pero no en Parkinson.

## Intoxicación

La intoxicación aguda por antidepresivos tricíclicos es una de las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes y graves (mortalidad del 20%) (MIR).

Las manifestaciones clínicas derivan de su efecto anticolinérgico, depresor del SNC y cardiotoxico, y entre ellas se encuentran: hipotensión, hipertermia, convulsiones, coma y arritmias ventriculares (TV, FV). Las arritmias están ocasionadas por el bloqueo de los canales de sodio del mio-

cito, que ocasiona un enlentecimiento de la conducción, y además un deterioro de la contractilidad (lo que explica la hipotensión).

Dado que la vida media de sus metabolitos se prolonga hasta 2-3 días, el tratamiento de la sobredosis requiere: lavado gástrico, monitorización cardíaca prolongada, control de la vía aérea (valorar la ventilación mecánica), y administración de bicarbonato i.v., que revierte el bloqueo de los canales de sodio (MIR).

### Monitorización (MIR 13, 166)

Cuando se administran antidepresivos tricíclicos como imipramina, desipramina o nortriptilina, se deben determinar rutinariamente los niveles plasmáticos por la gravedad que tienen las posibles intoxicaciones.

### 3. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)

Son **los más usados** en la práctica por la escasa frecuencia e intensidad de sus efectos secundarios, su baja incidencia de interacciones y su inocuidad en caso de intoxicación (MIR 10, 146). Se consideran además altamente eficaces y son de **primera elección** en la mayoría de los trastornos depresivos y en muchos de los ansiosos: TOC, trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada. También en bulimia y en trastornos del control de los impulsos.

Los más conocidos son: fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram (MIR), sertralina (MIR).

#### Mecanismo de acción

Cuando en el espacio sináptico, durante la neurotransmisión, se libera serotonina, parte de ésta es recaptada hacia la neurona presináptica antes de llegar a los receptores de la neurona postsináptica. Los ISRS actúan inhibiendo la acción de la bomba de recaptación de serotonina, con lo que aumentan la disponibilidad de esta sustancia en la sinapsis. A largo plazo inducen modificaciones en los receptores postsinápticos.

El efecto clínico tarda entre **4 y 6 semanas** en producirse (MIR) y se relaciona con las modificaciones en los receptores postsinápticos.

Estos fármacos son en general muy selectivos hacia la serotonina; por eso no producen efectos relacionados con bloqueo alfa adrenérgico (hipotensión) ni anticolinérgicos.

Son de primera elección en casos en que hay enfermedades médicas concomitantes o limitaciones en el uso de heterocíclicos: cardiopatías, prostatismo, glaucoma, etc. (MIR).

El **citalopram** (su isómero **escitalopram**, de reciente comercialización) y **sertralina**, son los que menor metabolismo hepático sufren, porque son de elección en pacientes hepatopatas, con pluripatología y múltiples tratamientos farmacológicos (elevado uso en ancianos).

#### Efectos secundarios

- Los más frecuentes gastrointestinales: náuseas, diarrea.
- Ansiedad, insomnio.

- Disfunción sexual: disminución de libido y retraso en la eyaculación o el orgasmo.
- Pueden tener una leve acción antidopaminérgica: temblor, acatisia (más frecuente en ancianos y en enfermos de Parkinson) (MIR).

- Puede existir una ligera actividad anticolinérgica, principalmente con la **paroxetina**.

Síntomas: sequedad bucal, estreñimiento, sedación, visión borrosa y **aumento del riesgo de caídas** en pacientes vulnerables (ancianos, en quienes son más frecuentes estos efectos).

- Raramente bradicardia no clínicamente significativa.
- En intoxicaciones –intencionadas, o en uso de dosis altas o combinaciones de fármacos– pueden dar el llamado **síndrome serotoninérgico**:
  - Náuseas.
  - Temblor.
  - Hipertermia.
  - Agitación, confusión e incluso coma.
- Este síndrome es muy poco frecuente y son en general fármacos muy seguros en intoxicaciones.

No existe entre ellos tolerancia cruzada, es decir, que los efectos secundarios de uno no quiere decir que tengan que repetirse usando otro.

#### Interacciones significativas

- Con litio aumentan neurotoxicidad.
- Con IMAO se aconseja cuando se sustituyen un periodo de lavado de cinco semanas.
- Linezolid: la administración conjunta de este antibiótico (que también actúa como IMAO) con un ISRS puede producir un síndrome serotoninérgico (MIR 12, 233; MIR).

### 4. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina

Tienen acción sobre los dos sistemas de neurotransmisión. Son, como los ISRS, fármacos bastante seguros en su uso.

Los efectos adversos son los mismos que en los ISRS, añadiendo aumento de la tensión arterial, de la sudoración, la secreción gástrica y acción broncoconstrictora, todos ellos por el aumento de actividad noradrenérgica. Sin embargo, estos efectos son leves y poco frecuentes.

Los fármacos de esta familia son duloxetine, venlafaxina y desvenlafaxina (metabolito de venlafaxina con menor metabolismo hepático).

### 5. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (ISRN)

La **reboxetina**, de perfil clínico más estimulante. Efectos secundarios relacionados con aumento de actividad adrenérgica, ya reseñados. Más a menudo que los ISRS puede producir insomnio y ansiedad.

## 6. Antidepresivos atípicos

- **Trazodona:** bloquea los receptores serotoninérgicos postsinápticos (e inhibe débilmente la recaptación de serotonina). Escasa potencia antidepresiva. Tiene un perfil sedante. Un efecto adverso característico es el priapismo.
- **Mianserina:** aumenta la liberación de noradrenalina (al bloquear los receptores presinápticos). Bastante sedante y pocos efectos cardiovasculares y anticolinérgicos. Muy buena elección en ancianos.
- **Mirtazapina:** fármaco con acción dual, noradrenérgica y serotoninérgica, bioquímicamente similar a la mianserina. Elevada sedación y perfil antirrumiativo. Uso principal como hipnótico o adyuvante a otro antidepresivo (ISRS o ISRN).
- **Bupropion:** con mecanismo dopaminérgico y noradrenérgico (**MIR 20, 88**). En España sólo está autorizado para el tratamiento de la adicción al tabaco (en otros países sí se usa como antidepresivo).

### Regla mnemotécnica

*El bupropion es muy propio*

Es un antidepresivo que solo tiene indicación en España para dejar el tabaco, no tiene nada que ver con el resto. Mecanismo de acción dopaminérgico y noradrenérgico:

**NADA** de tabaco

**NorA**drenalina

**DopA**mina

## 7. Antidepresivo multimodal

Se ha comercializado en España un antidepresivo de perfil multimodal, **vortioxetina**. Este fármaco modifica tanto la recaptación de serotonina (ISRS) como la liberación de serotonina al espacio sináptico.

### Otros tratamientos neurobiológicos

#### 1. Terapia electroconvulsiva (TEC)

La TEC consiste en inducir crisis convulsivas generalizadas en un paciente mediante descargas eléctricas aplicadas sobre el cráneo (normalmente en regiones temporales) de muy pocos segundos de duración. Se realiza siempre bajo anestesia general.

Habitualmente se efectúan entre 9 y 12 sesiones en días alternos.

La TEC induce una despolarización neuronal que activa muy enérgicamente los sistemas de neurotransmisión cerebral. Es una técnica eficaz y, si se realiza en condiciones adecuadas, bastante inocua.

#### Indicaciones (**MIR 20, 86**)

- Depresión grave resistente a tratamiento o con alto riesgo suicida (**MIR**).

- Depresión psicótica con riesgo suicida.
- Grave inhibición motriz o catatonía, de origen esquizofrénico o depresivo.
- Manía con agitación severa resistente a tratamiento.
- Depresiones graves en pacientes con contraindicaciones a tratamientos farmacológicos: ancianos, pacientes con patologías múltiples y, en algunos casos, embarazadas.
- En depresiones graves recurrentes que han respondido a tratamiento con TEC puede optarse por efectuar TEC de mantenimiento, de ritmo entre semanal o mensual, para proteger de recurrencias.
- Al acabar la TEC hay que seguir con tratamiento farmacológico del proceso.

#### Contraindicaciones

Serán lógicamente las mismas que para cualquier acto anestésico, y además:

- IAM reciente.
- Hemorragia intracraneal y cualquier proceso que aumente la presión intracraneal.
- Aneurisma cerebral o aórtico.
- Infecciones agudas.
- Desprendimiento de retina y glaucoma de ángulo estrecho.
- ACV o traumatismo craneoencefálico grave en un periodo de seis meses antes de la TEC.

Durante el tratamiento con TEC hay que reducir o suspender la terapia farmacológica, ya que la mayor capacidad de penetración de la barrera hematoencefálica que se produce hace que aumenten los niveles de los fármacos. Habrá por tanto que suspender litio (riesgo de intoxicación), tricíclicos, IMAO, y benzodiacepinas, éstas por aumentar el umbral de convulsión.

### Recuerda...

**No** contraindican la TEC el uso de marcapasos, la cirugía cardíaca, la anticoagulación oral ni las valvulopatías.

### Regla mnemotécnica

*Si **TIC** no **TEC***

La **T**ensión **I**ntra**C**raneal aumentada contraindica la **T**erapia **E**lectro**C**onvulsiva

#### Efectos secundarios

- Amnesia de tipo lacunar, referida al episodio de TEC.
- Confusión durante el periodo postTEC (horas).
- Arritmias durante la TEC, habitualmente pasajeras y reversibles.



- Cefaleas simples de breve duración, tratables con analgesia convencional.

## **2. Estimulación magnética transcraneal (EMT)**

La EMT consiste en la aplicación de un campo magnético en la corteza cerebral, que a su vez induce pequeñas corrientes eléctricas en dicha zona. Esto se consigue colocando un electroimán en el cuero cabelludo. Se trata, por tanto, de una técnica local, no invasiva y que no requiere la administración de anestesia, a diferencia de la TEC. Su principal indicación es la **depresión resistente (MIR 22, 98)**. Sin embargo, su efecto es muy limitado, por lo que no se recomienda en casos severos o urgentes, en cuyo caso la TEC seguiría siendo el tratamiento *gold standard*. Los efectos secundarios son infrecuentes, siendo el principal la inducción de una crisis epiléptica.

## **3. Terapia lumínica o fototerapia**

Se usa en el trastorno afectivo estacional, en países nórdicos. Consiste en exponer al sujeto con depresión recurrente invernal a una luz intensa durante varias horas.

## Tema 4

# Trastornos de ansiedad

**Autores:** Berta Pinilla Santos (21), Florencio García-Escribano Martín (21), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Rafael Baena Mures (10).

### ENFOQUE MIR

Se preguntan bastante, casi siempre como casos clínicos. Más que ir al detalle, lo importante es tener clara la idea de cuál es uno y otro, porque casi siempre en las preguntas lo que se pretende es que se llegue a diagnósticos. Si uno se fija, son sencillos de diferenciar.

La ansiedad es un estado normal caracterizado por activación de la alerta y preparación psicofísica ante una expectativa de respuesta a un estímulo del ambiente. Se acompaña de cambios físicos, expresión de activación adrenérgica. Es patológica cuando no existe estímulo desencadenante proporcional o cuando su intensidad es exagerada y motiva un estado de discomfort intenso en el individuo.

Los trastornos de ansiedad son los problemas psiquiátricos más comunes y extendidos en la población general (MIR), con una prevalencia en la población general del 17,7%.

Son más frecuentes en mujeres y su incidencia disminuye con la edad. El abuso de alcohol es una complicación grave y frecuente (MIR). Es importante recordar que los trastornos de ansiedad pueden asociar síntomas depresivos o psicósomáticos, e incluso conllevar conductas suicidas, pero, sin embargo, **no asocian síntomas psicóticos** (delirios, alucinaciones, etc.) (MIR 14, 222; MIR 14, 225).

El más común es la fobia simple o específica. El que causa más asistencias médicas de urgencias es el trastorno de angustia.

El **DSM-5** ha cambiado la clasificación de los trastornos de ansiedad. En la nueva edición el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), los trastornos disociativos y los trastornos por estrés agudo y estrés postraumático aparecen cada uno en un capítulo diferente (al considerar que tienen entidad suficiente para constituir su propio grupo).

| TRASTORNOS DE ANSIEDAD                                                                                                                                                                                                                     | TOC Y TRASTORNOS RELACIONADOS                                                                                                                                       | TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TRAUMA Y EL ESTRÉS                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansiedad por separación</li> <li>Mutismo selectivo</li> <li>Fobia específica</li> <li>Fobia social</li> <li>Trastorno de pánico</li> <li>Agorafobia</li> <li>T. de ansiedad generalizada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>TOC</li> <li>T. dismórfico corporal</li> <li>T. de acumulación</li> <li>Tricotilomanía</li> <li>T. de excoriación</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>T. por apego reactivo</li> <li>T. de relación social desinhibida</li> <li>T. de estrés postraumático</li> <li>T. de estrés agudo</li> <li>T. de adaptación</li> </ul> |

Tabla 1. Nueva organización de los trastornos de ansiedad según el DSM-5 (MIR 23, 91; MIR 21, 88).

### Crisis de angustia (MIR 11, 146; MIR)

Pueden aparecer en el curso de varios trastornos de ansiedad. Así, el DSM-5 lo considera especificador de cualquiera de los otros trastornos de angustia. Son episodios aislados, bruscos y autolimitados, de 15-30 minutos de duración, de miedo intenso, en ausencia de peligro real, que se acompañan de al menos **cuatro** de los siguientes **trece** síntomas que se detallan en la siguiente tabla:

#### SÍNTOMAS DE LA CRISIS DE ANGUSTIA

- Palpitaciones, taquicardia.
- Sudoración.
- Temblor o sacudidas.
- Sensación de ahogo o falta de aliento.
- Sensación de atragantarse.
- Opresión o malestar torácico.
- Náuseas o dolores abdominales.
- Inestabilidad, desmayo o mareo.
- Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (sensación de separarse de sí mismo).
- Miedo a perder el control o enloquecer.
- Miedo a morir.
- Parestesias.
- Escalofríos o sofocaciones.

Tabla 2. Síntomas de la crisis de angustia.

Estas crisis se pueden presentar de manera inesperada, o bien en relación con situaciones o estímulos determinados que causen la ansiedad.

La prevalencia en la población general es del 3-6%.

Se presentan al inicio de la edad adulta; la edad media de presentación es de 25 años (MIR).

### 4.1. Trastorno de angustia (panic disorder o trastorno de pánico)

Presencia de crisis de angustia **recurrentes e inesperadas** con un periodo de al menos un mes de preocupaciones persistentes centradas en el temor a que aparezcan nuevas crisis, o bien de cambios en la vida del sujeto relacionados con estas crisis (evitar determinadas situaciones, p. ej.), o temores relacionados con los síntomas de las crisis (miedo a tener un infarto, o a volverse loco, p. ej.) (MIR).

Al progresar el trastorno suele acompañarse de un aumento de la ansiedad generalizada, con pensamientos y temores aprensivos.

Las primeras crisis suelen producirse sin desencadenante y es al repetirse cuando se ligan a situaciones de estrés, dando lugar a conductas de evitación (MIR 22, 95). La mayor parte de las veces las crisis no se asocian a situaciones concretas o a un suceso claramente identificable (MIR).

La agorafobia sin trastorno de angustia es la persistencia de miedo intenso a repetir crisis en situaciones típicamente agorafóbicas sin llegar no obstante a desarrollar crisis de angustia completas.

La **prevalencia** es del 1,5-5%, menor que la de las crisis de angustia aisladas. Más frecuente en mujeres (3:1).

La comorbilidad es muy frecuente, especialmente con depresión; también con otros trastornos de ansiedad (generalizada, fobias) o con trastornos de personalidad y abuso de sustancias.

## Etiología

- Factores genéticos: mayor prevalencia en familiares de primer grado. Se han hallado genes candidatos que están en estudio. Se propone su mayor incidencia ligado a dos trastornos: el prolapso de la válvula mitral y el síndrome de hiperlaxitud articular.
- Déficit en la regulación de neurotransmisión: hipofunción GABA, activación adrenérgica y disregulación serotoninérgica.
- La producción de crisis con lactato sódico y otras sustancias ha servido de modelo del mecanismo patológico.
- El aumento de la frecuencia respiratoria que se pone en marcha produce una hiperventilación con alcalosis respiratoria. Los síntomas ansiosos se derivan de esta alcalosis y de la activación adrenérgica.

## Diagnóstico diferencial con enfermedades orgánicas

Ante la sospecha de un trastorno de pánico, siempre deben descartarse enfermedades orgánicas que cursan con síntomas similares (MIR 13, 170):

- Enfermedades cardiovasculares: angina de pecho, IAM, insuficiencia cardiaca, taquicardias paroxísticas supraventriculares, HTA, prolapso de la válvula mitral.
- Enfermedades pulmonares: asma, hiperventilación, TEP.
- Enfermedades endocrinológicas: hipertiroidismo (MIR), síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, feocromocitoma, hipoglucemia, síndrome carcinoide, hipoparatiroidismo.
- Enfermedades neurológicas: epilepsia, esclerosis múltiple, tumor, enfermedad cerebrovascular, síndrome de Huntington.
- Intoxicaciones por fármacos: anfetaminas, cocaína, anticolinérgicos, nicotina, alucinógenos.
- Abstinencia de drogas/fármacos: alcohol, sedantes, antihipertensivos.
- Otros: anemia, síndrome de Ménière, déficit de vitamina B<sub>12</sub>, arteritis de la temporal, anafilaxia...

## Tratamiento

Es fundamentalmente farmacológico. Son útiles también la terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación. El tratamiento de elección son los ISRS (MIR), si bien debemos hacer una diferencia a la hora de plantear el tratamiento.

**Tratamiento agudo** (o tratamiento de la crisis de angustia): son de elección las **benzodiacepinas** (alprazolam o diazepam) (MIR).

**Tratamiento de mantenimiento** (o tratamiento del trastorno de angustia propiamente dicho): son de elección los **antidepresivos**, tanto los ISRS –que son los más usados por su eficacia y tolerabilidad–, como los antidepresivos tricíclicos. Sólo en casos refractarios utilizaremos IMAO (MIR). Se utilizan asociados a **benzodiacepinas** de alta potencia (alprazolam, loracepam, cloracepato, diazepam).

## 4.2. Trastornos fóbicos

### Agorafobia

La agorafobia es la aparición de ansiedad intensa al encontrarse en lugares donde escapar pueda resultar difícil o embarazoso; o donde, en caso de presentarse una crisis de angustia, se piense que no se dispondrá de ayuda, aunque sin llegar a ser una creencia delirante (MIR). Estos temores son frecuentes en espacios públicos, donde hay mucha gente (MIR 18, 204), en medios de transporte (MIR 19, 232) (tren, coches, ascensores, etc.) o espacios cerrados (aparcamientos, sótanos, etc.).

Estas situaciones se evitan o bien se soportan a costa de un malestar importante para el sujeto.

La prevalencia general es del 0,6-6%; siendo más frecuente en mujeres jóvenes.

### Fobia simple o específica

Es el temor persistente a un objeto o a una situación (estímulo fóbico), que a pesar de reconocerse como desmedido e injustificado, queda fuera del dominio del sujeto y da lugar a conductas de evitación.

Las fobias simples son el **trastorno psiquiátrico más común en la población general**.

Son más frecuentes en niños y se consideran en los mismos un fenómeno evolutivo antes que un verdadero trastorno. En adultos, la prevalencia es mayor en mujeres.

Las más frecuentes son:

- A los animales o a los insectos (son las más frecuentes).
- A estímulos del ambiente (tormentas, truenos, mar, alturas) (MIR).
- A la sangre o heridas.
- Fobias situacionales, con miedo en determinadas situaciones, como subir en ascensores, aviones, trenes, etc.

Las fobias no generan habitualmente demandas de asistencia psiquiátrica ni generan discapacidades importantes.

La **clínica** a la que dan lugar es una crisis de angustia, a menudo no completa, dando lugar en algunos casos a cuadros vagales, como en la fobia a la sangre.

El **tratamiento** de elección es la **psicoterapia cognitivo-conductual** (MIR 18, 205), con desensibilización frente al estímulo fóbico. Pueden emplearse **benzodiacepinas** sólo en casos de exposición a situaciones concretas, aunque los fármacos no resuelven el trastorno.

### Fobia social (trastorno de ansiedad social)

En este trastorno el sujeto siente una inseguridad, angustia y miedo a situaciones que lo sometan a **exposición social**: hablar en público, usar un aseo público, comer en lugares públicos, dirigirse a desconocidos, etc. (MIR). El paciente tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que puedan ser valorados de manera negativa por las otras personas (verse humillados, ridiculizados, rechazados o causar ofensa). La exposición a estas situaciones puede llegar a provocar una crisis de angustia, completa o no. El enrojecimiento es un síntoma muy común.

Como en todas las fobias, el individuo reconoce que su temor es excesivo e irracional, aunque se siente incapaz de dominarlo.

Las situaciones temidas se evitan, dando lugar a un deterioro del funcionamiento social.

En los niños estos síntomas pueden tomar la forma de lloros, tartamudeos, abrazos o excesiva timidez.

Se clasifica según sea:

- De interacción social: hablar con desconocidos, acudir a una fiesta, tener una cita...
- De ejecución o rendimiento: hablar o escribir en público, tocar un instrumento, usar el aseo público (MIR 15, 157)...
- Generalizada: los síntomas se presentan en la mayoría de las situaciones sociales.
- Simple: sólo determinadas situaciones llegan a provocar los síntomas.

La edad de comienzo habitual es en la adolescencia.

La prevalencia en la población general es alta y oscila entre el 3 y 13%. Entre pacientes ansiosos, estas cifras llegan al 10-20%.

### Recuerda...

Es muy común la **comorbilidad** con el trastorno de personalidad por evitación. Son frecuentes los **antecedentes** de trastorno de ansiedad por separación en la infancia. El abuso de alcohol es una **complicación** grave y frecuente (el sujeto lo usa para "animarse" a vencer su miedo y por su efecto ansiolítico).

El tratamiento combina la **psicoterapia** cognitivo-conductual con fármacos **antidepresivos**. Son de elección los ISRS (paroxetina) y los IMAO.

En situaciones muy concretas, como el hablar en público, pueden usarse de forma puntual los **betabloqueantes** (atenolol o propranolol), que inhiben la repuesta adrenérgica, reduciendo fundamentalmente el temblor y la taquicardia secundarios a la ansiedad, o las **benzodiacepinas**.

### 4.3. Trastorno de ansiedad generalizada

La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es la ansiedad y preocupación excesiva que se produce de forma mantenida (más días de los que ha estado ausente), durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades (laboral, escolar...).

Además de los síntomas de ansiedad, se asocian otros síntomas como: sensación de nervios, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular o problemas de sueño. Puede acompañarse también de otras afecciones asociadas con el estrés como cefaleas, intestino irritable, etc. (MIR 24, 89).

Hay que diferenciarlo de otros trastornos de ansiedad en que las preocupaciones se ciñen a unas situaciones concretas y no se extienden a todas las actividades, como el trastorno de angustia, donde la preocupación se refiere a la posibilidad de experimentar crisis de angustia; de la fobia social, donde la ansiedad se ciñe a situaciones sociales; de los trastornos somatomorfos, donde el miedo se centra en la enfermedad, etcétera.

El inicio se produce habitualmente entre la adolescencia y primera juventud. Las mujeres tienen el doble de probabilidades que los varones de experimentar un trastorno de ansiedad generalizado.

En los niños se denomina trastorno por ansiedad excesiva infantil.

El curso tiende a ser **crónico**.

Es frecuente la asociación con **síntomas depresivos** (MIR 17, 187), con otros **trastornos de ansiedad** y con problemas de **abuso de sustancias**.

Es frecuente: la prevalencia general es entre el 3-5%, y en población psiquiátrica de hasta el 20%.

Existe agregación familiar, por factores genéticos y de educación.

El **tratamiento** se efectúa con **psicoterapia**: entrenamiento en relajación, terapia cognitivo-conductual. Los **ansiolíticos** se emplean en **tiempos limitados** por el riesgo de dependencia. Los **antidepresivos** (tríclicos e ISRS) son moderadamente eficaces.

### 4.4. Trastorno por estrés postraumático (TEPT)

Trastorno que aparece tras haberse sometido al sujeto de forma **directa o indirecta** a una situación extremadamente traumática, situada fuera de la experiencia humana habitual (accidentes, atentados, catástrofes naturales, agresiones, violaciones...).

### Clínica (MIR)

El síntoma clínico clave del TEPT es la reexperimentación persistente del suceso traumático. Los criterios diagnósticos del TEPT según el DSM-V son:

- Presencia de síntomas de **intrusión** no deseados voluntariamente que provocan malestar (recuerdos, sueños, reacciones disociativas tipo *flashback*) (MIR 19, 190). Pueden estar acompañados de reacciones fisiológicas intensas, asociadas a la reexperimentación (taquicardia, hiperventilación, sudación, piloerección, etc.).

- **Evitación** persistente de estímulos asociados al suceso, como subir en coche tras un accidente, rechazar relaciones sexuales tras una agresión sexual, evitar el fuego tras incendio, etc. Puede progresar hacia el aislamiento social.
- Alteraciones negativas **cognitivas** (amnesia disociativa, creencias y expectativas negativas persistentes) y del **estado de ánimo** (miedo, terror, enfado, culpa, vergüenza). También puede aparecer embotamiento emocional, que se refiere a un estado de desinterés por las personas y por el entorno, y la sensación de estar alejado de los demás, así como la incapacidad de experimentar emociones positivas.
- Alteración del nivel de **alerta y reactividad** (comportamiento irritable, arrebatos de furia, comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada o *hiperarousal*, problemas de concentración y de sueño).
- En los **niños** es frecuente observar juegos que representen directa o simbólicamente los sucesos relacionados: jugar sexualmente con muñecas, hacer chocar violentamente un coche, etc.

El TEPT es frecuente. La prevalencia general es del 8%; tras catástrofes naturales lo presentan un 15% y llega al 80% en víctimas de agresiones sexuales. La mayoría se recupera, sólo un 10% empeora o no mejora. El curso es fluctuante.

Es frecuente la comorbilidad con otros trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos por abuso de sustancias.

Habitualmente aparece en los **6 primeros meses** tras el suceso; si lo hace más tarde se considera de inicio demorado.

Según el **curso** del TEPT, es denominado **agudo** si la duración es menor de **3 meses** y **crónico** si es superior.

El **tratamiento** fundamental es psicoterapéutico. Son muy eficaces los **antidepresivos** (ISRS) que deben darse durante **1 año**.

### Otros trastornos relacionados con el trauma y el estrés

#### Trastorno por estrés agudo

Es un trastorno clínicamente similar al TEPT, que aparece en el **mes siguiente a un suceso traumático** y se resuelve en **menos de 4 semanas**. Si dura más, el diagnóstico se cambia por el de trastorno por estrés postraumático.

#### Trastorno por apego reactivo

Consiste en un comportamiento inhibido y afecto retraído hacia los cuidadores, con alteración social. Es secundario a carencias sufridas en el cuidado o cambios repetidos de los cuidadores principales (niños abandonados, institucionalizados o insuficientemente atendidos).

#### Trastorno de relación social desinhibida

Consiste en un comportamiento inadecuadamente familiar y desinhibido hacia extraños. Como el trastorno por apego reactivo, es secundario a carencias sufridas en el cuidado

o cambios repetidos de los cuidadores principales (niños abandonados, institucionalizados o insuficientemente atendidos).

### 4.5. Trastorno obsesivo-compulsivo

La característica esencial es la presencia de obsesiones y de compulsiones o actos obsesivos de manera recurrente, con pérdida de tiempo significativa que supone una alteración en el funcionamiento normal, en un paciente que comprende lo absurdo de su forma de proceder y de sus pensamientos, pero que es incapaz de evitarlos.

La hipocondría, el trastorno dismórfico corporal, los tics y la cleptomanía se consideran también relacionados con el espectro de la patología obsesivo-compulsiva (**MIR**).

### Clínica

Las **obsesiones** son ideas, imágenes o impulsos mentales que irrumpen una y otra vez en la mente del sujeto, de forma estereotipada. Suelen ser desagradables y aunque el sujeto se da cuenta de que son pensamientos propios no consigue evitar su aparición reiterada. Normalmente el paciente **comprende** que son de **carácter absurdo e irracional**, pero le causan una importante angustia y es incapaz de apartarlas de su mente. Este carácter intrusivo y parásito de los pensamientos obsesivos los hace definir como "egodistónicos": vividos forzosamente, sin acuerdo con el yo del sujeto (**MIR**).

Las **compulsiones** (**MIR 16, 225**) son actos motores (o mentales) **voluntarios**, estereotipados, que se repiten una y otra vez. Su función es la de neutralizar los temores provocados por las obsesiones, aunque formalmente muchas veces no tengan una relación aparente con ellas (**MIR**). El sujeto es consciente de que son absurdas e irracionales, pero no se siente capaz de evitar su repetición, y si lo hace le genera una gran angustia. El grado extremo de la compulsión son los **rituales**, en los que la compulsión adquiere un alto grado de complejidad, llegando a unas conductas estereotipadas a las que el enfermo atribuye un carácter "mágico", con la finalidad de anular el peligro de la idea obsesiva y reducir así la angustia. En los casos más graves, el paciente llega a ritualizar su vida.

Los contenidos de las obsesiones –y de las compulsiones a que dan lugar– son muy variados. Por orden de frecuencia, son (**MIR 15, 151**):

- Obsesión de **contaminación** y compulsiones/rituales de **limpieza**: son las **más frecuentes** (50%) (**MIR**). Suponen un temor a contagiarse una enfermedad o a contaminarse con el contacto con objetos. Se asocia al lavado compulsivo de manos (**MIR**).
- Obsesión de **duda** (patológica) y compulsiones de **comprobación** (25%): se presenta recurrentemente la duda sobre cualquier cuestión, con la compulsión de comprobar, se comprueban "infinitamente" cerraduras o llaves de paso, o la limpieza de los niños, etc. (**MIR**).
- **Pensamientos intrusivos** (15%): en este patrón **no hay actos de compulsión**, aunque puede haber compulsiones mentales (p. ej., rezar una oración). El sujeto se ve asaltado por pensamientos de carácter agresivo o sexual que le resultan inevitables y angustiosos, como el temor



de blasfemar en una iglesia, atacar a su hijo, o agredir sexualmente a desconocidos, etc.

- Obsesión de **orden y simetría** con compulsiones de **colocación y comprobación**: necesidad de simetría, orden y precisión absolutas, que puede dar lugar a inacabables comprobaciones y ajustes. El sujeto puede tardar, por ejemplo, horas en afeitarse o comer.
- Otros patrones sintomáticos: son variantes de estos patrones, con componente religioso, acumulación de objetos a modo de coleccionismo, etc.

Es importante insistir en que en este trastorno el sujeto **comprende lo absurdo** de sus pensamientos y sus actos, pero no puede impedirlos. En los trastornos psicóticos esta conciencia de lo absurdo desaparece.

P. Jannet describió como típico de estos pacientes la Psicastenia, que es la pérdida de la tensión psíquica, de la sensación de seguridad en la realidad, con necesidad de verificación constante de los actos (MIR).

El curso del TOC es **crónico**, aunque con periodos de remisión y otros de exacerbación sintomática.

El DSM-5 pide especificar el nivel de introspección en el TOC (buena, poca o nula/delirante) y si hay historial asociado de tics.



Figura 1. Compulsión de comprobación y de limpieza.

## Etiología

El TOC ha acumulado numerosos datos sobre su origen biológico, y muchos autores opinan que debiera separarse de los demás trastornos de ansiedad.

- Existen alteraciones de la transmisión **serotoninérgica**.
- Hay una hiperactividad cerebral en ganglios basales y lóbulos frontales, que desaparece con el tratamiento.
- Alteraciones genéticas.

Un 35% de los familiares de primer grado con TOC están también afectados.

En niños se ha identificado una variante del TOC (síndrome de **PANDAS**) que se asocia a tics motores, y se relaciona con infecciones por estreptococo beta hemolítico grupo A (MIR 20, 87), como la corea de Sydenham.

El TOC aparece de forma comórbida en trastornos neurológicos como el síndrome de Gilles La Tourette.

## Epidemiología

En la población general la prevalencia es del 2-3%.

No hay diferencias de género en la edad adulta pero en la infancia es más frecuente en niños.

La edad de inicio más frecuente se sitúa hacia los 20 años. Puede empezar antes, existiendo formas infantiles.

Es frecuente la comorbilidad con depresión y fobia social.

## Tratamiento

**Antidepresivos serotoninérgicos**: son eficaces hasta en el 70% de casos (MIR 19, 184). Se utilizan los ISRS y los antidepresivos tricíclicos (clomipramina) (MIR). Se usan dosis más altas y periodos más prolongados que en depresión.

**Psicoterapia conductual de exposición con prevención de respuesta**: se obliga al sujeto a exponerse a los estímulos que teme sin dejarle efectuar las compulsiones que alivian la angustia (MIR 10, 151). No se usa la terapia psicodinámica.

## Otros trastornos relacionados con el TOC

### Trastorno dismórfico corporal o dismorfofobia (MIR 16, 222)

#### Recuerda...

Anteriormente el trastorno dismórfico corporal se encontraba entre los trastornos somatomorfos, pero en la nueva edición DSM-5 pasa a considerarse un trastorno asociado al TOC (MIR 21, 88).

Es un trastorno cercano a la hipocondría en que la preocupación se centra en un **defecto físico** imaginario o claramente exagerado por el sujeto. Suele centrarse en rasgos faciales (asimetría, manchas en la piel, ojos, orejas, etc.) o en miedo a emitir olor desagradable (MIR).

Estas preocupaciones se convierten en el centro de la vida del sujeto y **deterioran** sus relaciones personales y su integración social y laboral (MIR 10, 152).

Se inicia en la adolescencia y primeros años de la edad adulta. Es más frecuente en mujeres.

Los pacientes pueden invertir muchas horas en intentar "disimular" sus defectos. Es muy frecuente que consulten a dermatólogos y cirujanos plásticos, y que se sometan a intervenciones, aunque rara vez encuentran después alivio.

El **diagnóstico diferencial** se plantea sobre todo con:

- El **trastorno delirante tipo somático**, en que la preocupación es de carácter delirante, irreductible a la razón.
- En la **anorexia nerviosa** existe distorsión de la imagen corporal, si bien no es el único fenómeno de la enfermedad.



En el **tratamiento** se usan antidepresivos, especialmente clorimipramina e ISRS, al considerarse una enfermedad del espectro obsesivo. En los casos más graves pueden llegar a usarse bajas dosis de APS.

### Trastorno por acumulación

Consiste en dificultad para deshacerse de las cosas, independientemente de su valor (síndrome de Diógenes).

### Trastorno por excoriación y tricotilomanía

Trastornos caracterizados por rascarse o arrancarse el pelo, respectivamente, de forma repetida y a pesar del malestar que esto provoca.

## 4.6. Benzodiacepinas

Grupo de fármacos con acciones ansiolítica, sedante, hipnótica, anticonvulsivante y miorelajante.

Su **indicación** principal –pero no la única– es el tratamiento de la ansiedad y el insomnio.

### Mecanismo de acción

Las BZD ejercen sus efectos al unirse a una subunidad de los receptores neuronales del **GABA** (ácido gamma hidroxibutírico). Esta subunidad es conocida como el receptor benzodiacepínico. Las BZD son pues **agonistas** de estos receptores y estimulan la función del GABA. El GABA es el principal neurotransmisor cerebral con efecto **inhibidor** y las sinapsis del GABA, distribuidas por el cerebro y la médula espinal, constituyen el 40% de todas las sinapsis.

El receptor del GABA realiza su función mediante canales de **cloro**, de manera que al abrirse los canales de membrana la entrada de cloruro hace que las neuronas sean menos excitables. Los efectos clínicos son la **sedación**, la **reducción** de la **ansiedad** y un **aumento del umbral convulsivante**.

### Farmacocinética

La absorción es **oral**. Se absorben mal por vía IM, excepto el loracepam (no disponible en España). Puede usarse la vía intravenosa en anestesia y en crisis convulsivas, aumentando el riesgo de depresión respiratoria.

Son liposolubles, acumulándose en tejido graso. Atraviesan las barreras hematoencefálica y placentaria, pasando a la leche materna. Su metabolización es **hepática**, excepto loracepam, oxacepam y temacepam.

Eliminación **renal**.

### Clasificación

Se clasifican según su vida media. Las de acción prolongada forman metabolitos que son los responsables de prolongar sus efectos.

| ULTRACORTA<br><6 H                      | CORTA<br>6-20 H                     | LARGA<br>>20 H                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Midazolam<br>Triazolam<br>(MIR 11, 201) | Loracepam<br>Alprazolam<br>Oxacepam | Diacepam<br>Cloracepato<br>Clonacepam<br>Fluracepam<br>Bromacepam |

Tabla 3. Clasificación de las benzodiacepinas.

| Regla mnemotécnica                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benzodiacepinas de vida media ultracorta</b><br>Se <b>MID</b> en en un <b>TRI</b> s<br><b>MID</b> azolam<br><b>TRI</b> azolam<br><br><b>Benzodiacepinas de vida media corta:</b><br><b>AL LOROX</b> con el <b>TEMA</b><br><b>AL</b> prazolam<br><b>LOR</b> acepam<br><b>OX</b> acepam<br><b>TEMA</b> cepam |

### Indicaciones

- Trastornos de ansiedad.
- En trastorno de angustia y en ansiedad generalizada, durante tiempo limitado por el riesgo de dependencia.  
Se utilizan fundamentalmente para abortar las crisis de ansiedad. Se usan también en otros trastornos de la esfera ansiosa, como en el estrés postraumático, trastornos fóbicos y trastornos obsesivos (MIR).
- En el trastorno de angustia se prefiere diacepam en crisis y prevención con alprazolam y clonacepam.
- Insomnio:
  - Recomendado uso limitado a 3 semanas por riesgo de dependencia.
  - En insomnio de conciliación, las de vida media corta: triazolam.
  - Insomnio fraccionario y despertar precoz, vida media larga: diacepam, clonacepam, fluracepam.
- Parasomnias:
  - Síndrome de piernas inquietas, trastorno de conducta del sueño REM: con BZD de vida media larga (clonacepam).
- Síndrome de abstinencia alcohólica: clorazepato.
- Agitación en intoxicaciones por drogas y en cuadros de abstinencia.
- Crisis convulsivas, convulsiones febriles y estatus epiléptico.
- Contracturas musculares: tetrazepam, diazepam.

- Trastorno bipolar: el clonacepam es tratamiento coadyuvante en manía.
- Anestesia: midazolam.

### Efectos secundarios

- **Sedación excesiva** con somnolencia, dificultad de atención, enlentecimiento motriz. Es el efecto adverso más habitual (MIR). Por ello, en ancianos es preferible el uso de benzodiacepinas de vida media corta a las de vida media larga (MIR 23, 92).
- **Tolerancia y dependencia:** mayor en las de vida media corta (alprazolam), menor en las de larga (MIR).
- Ocasionalmente puede aparecer una **reacción paradójica**, en la que se produce un aumento de la ansiedad, inquietud e irritabilidad. Es más frecuente en niños y ancianos, así como en individuos con enfermedades neurodegenerativas.
- **Amnesia anterógrada:** más frecuente en ancianos.
- Ataxia, disartria, vértigo: poco frecuentes.
- La abstinencia a BZD produce irritabilidad, insomnio, ansiedad y posibles convulsiones.

### Contraindicaciones

- Miastenia gravis y cualquier enfermedad que curse con debilidad muscular (MIR).
- Glaucoma de ángulo cerrado.
- Uso limitado en enfermedades con disminución de capacidad respiratoria.
- Embarazo (relativa).

### Intoxicación

- Son muy seguras y bien toleradas.
- Acción depresora del SNC, con riesgo de depresión respiratoria.

- El uso de otros sedantes como el alcohol u opiáceos potencia los efectos de la intoxicación.
- El **tratamiento** de elección es un antagonista específico, el **flumacenilo** (MIR 10, 204).

### Otros ansiolíticos e hipnóticos no benzodiacepínicos

#### 1. Barbitúricos

Poco usados salvo en anestesia. Menos seguros que las BZD. Se usan en convulsiones febriles y en epilepsia (fenobarbital).

#### 2. Clometiazol o hemineurina

Es un derivado de la vitamina B<sub>1</sub>, por lo que es muy usado en la abstinencia alcohólica y como hipnótico. Produce dependencia y riesgo de depresión respiratoria.

#### 3. Betabloqueantes

Usados sólo en casos de ansiedad asociada a síntomas vegetativos profusos: palpitaciones, temblor, taquicardia.

#### 4. Zolpidem, zopiclona, zaleplon

En teoría son hipnóticos puros (sin acción benzodiacepínica), aunque actúan sobre el mismo receptor. Muy usados como inductores del sueño. Su vida media es corta y muy rápida su acción. Aunque en menor grado que con BZD, existe riesgo de dependencia.

#### Regla mnemotécnica

##### Hipnóticos puros o inductores del sueño (ZZZ...)

Zolpidem  
Zopiclona  
Zaleplon

## Tema 5

# Trastornos somatomorfos

**Autores:** Berta Pinilla Santos (21), Florencio García-Escribano Martín (21), Rafael Baena Mures (10), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33).

### ENFOQUE MIR

Lo importante es entender los conceptos para saber diferenciar los trastornos. Si se preguntan será en forma de casos, para hacer diagnóstico diferencial.

Son un grupo de trastornos que tienen en común presentarse como **síntomas físicos** que sugieren una enfermedad médica, sin que sin embargo las pruebas complementarias, los hallazgos de la exploración y los mecanismos fisiopatológicos apoyen la presencia de enfermedad física (**MIR 10, 148**). Se consideran más frecuentes en personas a quienes les cuesta identificar y expresar verbalmente sus emociones (alexitimia).

Nunca se trata de simulación ni son síntomas producidos voluntariamente (**MIR**).

El paciente se queja de problemas físicos sin reconocer habitualmente alteraciones psíquicas.

La mayoría de estos trastornos y especialmente el trastorno de somatización y el de conversión corresponden a la antigua Histeria (**MIR**), término ausente en las clasificaciones actuales. Aunque no es probable, en el MIR pueden referirse a ellos como síntomas histéricos, histriónicos, histeria o sinónimos.

A continuación exponemos los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados recogidos en el DSM-5.

### 5.1. Trastorno de somatización (síndrome de Briquet)

Cursa con múltiples quejas sobre **diversos síntomas físicos** (**MIR 16, 224**), empezando antes de los 30 años. La sucesión de síntomas, casi siempre exclusivamente subjetivos, se prolonga durante años.

Es causa de múltiples asistencia médica y exploraciones complementarias y llega a deteriorar el funcionamiento social y laboral del sujeto (**MIR**).

Incluso si hay una enfermedad médica, los síntomas físicos o el deterioro sociolaboral son excesivos a lo que cabría esperar en casos habituales.

Para asentar este diagnóstico se exige que en la historia estén presentes a lo largo del tiempo:

- Cuatro síntomas de dolor, con localizaciones distintas.
- Dos síntomas gastrointestinales: diarrea, vómitos, dispepsia, pirosis, náuseas, etc.
- Un síntoma sexual: indiferencia sexual, disfunción eréctil, menstruaciones irregulares o dismenorrea, etc.
- Un síntoma pseudoneurológico: cefaleas, dificultad para deglutir, alteración de la sensibilidad, inestabilidad, mareos, pérdida de visión, sordera, etc.

La **prevalencia** es del 2% en mujeres y 0,2% en hombres.

Es muy frecuente la **comorbilidad** con ansiedad o clínica depresiva, que les conduce finalmente al psiquiatra. Puede haber **trastornos de personalidad** de base. Es frecuente el abuso de fármacos y también el consumo de sustancias de abuso.

Entre los familiares de primer grado, existe un 10-20% de parientes con el mismo diagnóstico.

El **tratamiento** se basa en la intervención de un solo médico que evite realizar exploraciones innecesarias. Se usan antidepresivos o ansiolíticos según la comorbilidad.

### 5.2. Trastorno somatomorfo indiferenciado

Presencia de uno o más síntomas físicos **durante más de seis meses** sin causa de enfermedad que los justifique, con deterioro sociolaboral del sujeto.

Se diferencia del trastorno de somatización en que no requiere tantos síntomas ni ha de empezar antes de los 30 años.

Es más frecuente en mujeres y en niveles socioculturales bajos.

### 5.3. Trastorno por dolor

En el DSM-5, el trastorno por dolor está incluido en el trastorno de síntomas somáticos, como un especificador "con predominio de dolor", si la sintomatología somática predominante del paciente es el dolor.

La única queja del paciente es el **dolor** en una o más zonas del cuerpo, sin hallar enfermedad médica que lo justifique o bien cuando la hay, la intensidad y déficit causados por el dolor son superiores claramente a lo que cabría esperar.

Como en todos los trastornos somatomorfos hay un deterioro en el funcionamiento sociolaboral.

El dolor ocupa un lugar central en la vida del sujeto, le impide desempeñar sus obligaciones e interfiere en sus relaciones (**MIR**).

Es frecuente el abuso de fármacos.

La **comorbilidad** con depresión y ansiedad es frecuente.

Es más frecuente en mujeres y aparece a cualquier edad. Tiende a cronificarse.

Se distinguen las formas agudas, de menos de seis meses, y las crónicas, de más de seis meses de duración.

En el **tratamiento** se usan antidepresivos según la comorbilidad.

**Recuerda...**

El DSM-5 engloba el trastorno de somatización, el trastorno somatomorfo indiferenciado y el trastorno por dolor en un solo concepto: trastorno por síntomas somáticos. Se define como uno o más síntomas físicos que causan: pensamientos desproporcionados de gravedad, ansiedad elevada y empleo excesivo de tiempo y energía consagrados al síntoma.

**5.4. Trastorno de conversión**

Presencia de uno o más síntomas que afectan **funciones motoras o sensoriales**, sugerentes de enfermedad neurológica.

Suele tratarse de déficits sensoriales o motores de aparición **brusca** (MIR 12, 159), como debilidad o parálisis de un miembro, sordera, ceguera, afasia, o movimientos anormales (pseudocrisis o convulsiones) o formas mixtas.

Es característico que la presentación sintomática y los hallazgos de la exploración presenten una **incoherencia anatómica** con lo que sería de esperar.

El **inicio** o la exacerbación de los cuadros se asocian a la presencia de factores estresantes.

El comienzo es brusco y la resolución suele ser espontánea en el **curso** de unas dos semanas. Si los síntomas se cronifican más de un año, es muy difícil que desaparezcan.

Es característica una actitud de indiferencia del paciente que contrasta con la presunta gravedad de la lesión, la "belle indifférence" de los franceses (MIR).

Son **factores de buen pronóstico**: el inicio repentino, la presencia de estrés identificable al comienzo, inteligencia alta y escasa duración de los síntomas (MIR 14, 223). Por el contrario, la presencia de convulsiones y temblores ("pseudocrisis") dificulta llegar rápidamente al diagnóstico, y además suelen resolverse peor que otros síntomas neurológicos.

Los síntomas deficitarios claros suelen resolverse bien, no así los temblores o las convulsiones.

La **prevalencia** es mayor en grupos socioeconómicos bajos y población rural. Son más frecuentes en mujeres, 5:1.

La edad de inicio es en los últimos años de la adolescencia o al principio de la edad adulta, son raros antes de los 10 años o después de los 35.

Desde la psiquiatría tradicional se han explicado considerando que son la forma que el individuo tiene de enfrentarse a un **conflicto inconsciente**.

No existen **tratamientos** específicos. La terapia psicodinámica (psicoanálisis) es la más utilizada para intentar averiguar cuál es el conflicto inconsciente desencadenante.

**5.5. Trastorno de ansiedad por enfermedad (hipocondría)**

Es la preocupación y miedo a tener, o la convicción de padecer, una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos (MIR). Esta preocupación persiste a pesar de realizar exploraciones y pruebas negativas. La duración es de más de seis meses.

Aunque habitualmente el sujeto comprende que su preocupación es excesiva o injustificada, no puede evitarla. Es frecuente repetir exploraciones y pruebas con diversos médicos. Inicialmente se tranquilizan pero en poco tiempo sienten de nuevo la necesidad de repetirlas.

Suelen sin embargo incumplir los tratamientos, por miedo a los efectos secundarios (MIR).

El curso es variado desde semanas hasta la cronicidad.

Con menor frecuencia, el sujeto no llega a darse cuenta la mayor parte del tiempo de que su preocupación es injustificada.

Se da por igual en ambos sexos.

Puede iniciarse a cualquier edad.

La prevalencia general es entre 1-5%.

**Diagnóstico diferencial de las ideas hipocondríacas**

- Es importante diferenciar la hipocondría del **trastorno delirante hipocondríaco**, en que la creencia firme del sujeto en padecer una enfermedad no se modifica nunca, creyendo que los resultados de las pruebas son erróneos, que los médicos les engañan, etc. (MIR).
- En la **esquizofrenia** el delirio hipocondríaco es extraño e irreducible a la razón.
- Las preocupaciones hipocondríacas son muy frecuentes en la **depresión** y la ansiedad, pero no ocupan el lugar central del trastorno.

**5.6. Trastorno somatomorfo no especificado**

Abarca un grupo de trastornos que son formas incompletas de los reseñados: preocupaciones hipocondríacas de menos de seis meses, trastornos somatomorfos inespecificados con menos de seis meses, etc.

**Pseudociesis**

"Embarazo psicológico" se clasifica también en este grupo.

## Tema 6

# Trastornos disociativos

**Autores:** Rafael Baena Mures (10), Berta Pinilla Santos (21), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Florencio García-Escribano Martín (21).

### ENFOQUE MIR

No ha sido preguntado en los últimos 10 años. Quédate con las ideas generales.

Grupo de trastornos en los que se produce una separación de contenidos o funciones de la conciencia. Es decir, funciones que están normalmente integradas como la memoria, la identidad o la orientación se separan del resto, dando lugar a cuadros diferentes.

Son trastornos que, como los somatomorfos, se engloban en el antiguo concepto de Histeria. En la CIE se encuadran en el mismo grupo que los trastornos conversivos, con los que tiene muchos puntos en común:

- Su aparición es brusca.
- Tienen una causa psicógena, ligados a acontecimientos traumáticos, ante los que la conciencia “escapa” buscando una defensa ante la angustia.
- Son procesos inconscientes.

No tienen **tratamiento** específico. Se usan ansiolíticos como soporte. La hipnosis se ha usado en algunos casos con éxito.

Se distinguen:

### Amnesia disociativa

Pérdida de memoria global o de una parte de la misma (a menudo la ligada a acontecimientos traumáticos) de aparición brusca y no justificada por causa orgánica (lesión cerebral, epilepsia temporal, palimpsesto alcohólico, abuso de BZD). Puede acompañarse de fuga disociativa o no.

Es el trastorno más frecuente y se puede asociar a otros trastornos disociativos. La recuperación suele ser rápida, brusca y completa.

### Fuga disociativa

El sujeto emprende un viaje a veces largo, con amnesia parcial o total de su pasado y de los motivos que le han impulsado a hacerlo (incluso olvidando su identidad o adoptando una nueva). Se asocia también a acontecimientos traumáticos o vivencias muy estresantes.

También es necesario un diagnóstico diferencial con causas orgánicas (consumo de tóxicos –alcohol–, epilepsia del lóbulo temporal, etc.). La recuperación es brusca y completa.

### Trastorno de identidad disociativa (personalidad múltiple)

Es un trastorno muy raro cuya existencia misma se discute fuera de los EE.UU. El sujeto se comporta como si poseyera dos o más personalidades independientes, cada una ignorante de la otra, cambiando bruscamente. Existe con frecuencia historia de abuso sexual infantil. El diagnóstico diferencial es con epilepsia temporal y uso de sustancias.

### Trastorno por despersonalización/desrealización

Ambos son muy frecuentes y se asocian sobre todo a la **ansiedad**. Pueden verse también en episodios depresivos, en esquizofrenia, en epilepsia temporal o con el uso de sustancias.

- **Despersonalización:** experiencia en que el sujeto se siente separado de sí mismo, como observándose desde fuera de sí (**MIR**).
- **Desrealización:** experiencia de sentir el mundo ajeno e irreal, como si se viviera en un sueño o una película.

Estas experiencias aisladas son muy frecuentes, de manera que hasta un 25% de la población general las ha experimentado alguna vez, en circunstancias estresantes. Constituyen un trastorno cuando se producen de forma repetida e interfieren en la vida del sujeto. No tienen tratamiento específico (tranquilizar e informar que no son graves); se usan ansiolíticos de apoyo si es preciso.

### Otros trastornos disociativos

Algunos síndromes de presentación exclusiva en algunas culturas presentan clínica disociativa. Las experiencias de trance y posesión, ligadas a rituales y creencias religiosas.

### Estupor disociativo

Es una desconexión del ambiente (aparente coma) con recuperación espontánea y que aparece tras conflictos o vivencias de ansiedad intensa. Se recupera espontáneamente de forma rápida.

### Síndrome de Ganser

Es un estado confusional con desorganización del lenguaje, respuestas aproximadas, perplejidad, alucinaciones, que semeja una demencia y aparece bruscamente en situaciones de estrés en sujetos con trastornos de personalidad. Se describió inicialmente en prisioneros, como una reacción de escape frente a la angustia.

## Tema 7

# Trastornos facticios y simulación

**Autores:** Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Florencio García-Escribano Martín (21), Berta Pinilla Santos (21), Kazuhiro Tajima Pozo (10).

### ENFOQUE MIR

No ha sido preguntado en los últimos 10 años. Quédate con las ideas generales.

En estos trastornos existe la **voluntad** deliberada por parte del sujeto de fingir síntomas físicos y/o psíquicos o de producir signos de enfermedad. Al contrario que en los trastornos somatomorfos, los síntomas son voluntarios **(MIR)**.

### 7.1. Trastornos facticios

Se caracterizan por el fingimiento o producción intencionada de síntomas físicos o psíquicos con la finalidad de adquirir el **rol de enfermo**. No existe un beneficio material directo, como la percepción de pensiones o indemnizaciones.

La presentación es diversa, tanto en síntomas físicos (dolores abdominales, náuseas o vómitos, fiebre, hipoglucemias, lesiones dermatológicas...) como en síntomas psicológicos, como quejas de falta de concentración, rendimiento mental o presentarse como una alteración psiquiátrica mayor.

Los pacientes se someten sin importarles a exploraciones e incluso a intervenciones quirúrgicas innecesarias.

### Síndrome de Münchausen

(Como el personaje de cuento, que inventaba embustes)

Es una variedad en la que el paciente inventa historias clínicas abigarradas, con un conocimiento importante de los síntomas, y "viaja" de centro en centro donde casi siempre es ingresado durante tiempo y sometido a exploraciones repetidas y costosas.

### Trastorno facticio aplicado a otro o síndrome de Münchausen por poderes (MIR)

Constituye una forma de maltrato infantil. Consiste en la producción de síntomas a otra persona, generalmente un niño o niña, con la motivación de adquisición indirecta del papel de enfermo o cuidador; los causantes suelen ser los padres (principalmente la madre), quienes acostumbran a mostrar gran preocupación, y es posible que haya historia previa de fallecimiento o ingresos recurrentes en otros hijos.

La clínica suele ser frecuentemente en forma de cuadros abdominales o digestivos, y hemorrágicos. No suele levantar sospecha en el personal sanitario.

En el manejo es fundamental la asistencia psiquiátrica de la madre.

| DIAGNÓSTICO                                                                                                                      | PRESENTACIÓN CLÍNICA                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Trastorno de somatización                                                                                                        | Polisintomática<br>Recurrente y crónica<br>Antecedentes de persona enfermiza         |
| Trastorno de conversión                                                                                                          | Monosintomática<br>Básicamente aguda<br>Simula una enfermedad neurológica            |
| Hipocondría                                                                                                                      | Preocupación por una enfermedad<br>No síntomas físicos de enfermedad                 |
| Trastorno dismórfico corporal                                                                                                    | Sentimientos subjetivos de fealdad o preocupación por un defecto corporal            |
| Trastorno por dolor                                                                                                              | Síndrome de dolor simulado                                                           |
| En los anteriores trastornos:<br>• Existe motivación psicológica inconsciente.<br>• No existe producción voluntaria de síntomas. |                                                                                      |
| Trastornos facticios                                                                                                             | Producción <b>voluntaria</b> de síntomas<br>Adquisición de <b>rol de enfermo</b>     |
| Simulación                                                                                                                       | Producción <b>voluntaria</b> de síntomas<br><b>Motivación</b> externa (económica...) |

Tabla 1. Trastornos con síntomas físicos sin causa somática. *Adaptado de: Kaplan y Sadock. Sinopsis de psiquiatría, 10.ª edición (2009).*

### 7.2. Simulación

No es una enfermedad sino un comportamiento premeditado dirigido a obtener un beneficio material, ya sea económico, laboral, eludir una responsabilidad u otro similar. La búsqueda de esa recompensa externa es lo que lo diferencia del trastorno facticio. Es frecuente en el trastorno de personalidad antisocial.



## Tema 8

# Trastornos del control de impulsos

**Autores:** Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Florencio García-Escribano Martín (21), Berta Pinilla Santos (21), Kazuhiro Tajima Pozo (10).

### ENFOQUE MIR

No se pregunta. Las clasificaciones vigentes incluyen la ludopatía no como trastorno de control de impulsos sino como adicción conductual: juego patológico (en el DSM 5) y trastorno por juego de apuestas y por uso de videojuegos (en la CIE 11).

Grupo de trastornos en los que lo fundamental es la **dificultad de resistirse a un impulso**, una motivación o una tentación de llevar a cabo un acto perjudicial para sí mismo o para los demás. En todos hay una sensación de activación o **tensión interior** antes de llevar el acto a cabo y una sensación de placer, **liberación** o gratificación cuando se realiza. Puede o no haber después sentimientos de arrepentimiento y de culpa.

Desde un punto de vista biológico, los estudios han observado concentraciones disminuidas de 5-Hidroxitriptamina (5-HT, metabolito de la **serotonina**) en LCR, por lo que se supone la existencia de una baja actividad serotoninérgica. Otras vías neuroquímicas también parecen estar implicadas.

Se consideran poco frecuentes. Existe frecuentemente comorbilidad con trastornos adictivos, TOC y otros trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria y afectivos (principalmente depresión).

El tratamiento suele ser combinado: psicoterapia (de preferencia cognitivo-conductual) y tratamiento farmacológico; respecto a éste, han demostrado mayor eficacia los ISRS. En la práctica es frecuente el uso de antiepilépticos como ácido valproico o topiramato. En algunos casos se ha observado beneficio con litio.

Se reconocen en las clasificaciones diagnósticas (**ver tabla 1**):

|                                                       |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE</b>               | Episodios breves, recurrentes y desproporcionados de agresividad verbal y/o física. Más frecuente en infancia y adolescencia             |
| <b>PIROMANÍA</b>                                      | Provocación de incendios de forma recurrente como mecanismo de gratificación y fascinación                                               |
| <b>CLEPTOMANÍA</b>                                    | Robo de objetos innecesarios como vía de liberación y alivio                                                                             |
| <b>TRASTORNO POR COMPORTAMIENTO SEXUAL COMPULSIVO</b> | Comportamiento sexual repetitivo e incontrolable a pesar de las consecuencias adversas personales o sociales y de la escasa satisfacción |

Tabla 1. Trastornos del control de impulsos.

### Potomanía

No incluida como categoría diagnóstica. Consiste en la **ingesta compulsiva de agua**. Los pacientes presentan alto riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas, como hiponatremia dilucional, con consecuencia de edema cerebral y coma. Puede ocurrir en esquizofrenia y también en anorexia nerviosa, cuando los pacientes beben para obtener sensación de saciedad.

## Tema 9

# Trastornos de la conducta alimentaria

**Autores:** Florencio García-Escribano Martín (21), Rafael Baena Mures (10), Berta Pinilla Santos (21), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Rubén Galerón Guzmán (44).

### ENFOQUE MIR

Lo más preguntado en las últimas convocatorias son los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa y las complicaciones derivadas de la misma.

### 9.1. Anorexia nerviosa

#### Criterios diagnósticos (MIR 19, 187)

Los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa según el DSM-5 y la CIE-11 son:

1. Restricción de la ingesta con repercusión nutricional y pérdida de peso. En adultos se considera un IMC <18,5 (MIR); en población infantojuvenil, un peso menor al percentil 5. En la CIE-11, se establece como criterio alternativo la pérdida rápida de peso (más del 20% del peso corporal total en 6 meses).
2. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, acompañado de comportamientos dirigidos a la pérdida de peso, estando incluso por debajo del peso normal.
3. Alteración de la percepción del peso y silueta corporales, con negación del peligro que comporta el bajo peso corporal (MIR).

#### Recuerda...

En la CIE-10, se **consideraba** la amenorrea como criterio diagnóstico (MIR 19, 187).

Característicamente existe una conducta de negación de la existencia de enfermedad. Las pacientes no reconocen problema alguno y es su familia quien suele forzar la actuación médica (MIR).

La autoestima depende de forma central del peso y el aspecto percibidos. Los pacientes suelen disimular su aspecto con ropas anchas y se alteran las percepciones corporales de hambre o de fatiga (MIR).

#### Tipos clínicos (MIR 23, 81)

##### Tipo restrictivo

La paciente restringe la cantidad y calidad de los alimentos ingeridos, y realiza actividad física y ejercicio excesivos (MIR), sin presentar atracones ni recurrir a purgas (uso excesivo de laxantes, vómitos, diuréticos o enemas).

##### Tipo purgativo/compulsivo

Junto a la restricción alimentaria hay conducta de atracones y recurso a purgas (vómitos, laxantes, diuréticos).

En el tipo purgativo es más frecuente la comorbilidad con trastornos del control de impulsos, abuso de sustancias y trastorno límite de personalidad.

#### Complicaciones físicas

- Debilidad y laxitud generales, dificultad de concentración y rendimiento intelectual, apatía.
- Edemas por hipoproteinemias, lanugo, fragilidad de piel y faneras: hiper胡萝卜素emia y piel amarillenta.
- Distensión abdominal y enlentecimiento del vaciado gástrico (MIR).
- Hipotermia e intolerancia al frío.
- Bradicardia, arritmias, prolongación Q-T (signo de riesgo). Frialdad y cianosis en extremidades.
- Anemia, neutropenia, trombopenia, linfocitosis, baja VSG.
- Osteoporosis en amenorreas prolongadas (MIR).
- Hormonas.
  - Aumento de cortisol y de GH (MIR).
  - Disminución de hormonas tiroideas.
  - Descenso de estrógenos en mujeres y de testosterona en hombres.
  - Regresión del eje hipofisogonadal.
- Alteraciones bioquímicas.
  - Deshidratación con urea alta, con disminución de aclaramiento de creatinina por hipovolemia (MIR).
  - Descenso de magnesio, zinc, fósforo.
  - Vómitos: alcalosis metabólica con aumento de bicarbonato, por pérdida de ácido clorhídrico gástrico. Hipocloremia. Hipopotasemia. Hiperamilasemia.
  - Laxantes: acidosis metabólica por pérdida en las diarreas.
  - Hipercolesterolemia por déficit en síntesis de ácidos biliares (MIR).
  - Elevación de GOT, GPT, GGT y enzimas musculares, por destrucción tisular.

Dadas las múltiples complicaciones físicas, que también pueden producirse en múltiples enfermedades orgánicas, es importante realizar el diagnóstico diferencial con anorexias por consumo de tóxicos o de origen orgánico: enfermedades digestivas, enfermedades endocrinológicas (hipertiroidismo), tumores cerebrales, neoplasias ocultas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (MIR 11, 148).

## Curso

Tiende a la cronicidad, aunque responde a los tratamientos especializados y hospitalarios. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor es el pronóstico.

La mitad suele recuperar peso normal, un 20% mejoran con pesos bajos y un 20% no cambian. Un 5% se vuelven obesas. En casi todos los casos persiste el miedo a engordar.

Tras los cinco primeros años de restricción es muy frecuente iniciar ciclos de tipo compulsivo/purgativo, a veces con ganancia ponderal y cambio de diagnóstico a bulimia.

La **mortalidad** es alta (aproximadamente un 6%), siendo fundamentalmente como consecuencia de la inanición (arritmias cardíacas) o por suicidio.

## Epidemiología

La prevalencia en la franja de mayor riesgo (12-21 años) es de 0,3-0,9%.

Más del 90% mujeres.

Edad de inicio: más frecuente después de la pubertad (14-18 años) (MIR). Puede comenzar en edad prepuberal, y es rara después de 40 años.

## Factores etiológicos

- Culturales: más frecuente en países occidentales y desarrollados, con presiones hacia la delgadez como arquetipo de belleza.
- Familiares: estilo familiar competitivo, rígido, exigente.
- Personalidad más frecuente: responsable, con alta autoexigencia y rendimiento, con miedo a la pérdida de control.

## Tratamiento

Se dirige a recuperar nutrición; normalización del peso, pactando con la paciente un peso mínimo de mantenimiento; revertir amenorrea y mejorar cogniciones distorsionadas (sobre autoestima, imagen corporal).

1. **Psicoterapia:** se usa la terapia cognitivo-conductual, de familia y de apoyo (habitualmente no se utiliza el psicoanálisis).
2. **Farmacoterapia:** poco eficaz en general. Pueden usarse orexígenos (ciproheptadina) o antidepresivos (en caso de depresión o bulimia asociadas).

## Criterios de hospitalización

La hospitalización del paciente con **anorexia** suele recomendarse en pesos inferiores en un 20% de lo recomendado con fracaso del tratamiento ambulatorio nutricional, o si hay trastornos hidroelectrolíticos, aunque la decisión final siempre depende del caso concreto. Se recurre al ingreso involuntario por orden judicial sólo en casos de elevado riesgo de muerte debido a las complicaciones de la desnutrición o en presencia de conducta suicida.

En cambio, la mayor parte de pacientes con **bulimia nerviosa** no necesitan ser ingresados (MIR 17, 183). En éstos, sólo se contempla en casos de atracones o purgas peligrosos fuera de control, fracaso del tratamiento ambulatorio o debido a la presencia de otros síntomas como conducta suicida o consumo de drogas.

## 9.2. Bulimia nerviosa

### Criterios diagnósticos

1. Presencia de atracones al menos una vez por semana durante tres meses. Un atracón es la ingesta de gran cantidad de comida en poco tiempo, con vivencia de descontrol (MIR).
2. Conductas compensatorias inapropiadas dirigidas a no ganar peso: vómitos, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ejercicio excesivo y ayuno.
3. Autoevaluación personal exageradamente influida por el peso y silueta corporales.

Las personas bulímicas comparten con las anoréxicas el rechazo a ganar peso y la preocupación centrada en aspecto y peso.

Las personas enfermas de bulimia suelen tener mayor conciencia de enfermedad que los que sufren anorexia, si bien niegan su trastorno en fases iniciales, es más fácil que reconozcan el trastorno y la gravedad de sus conductas respecto a la comida, mejorando así su pronóstico.

El peso suele mantenerse normal o alto y **no** suele haber **amenorrea**.

Hay mayor comorbilidad con trastornos afectivos, abuso de sustancias y trastornos de personalidad que en la anorexia, especialmente con el trastorno límite de la personalidad al tratarse de pacientes con un elevado nivel de impulsividad.

### Complicaciones físicas

No provienen de desnutrición sino de las conductas de purga.

- Trastornos hidroelectrolíticos.
  - Hipopotasemia (MIR 13, 168).
  - Hiponatremia.
  - Hipomagnesemia.
  - Hipocloremia y alcalosis metabólica (vómitos) (MIR 18, 207).
  - Acidosis metabólica (laxantes).
  - Hiperamilasemia por aumento de isoenzima salivar, en relación con la gravedad de los vómitos (MIR).
- Trastornos digestivos.
  - Parotiditis.
  - Pérdida del esmalte dental y caries.
  - Esofagitis.
- Callosidad en el dorso de la mano (signo de Russell) al introducirla para provocar vómito.



Figura 1. Alteraciones dentales.

### Curso y pronóstico

Tiende a la cronicidad y es fluctuante con periodos de normalidad y recaídas frecuentes. Los periodos de remisión superiores a un año se asocian a mejor pronóstico. En general es mejor que en la anorexia.

### Epidemiología

Prevalencia general del 1-3%. Las conductas bulímicas aisladas son muy frecuentes. Inicio más tardío que en anorexia.

### Factores etiológicos

- Culturales.
- Historia personal o familiar de sobrepeso.
- Historia de abuso sexual en la infancia.
- Patrón familiar desestructurado.
- Disminución de la neurotransmisión serotoninérgica (**MIR 24, 85**), de manera similar a los pacientes con problemas de control de impulsos. Por este motivo se utilizan ISRS para el tratamiento.

### Tratamiento

- Terapia cognitivo-conductual, eficaz y con mejor respuesta que en la anorexia.
- Educación y control nutricional.
- Son útiles los ISRS (fluoxetina) en dosis altas: al igual que para los trastornos del control de los impulsos, se están realizando estudios sobre el uso de otros fármacos (sobre todo antiepilépticos: topiramato, zonisamida, gabapentina...) en el tratamiento de la bulimia.

| ANOREXIA                                                                | BULIMIA                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Amenorrea                                                               | No amenorrea                            |
| Disminución del peso                                                    | Peso normal                             |
| <b>No</b> conciencia de enfermedad                                      | Conciencia de enfermedad                |
| Restricción de la comida                                                | Pérdida del control sobre la comida     |
| Distorsión de la silueta corporal                                       | Autoestima basada en la silueta         |
| Alargamiento del QT<br>↑ GH<br>↑ Cortisol<br>↑ Colesterol<br>↑ AST, ALT | ↓ Mg++<br>Alteración del esmalte dental |
| ↑ <b>mortalidad</b>                                                     | ↑ <b>morbilidad</b>                     |
| Crónico (peor pronóstico)                                               | Crónico (mejor pronóstico)              |
| <b>Terapia</b>                                                          | <b>Terapia + ISRS</b>                   |

Tabla 1. Características diferenciales entre anorexia y bulimia nerviosas.

### 9.3. Otros trastornos de la conducta alimentaria

#### Trastorno por atracón

Presencia de atracones (al menos una vez a la semana durante tres meses) sin conductas compensatorias posteriores y que asocian al menos tres de las siguientes características:

- Comer mucho más rápido de lo normal.
- Comer hasta sentirse desagradablemente lleno.
- Comer grandes cantidades cuando no se siente hambre.
- Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere.
- Sentirse luego a disgusto, deprimido o muy avergonzado.

#### Trastorno restrictivo/evitativo de la alimentación

Se caracteriza por evitar o restringir la ingesta de alimentos, asociado a uno (o más) de los siguientes hechos:

1. Pérdida de peso significativa.
2. Deficiencias nutricionales significativas.

3. Dependencia de suplementos nutricionales orales o alimentación por sonda.
4. Un impedimento significativo en el funcionamiento psicosocial (por ejemplo, debido a la evitación o la angustia relacionada con la participación en experiencias sociales que involucran comer).

El patrón de conducta alimentaria no está motivado por la preocupación por el peso o la forma corporal. Tampoco es una manifestación de otra afección médica (por ejemplo, alergias alimentarias, hipertiroidismo) u otro trastorno mental.

#### Trastorno de rumiación

Regurgitación de los alimentos de forma repetida durante al menos un mes.

#### Pica

Ingesta persistente de sustancias no nutritivas inapropiadas para el grado de desarrollo del individuo.



## Tema 10

# Trastornos relacionados con sustancias y otras adicciones

**Autores:** Rafael Baena Mures (10), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Berta Pinilla Santos (21), Florencio García-Escribano Martín (21).

### ENFOQUE MIR

Tema que ha cobrado importancia en los últimos años. Importante conocer la dependencia al alcohol, opiáceos y tabaco.

### 10.1. Conceptos básicos

- **Tolerancia:** disminución de los efectos de una sustancia debido a su administración repetida. Necesidad de más dosis para conseguir el mismo efecto.
- **Abstinencia:** síndrome resultado de la reducción brusca de los niveles de droga en el organismo. Se compone de cambios fisiológicos tanto a nivel físico como emocionales y comportamentales. Común a todas las sustancias con la excepción de la feniclidina y los alucinógenos. Más acentuados en drogas como el alcohol, ansiolíticos y opiáceos. También depende del componente o vulnerabilidad individual.
- **Dependencia:** la adicción como tal. Es producto del uso continuado y habitualmente excesivo de la droga a pesar de las consecuencias negativas que conlleva y se caracteriza principalmente por el deseo persistente e intenso de consumo (**craving** en terminología inglesa), con incapacidad para controlarlo y una priorización de éste sobre otras actividades. Suelen estar presentes los fenómenos de tolerancia y abstinencia.
- **Abuso o consumo perjudicial/nocivo:** consumo perjudicial y dañino para el o la afectada y/o su entorno. Se entiende como el consumo excesivo y desadaptativo, esto es, que genera problemas físicos y sociales.
- **Desintoxicación:** proceso terapéutico consistente en conseguir que un sujeto deje de consumir drogas y supere el periodo correspondiente al síndrome de abstinencia. Es una fase breve –normalmente entre una y dos semanas– en la que se consigue que el organismo deje de ser dependiente de la sustancia, aunque persista el deseo de consumo y la dependencia psíquica.
- **Deshabitación:** proceso prolongado que se dirige a que el sujeto abandone el consumo de drogas de manera permanente, previniendo recaídas. Precisa de medidas de tipo psicosocial.
- **Remisión total temprana:** tras la dependencia, el sujeto no cumple criterios de dependencia en los primeros 12 meses.
- **Remisión total sostenida:** remisión superior a doce meses.

- **Remisión parcial temprana:** el sujeto presenta alguno de los criterios de dependencia o abuso, pero no todos, en los primeros 12 meses.
- **Remisión parcial sostenida:** uno o más criterios, pero no todos, durante más de doce meses.

|                  | ACCIÓN                           | PUPILAS   |
|------------------|----------------------------------|-----------|
| ALCOHOL          | Depresora                        | Medias    |
| OPIÁCEOS         | Depresora                        | Miosis    |
| COCAÍNA          | Psico-estimulante                | Midriasis |
| ANFETAMINAS      | Psico-estimulante                | Midriasis |
| DROGAS DE DISEÑO | Psico-estimulante y alucinógena  | Midriasis |
| FENCICLIDINA     | Excitante                        | Midriasis |
| ALUCINÓGENOS     | Alucinógena                      | Midriasis |
| CANNABIS         | Relajante + tr. senso-percepción | Medias    |
| INHALANTES       | Depresora                        | Medias    |

Tabla 1. Características de las sustancias de abuso.

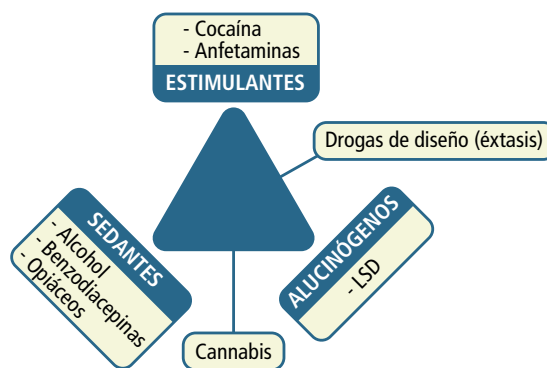


Figura 1. Clasificación de sustancias de abuso.



## Modelo transteórico del cambio

El modelo transteórico del cambio, formulado en 1984 por **Prochaska y Di Clemente**, consiste en una clasificación de las diferentes fases por las cuales pasa un individuo durante un período de cambio conductual. Se aplica especialmente para describir los periodos por los que pasa un paciente en tratamiento de deshabituación a una adicción. Estas fases se denominan “etapas del cambio” y son **(MIR 20, 148)**:

- **Precontemplación**: no existe intención ni deseo de cambio, escasa percepción de riesgo o problema. Por ejemplo, fumador que no quiere dejar de fumar ni ve en ello problema alguno.
- **Contemplación**: aparece una intención de cambio en relación a una percepción de riesgo. Todavía no hay un compromiso específico. Por ejemplo, fumador que prevé dejar de fumar pero en un futuro, sin decidir cuándo.
- **Preparación al cambio**: existe decisión de cambio y un compromiso más o menos inmediato. Por ejemplo, fumador que decide qué día va a dejar el tabaco.
- **Acción**: fase en la que se produce el cambio objetivo y medible. Por ejemplo, abandono del tabaco.
- **Mantenimiento**: etapa de estabilización del cambio conductual ejecutado, y cuya duración se suele considerar de entre 6 meses a 2 años.
- **Recaída**: reinicio de la conducta problemática.

El papel del terapeuta según este modelo es el **soporte y promoción de la transición** por las diferentes fases, para lo cual se ha observado la mayor eficacia y eficiencia mediante la conocida como **entrevista motivacional**.

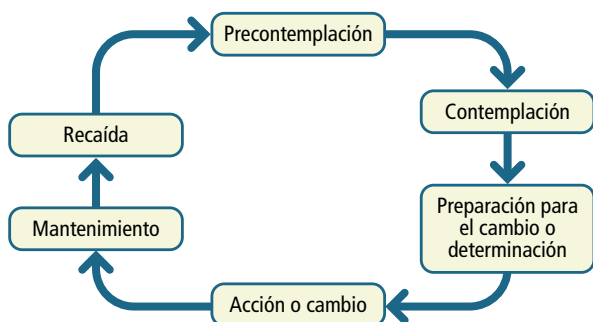


Figura 2. Etapas del cambio.

## 10.2. Alcoholismo

### ENFOQUE MIR

Se trata de un apartado muy importante dado que es el más preguntado en el MIR. Es importante conocer los síntomas de abstinencia, los tratamientos y las complicaciones derivadas del consumo de alcohol.

El alcohol es, junto con el tabaco, la droga de abuso más consumida en el mundo. En nuestro país es la más consumida (cerca de 2/3 de la población la ha consumido en el último año y alrededor de un 7% a diario).

El alcohol consumido habitualmente es el etanol o etílico. Las cifras de **consumo de riesgo** según el Ministerio de Sanidad son 20 g/día en hombres y 10 g/día en mujeres, asumiendo que cualquier consumo puede implicar riesgo. La diferencia de género se debe a la menor presencia de alcohol deshidrogenasa en la mujer. Otra manera de expresarlo es mediante la unidad de bebida estándar (UBE) que corresponde a 10 g (1 UBE = 10 g).

| NIVELES (G/L)                      | CLÍNICA                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,3-0,5                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución de atención y tiempo de reacción.</li> <li>• Desinhibición conductual y excitación.</li> </ul>                                                         |
| 0,5 nivel legal para la conducción |                                                                                                                                                                                                             |
| >0,5                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Síntomas vegetativos (hipotensión, náuseas y vómitos, sudoración).</li> <li>• Trastornos de la marcha.</li> <li>• Incoordinación, disartria y nistagmo.</li> </ul> |
| >3-4                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depresión respiratoria.</li> <li>• Coma.</li> <li>• Muerte <b>(MIR)</b>.</li> </ul>                                                                                |

Tabla 2. Niveles de alcoholemia y clínica.

### Farmacodinámica

Acción depresora del SNC. Potencia la acción de otras sustancias con este efecto: benzodiazepinas, barbitúricos, antipsicóticos.

El metabolismo del alcohol tiene lugar en el hígado por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH), que cataliza la formación de acetaldehído, que a su vez se metaboliza a acetato por la enzima acetaldehído deshidrogenasa (ALDH, diana del disulfiram). Este metabolismo incrementa la relación NADH/NAD<sup>+</sup> (cofactores que intervienen) **(MIR 22, 27)**, lo que inhibe la gluconeogénesis hepática.

Durante el metabolismo del alcohol se produce además hiperlactacidemia como consecuencia de la menor utilización del lactato por el hígado.

### Etiología

- Factores genéticos **(MIR)**.
  - El alcoholismo es hasta cuatro veces más frecuente en familiares de primer grado de alcohólicos.
  - Los hijos de alcohólicos presentan mayor resistencia a los efectos de la intoxicación.

- Factores de personalidad y riesgo psiquiátrico.
  - Personalidad dependiente y evitativa: en tipo I.
  - Personalidad antisocial: en tipo II.
- Factores sociales: es una droga aceptada socialmente y existe presión hacia el consumo: cultura del vino, consumo en reuniones y fiestas, etcétera.

### Clasificación

En el DSM-5 se integra el abuso y dependencia de alcohol en un único trastorno (**trastorno por uso de alcohol**). En el DSM-IV-TR el abuso y la dependencia de alcohol eran considerados de manera independiente.

En el DSM-5, atendiendo al número de criterios que se cumplan se clasificará como leve (2-3 síntomas), moderado (4-5 síntomas) o grave ( $\geq 6$ ). El DSM-5 elimina la existencia de problemas legales como criterio diagnóstico, y se añade el deseo de consumir como un criterio diagnóstico.

Históricamente se clasificaba el alcoholismo como primario (cuando no existía una enfermedad psiquiátrica previa) y secundario (cuando el alcoholismo surgía en el contexto de una enfermedad psiquiátrica, como "automedicación": por ejemplo, efecto ansiolítico en trastornos de ansiedad). La aparición de forma comórbida de un trastorno psiquiátrico y un trastorno por uso de sustancias se denomina patología dual.

### Problemas relacionados con el consumo agudo

Además de la adicción (trastorno por consumo, dependencia) al alcohol, el consumo del mismo se relaciona con accidentes de tráfico, laborales y problemas en el ámbito social y familiar. Algunas situaciones específicas son:

#### 1. Intoxicación alcohólica aguda

En una primera fase, los conocidos síntomas conductuales de desinhibición, euforia, que pueden pasar a irritabilidad, disartria, ataxia. Pérdida de reflejos. Disminución de la capacidad mental y de juicio. Efecto diurético por inhibición de la ADH y vasodilatador.

En una segunda fase, domina el efecto sedante: somnolencia, mayor disminución de los reflejos, aumento de ataxia con caídas, inducción de sueño. Hipotermia. Hipoglucemia por inhibición de la gluconeogénesis hepática (**MIR**).

Las intoxicaciones graves pueden desencadenar depresión respiratoria, coma y ser mortales.

El **tratamiento** de la intoxicación es sintomático (**MIR**):

- Medidas de soporte metabólico, con hidratación, soporte ventilatorio, vigilancia del nivel de conciencia. Solución glucosada intravenosa.
- Si agitación, se prefieren antipsicóticos (p. ej., haloperidol, vía intramuscular disponible) por menor riesgo de interacción y depresión respiratoria que las benzodiacepinas.
- En coma alcohólico pueden ser útiles la naloxona (antagonista opiáceo) y la hemodiálisis.

(Ver tabla 2)

#### 2. Intoxicación idiosincrásica

Alteraciones de conducta graves con amnesia lacunar tras ingesta de cantidades pequeñas de alcohol. Suelen ser abstemios. Es raro si no existe una lesión previa en el SNC.

#### 3. Amnesia lacunar, palimpsesto o "black out"

Pérdida de memoria referida a los acontecimientos que sucedieron durante la intoxicación (**MIR**). Es frecuente en adolescentes y en alcohólicos crónicos.

### Complicaciones debidas al consumo de alcohol

#### Neurológicas

Frecuentes y potencialmente graves. El alcohol es un tóxico directo e indirecto del sistema nervioso central y periférico; fundamentalmente se relaciona con caídas, que pueden provocar lesiones y hematomas craneales (p.ej.: hematoma subdural, típico del alcoholismo crónico). Además, el acetaldehído (metabolito) tiene una acción neurotóxica directa; el déficit de vitamina B1 (tiamina) resultado de la malnutrición y malabsorción secundarias pueden desencadenar la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff.

- **Encefalopatía de Wernicke-Korsakoff** (clásicamente denominada psicosis de Korsakoff, en desuso): resultado del déficit de vitamina B1 o tiamina y su efecto en el diencéfalo principalmente (atrofia de tubérculos mamilares en neuroimagen). La manifestación aguda es propiamente la encefalopatía de Wernicke (**ver manual de Neurología y Neurocirugía**). Su manifestación crónica es el síndrome de Korsakoff, que consiste en una amnesia anterógrada con afectación de la memoria reciente y desorientación principalmente temporal, junto con amnesia retrógrada parcheada y amplia, que se "rellena" mediante **confabulaciones**; el paciente no es consciente de su problema (anosognosia). El tratamiento es la reposición de **tiamina** a dosis altas, con respuesta variable (50% irreversible en caso de Korsakoff).
- **Temblor** fino distal, en manos y lengua.
- **Neuropatía periférica**: polineuropatía mixta, motora y sensitiva, de predominio distal. Es la polineuropatía más frecuente en varones. En el 5-15% de alcohólicos.
- **Degeneración cerebelosa**: con deterioro de la marcha y la postura en el 1% de alcohólicos.
- **Demencia alcohólica**: clínica clásica de demencia. Es la más frecuente de las de causa tóxica. También la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff puede evolucionar a demencia en el 50%.
- **Mielinólisis central pontina** (**ver manual de Neurología y Neurocirugía**).
- **Enfermedad de Marchiafava-Bignani** (**ver manual de Neurología y Neurocirugía**).

#### Trastornos psiquiátricos

El efecto neurotóxico es también causa de alteraciones psiquiátricas.

Por **consumo**:

- **Alucinosis alcohólica**: presencia de alucinaciones, de predominio auditivo (**MIR**) y angustiantes para la persona (de contenido insultante o sexual) (**MIR**) pero también visual, sin alteraciones del nivel de conciencia. Se asocia fundamentalmente al consumo pero **también** aparece en la **abstinencia**. La preservación del nivel de conciencia la distingue de las alucinaciones del *delirium tremens*. En algunos casos progresa hacia la interpretación delirante (**MIR**).

El **tratamiento** se realiza buscando la abstinencia y con antipsicóticos.

- La **celotipia**: un delirio paranoide centrado en la idea de infidelidad, es muy frecuente en alcohólicos, pero no se admite como causado por el tóxico.
- **Trastorno depresivo** inducido por el alcohol: es frecuente y puede ser intenso. Característicamente mejora tras unas semanas de abstinencia. Puede tratarse con antidepresivos.
- **Otros**: el alcohol puede inducir trastornos de ansiedad, fobia social (**MIR**) y empeorar los trastornos psicóticos primarios y las psicosis afectivas.

Por **abstinencia**:

- **Delirium tremens**: se da en algunos casos y supone un cuadro de importante gravedad. Cursa con agitación, nivel de conciencia fluctuante, sudoración, taquicardia, hipertermia, alucinaciones –son muy características las microzoopsias (animales de pequeño tamaño)– y riesgo de convulsiones (**MIR**). El tratamiento recomendado son las benzodiazepinas de vida media larga y clometiazol (derivado de la tiamina que aumenta la actividad de GABA, con efecto sedante, hipnótico, ansiolítico y anti-convulsivante) (**MIR 22, 93**).

(Ver tabla 3)

## Digestivas

- Esofagitis de reflujo.
- Síndrome de Mallory-Weiss.

- Varices por hipertensión portal.
- Gastritis aguda erosiva: es la primera causa de hemorragia digestiva en alcohólicos.
- Gastritis crónica atrófica.
- Pancreatitis agudas y crónicas: el alcohol es la primera causa de pancreatitis crónica.
- Esteatosis hepática.
- Hepatitis aguda: muy frecuente: **cociente GOT/GPT >2** (**MIR**). La gravedad de este cuadro es variable, desde asintomática a fulminante, con muerte.
- Cirrosis: el alcohol es la primera causa de cirrosis.
- Encefalopatía porto-cava, causa frecuente de síndrome confusional en alcohólicos.
- Malabsorción: produce déficit de vitamina B<sub>12</sub> y folato, y de absorción de grasas.

## Cardiovasculares

- Miocardiopatía dilatada.
- Hipertensión arterial.
- Taquiarritmias, especialmente episodios de fibrilación auricular paroxística en relación con las intoxicaciones (“corazón de día de fiesta”).

## Hematológicas

- Anemia con aumento de VCM (**MIR**).
- Neutropenia.
- Trombopenia.

## Osteomusculares

- Miopatías, que pueden ser asintomáticas, detectándose por aumento de CK y LDH.
- Miopatía aguda (la más frecuente) con mialgia y pérdida de fuerza, afecta a musculatura proximal de las extremidades.

|             | DELIRIUM TREMENS                                                                                                                                                                                         | ALUCINOSIS ALCOHÓLICA                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÍNTOMAS    | 1. Síntomas de abstinencia física, deshidratación y pirosis.<br>2. Reducción del nivel de conciencia y desorientación.<br>3. Trastornos sensorio-perceptivos (visuales) y del contenido del pensamiento. | 1. Alucinaciones auditivas persistentes y organizadas.<br>2. No hiperactividad autonómica.<br>3. Conciencia clara.<br>4. Si existen delirios, secundarios a las alucinaciones. |
| INICIO      | A partir del 3. <sup>er</sup> -4. <sup>o</sup> día de abstinencia.                                                                                                                                       | Asociado a consumo elevado en consumidores crónicos.                                                                                                                           |
| MORTALIDAD  | 5%                                                                                                                                                                                                       | No                                                                                                                                                                             |
| TRATAMIENTO | 1. Sedación con benzodiazepinas.<br>2. Rehidratación y vitaminoterapia.<br>3. Sólo anticonvulsivantes si antecedentes.                                                                                   | 1. Antipsicóticos.<br>2. Mejoría en días o semanas si el paciente permanece abstinentes.                                                                                       |

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre alucinosis alcohólica y *delirium tremens*.

- Osteoporosis por malabsorción.  
Primera causa de osteoporosis en varones.

### Respiratorias

- Neumonías por aspiración en intoxicaciones agudas.

### Endocrinológicas

- Hipofunción tiroidea (MIR).
- Hiperkortisolemia.
- Atrofia testicular y en mujeres amenorrea (MIR).

### Oncológicas

El consumo de alcohol eleva significativamente el riesgo de cáncer en:

- Suelo de boca y en general de cavidad oral.
- Faringe.
- Esófago.
- Estómago.
- Hígado.
- Colon.
- Recto.
- Mama.

### Síndrome alcohólico fetal

(Ver manual de Pediatría)

### Diagnóstico del alcoholismo

El diagnóstico de la dependencia o trastorno por consumo de alcohol se realiza mediante criterios específicos que son clínicos. Existen cuestionarios y escalas que pueden resultar útiles en el cribado o identificación. Los más usados son el CAGE, el AUDIT o el de Munich.

El **rasgo principal** que diferencia al bebedor moderado del abuso es la proporción de calorías de la dieta que son debidas al consumo de alcohol (MIR).

Algunas **determinaciones analíticas** ayudan al diagnóstico:

- VCM elevado: poco sensible pero bastante específico. El alcohol es la primera causa del aumento (MIR).
- GGT elevada: muy sensible pero poco específica (MIR).
- Cociente GOT/GPT >2.
- Hipertrigliceridemia: en relación con esteatosis hepática.
- CDT (transferrina deficiente en carbohidratos) elevada: es el marcador más sensible y específico. Puede usarse para detectar recaídas.

### Tratamiento

Como en toda adicción, en dos procesos: desintoxicación y deshabituación.

### 1. Desintoxicación

La supresión del consumo da lugar a un síndrome de abstinencia característico y grave.

- La característica fundamental es un síndrome de hiperactividad autonómica: temblor distal de manos, insomnio, náuseas y vómitos, midriasis, alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, agitación, ansiedad y crisis epilépticas. Riesgo de hipoglucemia. Pueden producirse convulsiones generalizadas (MIR).

Los síntomas comienzan entre 4 y 12 horas tras la última ingesta. La mayor intensidad se produce a las 48 horas y se mejora a partir del 4.º ó 5.º día.

- En los casos más graves se llega al *delirium tremens*. En caso de producirse convulsiones por la abstinencia, son tratadas con diazepam i.v., sin ser necesario el tratamiento con antiepilépticos una vez resueltas (MIR).

### Tratamiento (MIR 24, 48)

Las formas leves de abstinencia se tratan **ambulatoriamente**.

En los siguientes casos es necesario el **ingreso** hospitalario (MIR):

- Síndrome de abstinencia grave (*delirium tremens*).
- Enfermedades médicas o psiquiátricas concomitantes.
- Episodios anteriores de *delirium*.
- Ausencia de apoyo social ni familiar.

El fármaco de elección son las **benzodiazepinas** (MIR): diazepam, clordiazepóxido, lorazepam (recordar que esta última no tiene metabolismo hepático y es una alternativa útil en hepatopatías).

Se debe asociar al tratamiento suplemento de tiamina y control dietético adecuado.

### 2. Deshabituación

Es un proceso largo, mínimo de seis meses a un año, con un soporte fundamentalmente psicosocial. Son útiles los grupos de autoayuda y el seguimiento psiquiátrico y médico frecuente.

Una vez consolidada la deshabituación, el 50% de pacientes mantiene abstinencia superior a un año y en muchos casos de por vida (MIR).

Fármacos usados en deshabituación:

- **Aversivos:** disulfiram (antabus) (MIR 13, 171) y cianamida, son inhibidores de la enzima aldehído deshidrogenasa, haciendo que se produzca un **acúmulo de acetaldehído** (MIR 12, 234). Esto produce una serie de síntomas: enrojecimiento, vasodilatación, hipotensión, palpitaciones, náuseas, visión borrosa, ansiedad... de manera que el paciente sabe que no puede beber para evitar padecer estos efectos.

Se empiezan a dar habiendo pasado un mínimo de tres días desde la última ingesta.

Contraindicados en cardiopatías. El disulfiram también en hepatopatías (la cianamida puede darse). Ambos han de evitarse en el embarazo.

- **Agentes anti craving:** naltrexona, acamprosato, nalmeveno.

Buscan **disminuir el deseo** de consumo (MIR). En el *craving* está involucrado el sistema opioide cerebral. La naltrexona es un antagonista opiáceo que bloquea la sensación placentera que acompaña a la bebida, disminuyendo el deseo. Contraindicada en hepatopatías.

El acamprosato actúa sobre la transmisión glutamatérgica. Cuando un alcohólico se expone a estímulos que aumentan el deseo (contemplar beber, captar el olor de las bebidas, entrar en lugares donde se bebe) se activa el sistema excitador del glutamato, despertando el deseo. El acamprosato bloquea esta activación, disminuyendo el deseo de beber.

Nalmeveno se relaciona estructuralmente con la naloxona y naltrexona, comportándose como un modulador de los receptores opiáceos que se activan con el consumo de alcohol, encargándose el fármaco de la modulación de opioides endógenos.

### Prevención del alcoholismo

- Detección precoz del abuso, mediante:
  - Entrevista para cuantificar el consumo de alcohol.
  - Test de dependencia de MALT.
  - Analítica sanguínea con ↑ GGT, VCM y cociente GOT/GPT >1.
- Grupos de autoayuda y atención sanitaria (UDA).

### 10.3. Tabaquismo (MIR 24, 192)

El tabaco mata alrededor de 6 millones de personas al año en el mundo. Entre las sustancias que contiene se encuentra la **nicotina**, principal responsable de generar dependencia al tabaco.

La motivación del paciente es importante para la cesación de cualquier dependencia. Por ello, la **Atención Primaria**, donde existe una continuidad en los cuidados y una estrecha relación con los pacientes, es el lugar más favorable para el abordaje de la cesación tabáquica.

Para el tratamiento de la cesación tabáquica, han resultado ser eficaces:

- Entrevista motivacional.
- Terapia cognitivo conductual.
- Tratamiento farmacológico:
  - **Citisiniclina o citisina:** fármaco más reciente, financiado por el SNS (un intento al año) para pacientes incluidos en un programa de tratamiento del tabaquismo.
  - Varciclina, retirada del mercado.
  - Bupropion, antidepressivo dopaminérgico.
  - Terapia sustitutiva con nicotina.

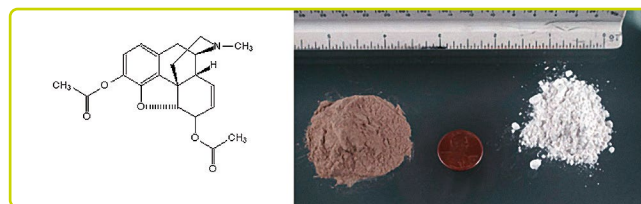
### 10.4. Opiáceos

Presentan una acción depresora del SNC.

Son sustancias de origen vegetal derivadas de la adormidera.

Han tenido y conservan numerosos usos médicos: analgésicos, anestésicos, en edema agudo de pulmón, antidiarreicos, antitusígenos. Contraindicados en cólico biliar por contraer el esfínter de Oddi (MIR).

Son drogas de abuso causantes de una importante morbi-mortalidad.



Figuras 3. Heroína.

### Mecanismo de acción

Los opiáceos se unen a receptores específicos (opioides) en el SNC. Producen la liberación de endorfinas, sustancias opioides endógenas. El receptor MU es el más implicado en la dependencia.

Además de estas acciones, los opioides endógenos se relacionan con el llamado sistema cerebral de recompensa, circuito activado en situaciones gratificantes.

Según la acción sobre los receptores, los opiáceos se dividen en (MIR):

Los **agonistas puros** serán capaces de reproducir los efectos naturales y los de la intoxicación.

| AGONISTAS PUROS                                                                                                                                                                                                             | AGONISTAS PARCIALES                                                                    | ANTA-<br>GONISTAS /<br>AGONISTAS                                                       | ANTA-<br>GONISTAS<br>PUROS                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morfina.</li> <li>• Heroína.</li> <li>• Metadona.</li> <li>• Codeína.</li> <li>• Meperidina.</li> <li>• Dextropropoxifeno.</li> <li>• Loperamida.</li> <li>• Fentanilo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buprenorfina.</li> <li>• Tramadol.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentazocina.</li> <li>• Nalorfina.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naloxona (uso en intoxicaciones agudas y coma).</li> <li>• Naltrexona (uso en deshabituación).</li> </ul> |

Tabla 4. Tipos de opiáceos.

Los **agonistas parciales** ocupan el receptor sin dar lugar a los efectos de la intoxicación y sí, aunque en menor grado, a los analgésicos.

Los **antagonistas/agonistas** se comportan como tales según las dosis usadas.

Los **antagonistas** serán capaces de bloquear el receptor desplazando del mismo a los agonistas, anulando por tanto la acción de éstos, tanto en intoxicaciones como en consumo terapéutico.

### Trastornos asociados al consumo

(Ver tabla 5)



|                                     | CLÍNICA                                                                                                                              | TRATAMIENTO                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>INTOXICACIÓN</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miosis.</li> <li>• Depr. resp.</li> <li>• Alteración de la conciencia.</li> </ul>           | Naloxona intravenosa                                   |
| <b>ABSTINENCIA</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Midriasis.</li> <li>• Como una gripe (rinorrea, dolor muscular, molestias G.I.).</li> </ul> | Sustitutivo: metadona +<br>Sintomático: clonidina      |
| <b>DEPENDENCIA (DESHABITUACIÓN)</b> |                                                                                                                                      | ↓ exigencia: metadona<br><hr/> ↑ exigencia: naltrexona |

Tabla 5. Características del consumo de opiáceos.

### 1. Intoxicación aguda

Puede darse en el contexto de sobredosis por administración errónea (droga más pura de lo habitual) o como tentativa suicida.

#### Clínica (MIR)

Fundamentalmente depresora.

- Miosis (MIR).
- Depresión del nivel de conciencia, desde somnolencia a coma.
- Depresión respiratoria, que puede ser fatal.
- Bradicardia e hipotensión.
- Edema agudo de pulmón.
- Hipotermia.
- Rubefacción facial.

#### Tratamiento (MIR)

De elección, **naloxona**: antagonista de vida media corta. Administración preferentemente por vía intravenosa o intramuscular (más lenta absorción), acción rápida (MIR). Medidas de soporte vital.

En caso de sobredosis de buprenorfina (rara), estimulación respiratoria, pues la naloxona no antagoniza su acción.

|                     | INTOXICACIÓN | ABSTINENCIA |
|---------------------|--------------|-------------|
| <b>OPIÁCEOS</b>     | Miosis       | Midriasis   |
| <b>ESTIMULANTES</b> | Midriasis    | Miosis      |

Tabla 6. Alteración pupilar en el consumo de opiáceos y estimulantes del SNC.

### 2. Síndrome de abstinencia intenso y característico

Su ritmo de presentación dependerá de la vida de la sustancia: en heroína, entre 6-8 horas, llegando al máximo entre dos-tres días; en metadona, 24-36 horas, con duración hasta diez-doce días. La meperidina produce síndrome de abstinencia más rápido (MIR).

#### Clínica (MIR 24, 87; MIR)

Sugiere los efectos inversos de la intoxicación: estimulación del SN autónomo.

- Midriasis (MIR).
- Dolores osteoarticulares y abdominales.
- Diarrea y vómitos (MIR).
- Rinorrea, lagrimeo.
- Sudación.
- Piloerección.
- Hipertensión.
- Hipertermia.
- Hiperpnea.
- Temblor.
- Bostezos (signo temprano).
- Inquietud psicomotriz, agitación y agresividad.

#### Tratamiento

**Sustitutivo** (de elección): consiste en la administración de otro opiáceo, de forma **controlada y supervisada**. Los principales en la actualidad son la metadona y la buprenorfina (MIR).

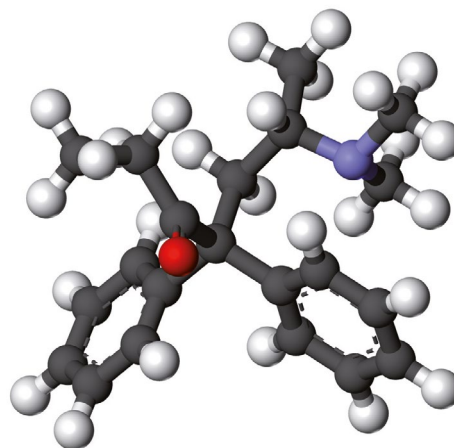


Figura 4. Metadona.

#### Recuerda...

El síndrome de abstinencia a opiáceos es como "una gripe", con malestar general, dolores musculares, sudoración, rinorrea, molestias gastrointestinales, etc... Tiene su pico máximo a los 2-3 días y se resuelve a los 7-10 días.

**Sintomático**: alfa 2 agonista (Clonidina). Soporte con analgésicos, ansiolíticos, antieméticos.

### 3. Dependencia

#### Trastornos asociados a la dependencia

- Estreñimiento.
- Síndrome nefrótico: GNF focal y segmentaria con depósitos de IgM y C3.



**Recuerda...**

Los opiáceos atraviesan la barrera placentaria y afectan al feto, pudiendo dar lugar a un síndrome de abstinencia en el recién nacido. Son niños hipotónicos y con menor respuesta respiratoria, con riesgo de complicaciones durante el parto. Tras nacer pueden presentar convulsiones por la abstinencia. Se trata en unidades pediátricas con sustitución y retirada progresiva.

Requiere monitorización.

- Efectos neurotóxicos por los adulterantes: neuropatía periférica, mielopatía.
- Efectos derivados del uso de vía intravenosa: infecciones locales y sistémicas, abscesos locales y diseminados, valvulopatías, embolismos sépticos.

La mortalidad de la dependencia de opiáceos es alta: 25% a los 10-20 años de iniciada.

**Tratamiento de la dependencia de opiáceos**

El tratamiento es de elección combinado, farmacológico y psicosocial. La desintoxicación puede realizarse ambulatoriamente aunque en algunos casos esté indicado que sea hospitalaria. A nivel farmacológico se usan:

- **Tratamiento con agonistas (sustitutivo):** los programas de tratamientos sustitutivos son los de elección y los que más beneficio han demostrado. Útiles para paliar los efectos de la abstinencia (físicos y emocionales), con lo que se reduce el riesgo de recaída y consecuencias del consumo. Suelen ser tratamientos prolongados que buscan la abstinencia y, si es posible, la retirada progresiva. La **metadona** es un agonista opioide puro, con buena disponibilidad por vía oral (vía de administración), vida media larga (administración única) y que no produce efectos euforizantes de otros opiáceos. Una alternativa de uso frecuente es la **buprenorfina**, agonista parcial, cuya forma más extendida es combinada con naloxona, con lo que se evita su mal uso. En algunos países hay programas de tratamiento con heroína controlada, fundamentalmente dentro de otras estrategias de reducción de riesgo (material, educación sanitaria).
- **Tratamiento con antagonistas (naltrexona):** se usa una vez completada la desintoxicación. Es un antagonista de vida media larga que se absorbe por vía oral y suprime el efecto del opiáceo ante una supuesta recaída (refuerzo indirecto).

**10.5. Cocaína****ENFOQUE MIR**

Se ha preguntado bastante como caso la clínica de la intoxicación. Importante entender que a pesar de no dar síndrome físico de abstinencia, es una droga que genera una gran dependencia, sobre todo fumada e inyectada.

|                                | ALCOHOL                                                                                                                | OPIÁCEOS                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTOXICACIÓN AGUDA</b>      | Depresión SNC + miosis + EAP<br>Tratamiento: naloxona                                                                  |                                                                                                                          |
| <b>SÍNDROME DE ABSTINENCIA</b> | Hiperactividad SNA + midriasis                                                                                         |                                                                                                                          |
|                                | <i>Delirium tremens:</i><br>zoopsias<br>Tratamiento:<br>clordiazepóxido<br>Puede ser ambulatorio                       | Bostezos:<br>signo precoz<br>Tratamiento:<br>clonidina<br>Ingreso                                                        |
| <b>DESHABITUACIÓN</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aversivos: disulfiram.</li> <li>• Anti <i>craving</i>: naltrexona.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antagonistas: naltrexona.</li> <li>• Tras varias recaídas: metadona.</li> </ul> |
| <b>COMPLICACIONES</b>          | Síntomas neurológicos                                                                                                  | GNSF                                                                                                                     |

Tabla 7. Características diferenciales del consumo de alcohol y opiáceos.

Efecto **psicoestimulante**. Produce euforia, desinhibición, resistencia al cansancio. Tuvo usos en la medicina de principios del siglo XX como anestésico local. Las hojas se usan en países andinos en infusión, para combatir la fatiga y el hambre.



Figura 5. Cocaína.

**Mecanismo de acción**

Inhibición de la recaptación de monoaminas, especialmente **dopamina**.

**Farmacocinética**

- Vía de administración:
  - Inhalada en polvo, la más frecuente.
  - Fumada ("coca base" o *crack*): forma muy adictiva tras pocas administraciones.
  - Intravenosa: se usa sola o mezclada con heroína (*speed-ball*). Alta capacidad de adicción.

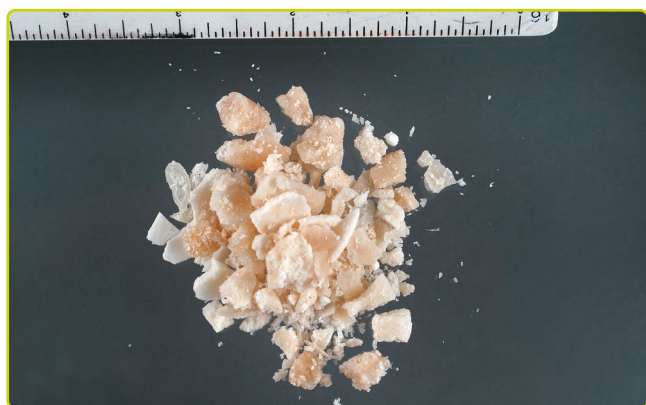


Figura 6. Cocaína base o crack cocaine.

- Vida media:
  - En la forma intravenosa es de aproximadamente 60 minutos: la inhalada es algo más prolongada al actuar localmente como vasoconstrictor nasal, prolongando el tiempo de absorción (MIR).

## Trastornos asociados

### 1. Intoxicación (MIR 15, 154; MIR)

- Efectos psíquicos:
  - Euforia rápida e intensa, de breve duración, que da lugar después a un estado de disforia.
  - Hiperactividad motriz y resistencia al cansancio.
  - Ideas delirantes, especialmente persecutorias.
  - Delirio de formicación (síndrome de Magnan) (ver tabla 8): el sujeto cree tener insectos (hormigas) bajo la piel. Se asocia a alucinaciones táctiles.
  - Alucinaciones visuales, frecuentemente "liliputienses" (seres diminutos).
  - Episodios maníacos inducidos.
- Efectos físicos (MIR):
  - Midriasis.
  - Hipertensión arterial (MIR).
  - Taquicardia.
  - Hipertermia.
  - Hiperreflexia tendinosa.

|                             | PATOLOGÍA                           | CARACTERÍSTICA     | EJEMPLO                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| INTOXICACIÓN POR COCAÍNA    | Síndrome de Magnan                  | Alucinación táctil | "Siento bichos corriendo"   |
| ABSTINENCIA A ALCOHOL       | Delirium tremens                    | Alucinación visual | "Veo bichos corriendo"      |
| TRASTORNO DELIRANTE CRÓNICO | Delirio dermatozoico senil (Eckbom) | Idea delirante     | "Tengo bichos en mi cuerpo" |

Tabla 8. "Bichos" en psiquiatría.

## Complicaciones de la intoxicación

- Cardiovasculares: crisis HTA, arritmias, rotura de aorta, miocarditis, infarto de miocardio y muerte súbita.
- Neurológicas: hemorragias e infartos cerebrales (por vasoconstricción). Convulsiones. Coma.
- Respiratorias: rotura de tabique nasal. Neumotórax y neumomediastino. Hemorragia pulmonar. Edema agudo de pulmón.
- Otras: rabdomiólisis con insuficiencia renal aguda. Necrosis hepática.

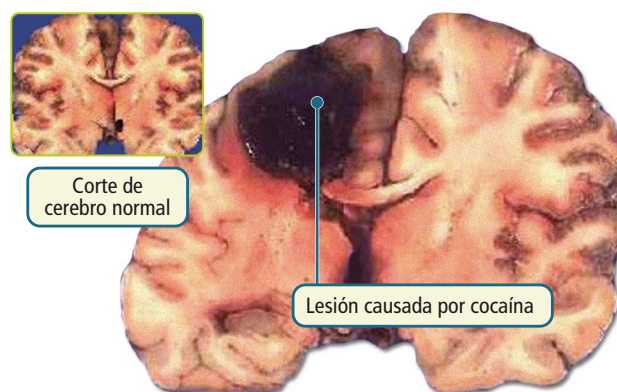


Figura 7. Lesión cerebral por cocaína.

### 2. Abstinencia

La cocaína es una droga con gran potencial adictivo, mayor cuando se consume fumada o endovenosa. La abstinencia a cocaína se manifiesta con una primera fase conocida como "crash" en la que predomina un estado de fatiga, abatimiento, aumento de apetito y disforia; esta última persiste y se presenta en forma de irritabilidad, a la que acompaña un intenso deseo de consumo (craving).

### 3. Complicaciones crónicas

- Las **físicas**: HTA, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, insuficiencia respiratoria, perforación nasal. Además, hiperprolactinemia con galactorrea, ginecomastia y disminución de la potencia sexual. (MIR). Infecciones locales y sistémicas en caso de uso intravenoso.
- Las **psíquicas** pueden ser graves: psicosis paranoide, episodios depresivos en abstinencia con impulsividad suicida.

## Tratamiento

En intoxicación, tratamiento sintomático, en ocasiones es necesario soporte vital intensivo:

En dependencia, no hay tratamiento específico. A nivel farmacológico, en **desintoxicación** son útiles sobre todo las benzodiazepinas de vida media larga (diazepam, clonazepam), o los antipsicóticos a dosis bajas (risperidona, olanzapina). Para la **deshabitación**, se han ensayado

diferentes estrategias farmacológicas destinadas fundamentalmente a reducir el *craving*, con resultado dispar: principalmente anticonvulsivantes (topiramato, gabapentina), o naltrexona. El disulfiram está indicado cuando hay dependencia al alcohol concomitante.

| CLÍNICA           | TRATAMIENTO     |
|-------------------|-----------------|
| Ansiedad          | Benzodiacepinas |
| Agitación intensa | Antipsicóticos  |
| Psicosis tóxica   | Antipsicóticos  |
| Arritmias         | Propranolol     |
| Convulsiones      | Diazepam        |

Tabla 9. Tratamiento sintomático de la intoxicación por cocaína.

## 10.6. Otras drogas

### Anfetaminas

Son psicoestimulantes.

Tienen algunos usos médicos: en el trastorno por déficit de atención-hiperactividad y en depresiones resistentes.

La vía de administración puede ser oral o intravenosa.

Al igual que la cocaína, pueden producir clínica psicótica y exacerbar o desencadenar cuadros psicóticos previos.

Generan tolerancia y abstinencia, básicamente psíquica, como la cocaína.

### Drogas de diseño (MIR 10, 130)

Su uso va en aumento. Son derivados de anfetaminas con efectos mixtos, psicoestimulantes y alucinógenos. Son conocidas el éxtasis o MDMA (metilendioximetanfetamina), GHB, NDMA. Ejercen su acción sobre el sistema serotoninérgico.

Pueden dar lugar a un cuadro serotoninérgico agudo, fulminante y a veces fatal: hipertermia, HTA, coma y muerte.

Son neurotóxicas: producen lesiones permanentes en vías de transmisión serotoninérgica, estudiadas con técnicas de neuroimagen dinámica (SPECT y PET).

Pueden desencadenar episodios psicóticos.

El manejo de la intoxicación consiste en tratamiento sintomático, sueroterapia, observación y, en caso de ingesta reciente de la última pastilla (menos de 1-2 horas), lavado gástrico y administración de carbón activado.

### Fenciclidina (PCP o “polvo de ángel”)

Ejerce acción sobre receptores NMDA del glutamato, principal neurotransmisor excitador del SNC.

Es usado como anestésico en veterinaria.

La intoxicación aguda da lugar a cuadros de intensa agitación y violencia asociada a incoordinación motriz, disartria, hiperacusia y nistagmo (vertical).

No genera dependencia.

El **tratamiento** es sintomático.

### Alucinógenos

Ejercen su acción central sobre el sistema serotoninérgico, y en menor grado sobre el noradrenérgico y dopaminérgico.

El más conocido es el LSD (lisérgico dietil amida), también hongos como el peyote o cactus, y la ketamina.

No generan tolerancia ni síndrome de abstinencia.

### Intoxicación

- **Físicamente** produce clínica de actividad adrenérgica: taquicardia, hipertensión, midriasis, sudación (**MIR**).
- **Psíquicamente**, alteraciones perceptivas: ilusiones y alucinaciones visuales, sinestesias (cambios de los sentidos en la percepción: “oír colores o ver sonidos”).

Pueden dar crisis intensas de pánico y despersonalización (“mal viaje”).

Pueden exacerbar o desencadenar clínica psicótica en sujetos con predisposición.

Son típicas las experiencias de *flashback*, incluso tras un tiempo sin consumirlas.

### Cannabis

Es la sustancia de abuso ilegal más consumida.

Tiene algunos usos médicos: antiemético (especialmente tras quimioterapia), analgésico, miorrelajante.

### Mecanismo de acción

El cannabis se une en el SNC a receptores específicos (endocannábicos). Induce tolerancia que inicialmente es inversa: la producción de metabolitos activos se acumula y pequeñas dosis hacen más efecto; aunque con el uso continuado pasa a ser directa.

No produce síndrome físico de abstinencia, sí inquietud psíquica y disforia de duración breve.

### Farmacocinética

Absorción respiratoria. La vía de administración habitual es la fumada. Es muy lipofílico y atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica. Sus metabolitos se acumulan en hígado y el ritmo de excreción es lento. Pueden detectarse en orina semanas después del consumo.

### Trastornos asociados

#### 1. Intoxicación aguda.

- Produce hiperemia conjuntival, taquicardia y efectos anticolinérgicos: sequedad de boca. Aumenta el apetito.

- Efectos psíquicos: relajación y suave euforia; disminución de la concentración; alteraciones perceptivas como cambio en la percepción de colores, sabores y sonidos.
- Puede desencadenar crisis de pánico y despersonalización, muy frecuentes, y con menor frecuencia episodios psicóticos (en consumidores habituales).

## 2. Complicaciones crónicas.

- Las derivadas de la vía de consumo: disminución de la capacidad vital respiratoria.
- Disminución de la fertilidad.
- Aumento de la velocidad de flujo cerebral con riesgo vascular a largo plazo.
- Síndrome "amotivacional": desinterés y apatía en consumidores habituales, que desaparecen con la abstinencia.
- Puede dar lugar a episodios de *flashback*: alteraciones perceptivas y de pensamiento sin consumo reciente, similares a las del consumo agudo.

El **tratamiento** de la adicción se realiza con psicoterapia.

## 10.7. Adolescencia y adicciones

La edad de inicio de consumo de sustancias en España se sitúa en torno a los 13-14 años, siendo frecuente la secuencia alcohol → tabaco → cannabis → otras sustancias. El alcohol es la droga más consumida.

Entre los principales problemas relacionados con el consumo en la adolescencia encontramos:

- Intoxicación aguda.
- Problemas escolares y legales.
- Sexo no planificado: implica embarazos no deseados y contagio de ETS.
- Problemas afectivos: es importante la relación entre el alcohol y el suicidio.

Siempre hay que sospechar consumo de tóxicos en los adolescentes que presentan cambios bruscos de conducta o crisis epilépticas sin antecedentes (**MIR 15, 168**).

## 10.8. Adicciones sin sustancia

Las adicciones sin sustancia, también conocidas como adicciones comportamentales, se encontraban incluidas en el DSM-IV dentro del trastorno de control de impulsos, pero salen de este capítulo en el DSM-5 y se incorporan al capítulo de conductas adictivas, con el argumento de que estas adicciones activan sistemas de recompensa similares a los que activan las drogas y provocan síntomas conductuales similares a los producidos por sustancias.

La adicción al juego, a los videojuegos y a internet son trastornos que se encuentran incluidos dentro del epígrafe.

# Trastornos mentales orgánicos o trastornos neurocognitivos

**Autores:** Rafael Baena Mures (10), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Florencio García-Escribano Martín (21), Berta Pinilla Santos (21).

## ENFOQUE MIR

Se pregunta **siempre**, muy rentable. Sobre todo hay que centrarse en el síndrome confusional agudo. La pseudodemenia depresiva es el nombre que recibe una forma particular de presentación de la depresión, por medio de quejas cognitivas, y que es más frecuente de población anciana.

### 11.1. Delirium o síndrome confusional agudo

Síndrome neuropsiquiátrico de causa orgánica con inicio agudo y curso fluctuante, caracterizado por un trastorno de la conciencia y de otras funciones cognitivas (atención, orientación, memoria) y del pensamiento, psicomotricidad, humor y sueño-vigilia (**MIR**). El curso es limitado aunque en algunos casos puede dejar sintomatología residual.

#### Recuerda...

Es importante retener dos ideas: inicio agudo y alteración fluctuante del nivel de conciencia (**MIR 19, 189; MIR**).

## Etiología

Frecuentemente multifactorial. El delirium es secundario a un sufrimiento cerebral de origen primario (es decir, por afecciones propias del SNC como traumatismos, epilepsia o accidentes cerebrovasculares) o secundario (alteraciones metabólicas, infecciones, **tratamientos farmacológicos**). También se han identificado causas o precipitantes circunstanciales o ambientales como el dolor, los procedimientos invasivos o los cambios de ritmo digestivo.

#### CAUSAS MÁS FRECUENTES POR GRUPOS DE EDAD

|              |                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infancia     | Infecciones, intoxicaciones, traumas, epilepsia                                                                                                         |
| Adolescencia | Sustancias de abuso, TCE, posquirúrgico                                                                                                                 |
| Adultos      | Intoxicación y abstinencia, procesos médicos y quirúrgicos                                                                                              |
| Ancianos     | Enfermedades cerebrovasculares (sobre todo en lóbulo temporal y frontal), efectos secundarios de medicación a dosis terapéuticas ( <b>MIR 18, 183</b> ) |

Tabla 1. Causas de delirium por grupos de edad (**MIR**).

La **edad** y otros factores relacionados con **disminución de capacidad cognitiva** (historia de deterioro cognitivo, algunos trastornos psiquiátricos, historia de consumo de drogas, dependencia funcional) se consideran **predisponentes** (**MIR 22, 58**).

En el síndrome confusional agudo se produce una serie de cambios metabólicos cerebrales, con deterioro del metabolismo oxidativo neuronal y, por tanto, una disfunción de los diferentes sistemas de neurotransmisores. El neurotransmisor que parece tener mayor importancia es la **acetilcolina**, que ve reducida su síntesis y liberación; también disminuye la serotonina, aumenta la secreción de dopamina y se producen neurotransmisores neurotóxicos en mayor cantidad como el glutamato (**MIR 23, 153**).

#### Recuerda...

En el delirium es muy frecuente la etiología combinada. En el 44% de los casos, se registran 2,8 causas por paciente.

**Clínica** (**MIR 20, 85; MIR 20, 144; MIR 13, 167; MIR 12, 157; MIR 10, 66**)

- Existen dos patrones según la alteración de la conducta:
  - Hiperactiva: más frecuente, con agitación psicomotriz.
  - Hipoactiva: con confusión, somnolencia e inhibición motriz.
- Descenso del nivel de conciencia e inatención, con respuestas exageradas ante estímulos bruscos (**MIR**).
- Inversión del ciclo vigilia/sueño (somnolencia diurna, empeoramiento nocturno).
- Desorientación (**MIR**).
- Conforme se agrava el cuadro, aparece desestructuración del pensamiento (incoherente, enlentecido, ideas delirantes) y de la percepción (ilusiones y alucinaciones, sobre todo visuales) (**MIR**).
- El estado de ánimo oscila entre lo ansioso y lo depresivo.
- Alteraciones de memoria de cualquier índole: corto y largo plazo, paramnesias.

#### Regla mnemotécnica

El delirium es un **CAOS**  
Se afecta es el nivel de **Con**ciencia,  
la **A**tención y  
la **O**rientación



## Diagnóstico

- **Clínico:** las pruebas complementarias se dirigen al estudio de la o las causas. El EEG característico muestra un enlentecimiento generalizado de la actividad cerebral.

## Diagnóstico diferencial

Se establece con:

- Enfermedades psiquiátricas: manía, depresión, trastornos psicóticos, ansiedad...
- Enfermedades médicas: principalmente las que supongan lesión aguda de SNC.
- Demencia (MIR 24, 193; MIR).

|                          | DELIRIUM                       | DEMENCIA (MIR)      |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| INICIO                   | Brusco                         | Insidioso           |
| DURACIÓN                 | Días-semanas                   | Crónica             |
| CURSO A LO LARGO DEL DÍA | Fluctuante                     | Estable             |
| NIVEL DE CONCIENCIA      | Descendido y fluctuante        | Normal              |
| DESORIENTACIÓN           | Intensa y precoz               | En estadios tardíos |
| ATENCIÓN                 | Muy alterada                   | Poco alterada       |
| ALUCINACIONES            | Frecuentes                     | Raras               |
| AFFECTIVIDAD             | Temor, ansiedad, irritabilidad | Lábil               |
| CICLO SUEÑO-VIGILIA      | Alterado                       | Normal              |
| PSICO-MOTRICIDAD         | Hiperactivo o hipoactivo       | Normal              |
| MEMORIA                  | Alterada                       | Alterada            |
| PENSAMIENTO              | Alterada                       | Alterado            |

Tabla 2. Diagnóstico diferencial entre *delirium* y demencia.

## Epidemiología

La prevalencia es del 10-30% en pacientes hospitalizados y la mortalidad al año del episodio puede alcanzar el 50%. Es por tanto un factor de mal pronóstico evolutivo.

## Tratamiento

El *delirium* se resuelve cuando se resuelve la causa (o circunstancias precipitantes), generalmente en menos de 1 semana.

- Medidas no farmacológicas: se consideran beneficiosas las medidas que mejoran la orientación (relojes, buena iluminación, presencia de familiares), la actividad física estructurada (MIR), la repetición de frases sencillas, y minimizar aquellas intervenciones que pueden incrementar el miedo o la ansiedad, como la sujeción mecánica (MIR 12, 128). Sin embargo, en casos con gran agitación o agresividad, la **sujeción mecánica** está indicada (MIR).
- Medidas farmacológicas: antipsicóticos, de elección **haloperidol a dosis bajas**.

Las benzodiacepinas deben evitarse pues potencian la confusión y la depresión respiratoria (son únicamente de elección en el *delirium* por abstinencia alcohólica) (MIR).

### 11.2. Pseudodemencia depresiva. Diagnóstico diferencial con las demencias de causa orgánica (MIR 17, 186; MIR)

Es una forma de presentación de la depresión, principalmente en población de edad avanzada, y consiste en la queja por fallos cognitivos y en el funcionamiento habitual, sin que exista tal afectación o al menos no de la forma expuesta. La depresión asocia frecuentemente alteración en rendimiento cognitivo (atención, velocidad de procesamiento, ejecución) y cuando estos síntomas son lo más llamativo (bien sea por su predominio sobre los emocionales o como resultado de una sobrevaloración de minusvalía y torpeza) es cuando decimos encontrarnos ante una pseudodemencia depresiva.

El diagnóstico diferencial se realiza básicamente con la demencia y se fundamenta en un correcto estudio clínico. En ocasiones se requieren exploraciones complementarias (neuroimagen) o una evaluación neuropsicológica reglada.

El tratamiento se basa en fármacos **antidepresivos** (MIR 15, 155), con buena respuesta. Hay demencias que debutan con síntomas depresivos, pero el cuadro progresa de forma independiente a pesar de que exista una buena respuesta inicial a antidepresivo.

### 11.3. Clínica neuropsiquiátrica de la demencia

La clínica neuropsiquiátrica, también denominada síntomas psicológicos y conductuales de la demencia (SPCD), es un cortejo sintomático de aparición frecuente (60-90%) en los pacientes con deterioro cognitivo, incluso cuando éste es todavía leve. Su frecuencia e intensidad se relaciona con el grado de deterioro cognitivo. Su aparición suele ser más frecuente en la tarde y noche, lo que se conoce como **fenómeno del ocaso**.

Se trata de síntomas de diversa índole:

- Emocionales y del afecto, como ansiedad, irritabilidad o apatía (más frecuentes en las fases iniciales del proceso degenerativo).



- Alteraciones en el pensamiento, como delirios.
- Alteraciones de la percepción, como falsos reconocimientos y alucinaciones.
- Problemas conductuales, como accesos violentos o agitaciones.

El tratamiento es **inicialmente la prevención** y el abordaje conductual-ambiental, orientado a un adecuado cuidado sanitario general, control y modificación de estímulos.

En cuanto al tratamiento farmacológico, se elegirá en función del perfil sintomático; en caso de clínica psicótica o agitación se recomiendan fundamentalmente los **antipsicóticos a dosis bajas**, de preferencia los atípicos como la **risperidona** (único de ellos con indicación específica en nuestro entorno) (**MIR 20, 84**), quetiapina (de uso muy extendido) o aripiprazol.

|                                          | PSEUDODEMENCIA                | DEMENCIA                     |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>EVOLUCIÓN CLÍNICA E HISTORIA</b>      |                               |                              |
| <b>EDAD</b>                              | Cualquiera                    | >50                          |
| <b>INICIO</b>                            | Rápido (semanas)              | Lento (meses-años)           |
| <b>EVOLUCIÓN</b>                         | Rápida                        | Lentamente progresiva        |
| <b>CONSULTA A UN MÉDICO</b>              | Precozmente                   | Tardíamente                  |
| <b>HISTORIA FAMILIAR</b>                 | Antecedentes psiquiátricos    |                              |
| <b>QUEJAS Y EMOTIVIDAD</b>               |                               |                              |
| <b>PÉRDIDAS COGNITIVAS</b>               | Se queja de ellas             | No se queja                  |
| <b>DÉFICITS</b>                          | Los exagera                   | Los oculta                   |
| <b>ESFUERZO</b>                          | Escaso                        | Intenso                      |
| <b>SENTIMIENTOS</b>                      | Preocupación, sufrimiento     | Desinterés                   |
| <b>AFECTIVIDAD</b>                       | Se queja de tristeza          | Lábil                        |
| <b>HABILIDADES SOCIALES</b>              | Retracción social, se pierden | Mantenidas                   |
| <b>CONGRUENCIA CONDUCTA / GRAVEDAD</b>   | No                            | Sí                           |
| <b>EXACERBACIÓN NOCTURNA</b>             | No                            | Sí                           |
| <b>CAPACIDADES MENTALES / COGNITIVAS</b> |                               |                              |
| <b>ATENCIÓN</b>                          | Conservada                    | Alterada                     |
| <b>CONCENTRACIÓN</b>                     | Conservada                    | Alterada                     |
| <b>PÉRDIDA DE MEMORIA</b>                | Reciente y remota             | Reciente                     |
| <b>LAGUNAS DE MEMORIA</b>                | Sí                            | No                           |
| <b>RESPUESTAS TÍPICAS A PREGUNTAS</b>    | "No lo sé"                    | Equivocadas                  |
| <b>TESTS DE DIFICULTAD SIMILAR</b>       | Puntuación incongruente       | Puntuación incongruente      |
| <b>TEST DE PRIVACIÓN DEL SUEÑO</b>       | Mejoría                       | Empeoramiento ( <b>MIR</b> ) |

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre demencia y pseudodemencia depresiva.

## Tema 12

# Trastornos del sueño

**Autores:** Berta Pinilla Santos (21), Florencio García-Escribano Martín (21), Rafael Baena Mures (10), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33).

### ENFOQUE MIR

Poco preguntado. A pesar de ello, conviene familiarizarse con el ciclo del sueño normal y las parasomnias.

#### 12.1. Sueño normal (MIR 17, 41)

Durante el sueño normal se producen una serie de cambios a nivel del SNC, de la secreción hormonal y de la regulación de la temperatura corporal. El ciclo del sueño se divide en cinco fases.

El sueño **NO-REM** se considera el sueño reparador. La mayoría de funciones fisiológicas son marcadamente más bajas que durante la vigilia, y en sus fases (I, II, III, IV) la actividad encefalográfica es de ondas cada vez más lentas (mayor porcentaje de ondas delta). En la fase **REM** se recupera el ritmo encefalográfico ya muy similar a la vigilia, se producen los ensueños y se prepara al SNC para despertar.

La duración total de un ciclo de sueño es de unos 90 a 100 minutos. En la primera mitad de la noche predomina el sueño de ondas lentas (fases III y IV), con fases REM escasas y muy breves (<10 minutos). En la segunda mitad de la noche se acortan las fases lentas y se alarga el tiempo REM (fases más numerosas y largas: 15-40 minutos) progresivamente hasta llegar al despertar.

El ritmo del sueño varía con la edad. El recién nacido duerme hasta 20 horas al día, con una proporción de REM de hasta el 50% (MIR). Al avanzar la infancia disminuye el tiempo REM y se establece la estructura de primera y segunda mitad de noche característica del sueño adulto.

En los ancianos disminuye el porcentaje de sueño profundo a favor del superficial. Disminuye el tiempo de sueño nocturno, pero aparecen pequeñas siestas durante el día, con un tiempo total de sueño parecido al del adulto (MIR 17, 209).

La instauración más rápida del sueño REM (disminución del tiempo de latencia REM) es característica de:

- Depresión endógena.
- Narcolepsia.
- Trastornos del ritmo circadiano.

Los trastornos del sueño se dividen en:

- **Disomnias:** trastornos psicógenos que afectan la cantidad, calidad o duración del sueño. Insomnio, hipersomnia y trastornos del ciclo sueño-vigilia.
- **Parasomnias:** trastornos episódicos durante el sueño, más habituales en la infancia, como sonambulismo, terrores nocturnos y pesadillas.

|                             | EEG                                                                               | ACTIVIDAD MUSCULAR                              | TRASTORNOS ASOCIADOS                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VIGILIA</b>              | Bajo voltaje, actividad $\alpha$ con frecuencia mixta con los ojos cerrados       | Alta actividad tónica y movimientos voluntarios | Narcolepsia + (intrusión actividad REM)                                                                               |
| <b>FASE I</b>               | Bajo voltaje<br>Ondas vértice                                                     | Actividad tónica baja                           |                                                                                                                       |
| <b>FASE II</b>              | Bajo voltaje<br>Complejo K, husos del sueño                                       | Actividad tónica baja                           | Bruxismo                                                                                                              |
| <b>FASE III<br/>FASE IV</b> | Ondas lentas ( $\delta$ )                                                         | Actividad tónica baja                           | 1. Terrores nocturnos<br>2. Sonambulismo<br>3. En la depresión mayor: <b>se reducen</b> estas fases                   |
| <b>REM</b>                  | Bajo voltaje, frecuencia mixta (como en la vigilia)<br>Ondas en dientes de sierra | Atonía tónica                                   | 1. Pesadillas<br>2. Trastorno de conducta del sueño REM<br>3. En la depresión mayor: <b>se acorta la latencia REM</b> |

Tabla 1. Fisiología de sueño.

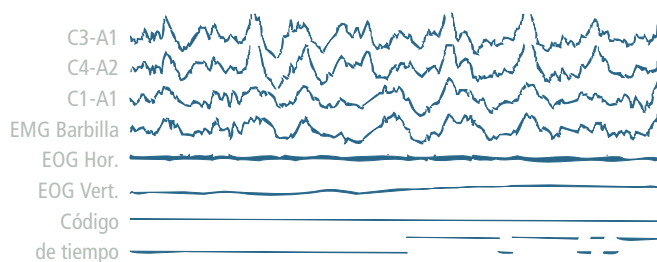


Figura 1. Registro del sueño.

## 12.2. Disomnias

### Insomnio

Es un problema extraordinariamente común, más frecuente en adultos y en ancianos, en mujeres y en pacientes psiquiátricos.

Se presenta en hasta un tercio de la población general.

El insomnio se asocia a numerosas enfermedades médicas y psiquiátricas.

Según su **presentación** puede ser:

- Insomnio **de conciliación**: cuando el sujeto tarda en empezar a dormir. Frecuente en trastornos de ansiedad.
- Insomnio **de mantenimiento** o sueño fragmentado: frecuentes despertares durante la noche tras los que cuesta mantener el sueño.
- Insomnio **terminal**, con despertar precoz: propio de la depresión endógena.

### Tratamiento

Si es un problema de breve duración o relacionado con circunstancias concretas, **medidas higiénicas**, que mejoren el entorno donde se duerme y dirigidas a normalizar el ciclo sueño-vigilia. Pueden darse en **periodos breves, benzodiacepinas** de vida media corta (**MIR 12, 198**).

Si se trata de un problema prolongado, lo adecuado es tratar la causa: depresión, enfermedades respiratorias,... En todos los casos se asociarán medidas higiénicas. Las benzodiacepinas e hipnóticos no están aconsejados a largo plazo.

### Narcolepsia (síndrome de Gelineau o narcolepsia-cataplejía)

Es una hipersomnia.

### Clínica

Los síntomas son la manifestación de intrusiones bruscas de sueño REM que no se precede de otras fases.

Se describen cuatro síntomas característicos:

1. Accesos de **sueño irresistible durante el día**, de breve duración. A veces se desencadenan con la risa.

2. **Cataplejía**: pérdida súbita del tono muscular, que puede ser parcial (p. ej., en maxilares) o generalizada, ocasionando caída al suelo. Respeta musculatura respiratoria y extraocular.
3. **Parálisis del sueño**: imposibilidad de movimiento voluntario de breve duración que aparece al despertar o más raramente al dormirse.
4. **Alucinaciones** al despertar (hipnopómpicas) o al dormirse (hipnagógicas). Más frecuentemente visuales.

### Regla mnemotécnica

- Las alucinaciones hipno**PON**PIEcas aparecen al **PON**erse en **PIE** (al despertar)
- Las alucinaciones hipn**ACO**gicas aparecen al **ACO**starse

Autor: Beni Gómez Rodríguez

Suele haber mala calidad de sueño nocturno y una historia previa de problemas de sueño de años de evolución.

### Epidemiología

La forma completa de la enfermedad es muy rara (0,02 a 0,05% en raza blanca).

La prevalencia es similar para mujeres que para hombres (**MIR**).

Se da con mayor frecuencia en personas jóvenes (menores de 30 años), en ocasiones secundario a una situación estresante.

### Etiología

Se relaciona con factores genéticos, asociándose a HLA DR2, al menos entre población caucásica.

### Diagnóstico

Se efectúa por la clínica, el análisis de HLA y la prueba de latencias múltiples durante el sueño (**polisomnografía**).

### Regla mnemotécnica

La narcolepsia se asocia a HLA-**DR2** porque los pacientes se pasan el día **DoRmiDOS**

### Tratamiento

- Derivados **anfetamínicos**, para impedir hipersomnia: metilfenidato, pemolina.
- **Antidepresivos tricíclicos**, para disminuir el sueño REM.
- **Modafinilo**, agonista Alfa-1, se utiliza como tratamiento específico por su acción tanto en la hipersomnia como en el sueño REM.

### Síndrome de Kleine-Levin

Hipersomnia que se da en varones adolescentes de causa desconocida.

Ciclos de días de duración que asocian la presencia de hipersomnia diurna, hiperfagia, hipersexualidad y trastornos de conducta. Son autolimitados y recurrentes. Puede haber alucinaciones.

Se ha usado el litio como **tratamiento**.

### 12.3. Parasomnias

#### Sonambulismo

Parasomnia del sueño profundo (fases 3 y 4); se asocia a terror nocturno o enuresis.

Se caracteriza por la presencia de actividad motora coordinada durante el sueño. El sujeto camina sin tener contacto con el ambiente. Puede hablar durante el sueño (somniaquios) (**MIR**). Aunque no reviste gravedad por sí, existe el riesgo de caídas y accidentes.

Es frecuente en la infancia. Más frecuente en varones. Se inicia entre los 6 y 12 años (**MIR**).

La resolución suele ser espontánea antes de los 20 años. Pueden darse **benzodiacepinas**, que actúan reduciendo las fases de sueño profundo.

#### Pesadillas

Ensueños desagradables o angustiosos, sin presentar síntomas vegetativos ni estupor (diferencia con el terror nocturno).

El sujeto sí recuerda el contenido al despertar.

Más frecuentes en el último tercio de la noche, siendo una parasomnia del sueño REM.

Muy frecuentes en niños. Se asocian a trastornos de ansiedad (trastorno por estrés postraumático) y afectivos en los adultos.

Si son muy persistentes pueden darse antidepresivos tricíclicos, que disminuyen el sueño REM.

#### Terrores nocturnos

Consiste en un episodio brusco de agitación, típicamente iniciado con un grito, con intensa angustia y **clínica vegetativa**: sudación, taquicardia, taquipnea.

El sujeto, al que cuesta despertar, **no recuerda nada** cuando le despiertan. Más habitual en el primer tercio de la noche (predominio de fases de sueño profundo) (**MIR**). No suelen darse varios episodios en la misma noche.

Suelen remitir espontáneamente durante la adolescencia.

Prevalencia: más frecuente en niños.

En adultos –y no en niños– pueden asociarse a periodos de ansiedad y estrés.

Pueden darse **benzodiacepinas**.

#### Regla mnemotécnica

##### TerroRES Nocturnos

Son **NO REM** (en sueño profundo),  
**NO** despiertan,  
**NO** recuerdan el episodio  
y se tratan con benzodiacepi**NO**s

|                             | PESADILLAS                                     | TERRORS NOCTURNOS                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MOMENTO DE LA NOCHE         | Al final (sueño REM)                           | Al principio (sueño $\delta$ )                             |
| AL DESPERTARSE              | Orientado y alerta, miedo                      | Desorientado, confuso, agitado, activación neurovegetativa |
| RECUERDA EL SUEÑO           | Sí                                             | No                                                         |
| VUELVE A CONCILIAR EL SUEÑO | Difícilmente (miedo)                           | Fácilmente                                                 |
| FACTORES DE RIESGO          | Acontecimientos vitales (estrés postraumático) | Periodos de ansiedad y estrés<br>Fiebre                    |
| TRATAMIENTO                 | Tricíclicos                                    | BZD                                                        |

Tabla 2. Características diferenciales entre las pesadillas y los terrores nocturnos.

#### Bruxismo

Se da en la fase II. Rechinar de dientes con roce mandibular, ocasiona desgaste dental y posibles fracturas dentarias y dolor. Se da en adultos.

**Tratamiento** con férulas maxilares que impiden el roce de las arcadas dentarias.



Figura 2. Paciente con bruxismo y férula de mordida inferior.

## Tema 13

# Trastornos de la personalidad

**Autores:** Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Florencio García-Escribano Martín (21), Rafael Baena Mures (10), Berta Pinilla Santos (21).

### ENFOQUE MIR

Quédate con el concepto general, y un poco más en profundidad en el caso del trastorno límite de personalidad.

La personalidad se define como la forma de experiencia interna y comportamiento de un individuo que surge de factores innatos y heredados (**temperamento**), y por la influencia del ambiente, entorno y cultura (**carácter**, fruto del aprendizaje y adaptación).

Se considera un **trastorno de la personalidad** cuando los diferentes elementos que la componen generan **problemas en el funcionamiento** por el hecho de ser **inflexibles y duraderos**, conduciendo a respuestas desadaptativas frente a un amplio abanico de situaciones sociales y relacionales. Son desviaciones extremas de las formas de pensar, sentir y, sobre todo, relacionarse con los demás (**MIR**). Precisamente, las claves para su diagnóstico son que los rasgos desadaptativos se manifiesten en diversos ámbitos de la vida, y que sean duraderos e inflexibles.

Su inicio puede remontarse a la adolescencia pero su **diagnóstico** acostumbra a realizarse en la **edad adulta**. Según criterios DSM, es posible encontrar clínica psicótica en el trastorno esquizotípico (que de hecho se considera dentro del espectro de la esquizofrenia en esta clasificación) y en el trastorno límite de la personalidad (síntomas disociativos o paranoides en situaciones de disregulación extrema).

Clásicamente se han dividido en **clusters**; de esta manera se recogen en el DSM 5 y suelen entenderse en la práctica (**ver a continuación**). Sin embargo, la CIE 11 cambia un tanto la aproximación y le da importancia a la gravedad del mismo.

### 13.1. Trastornos de la personalidad grupo A

Sujetos extraños, excéntricos, tienden a aislarse. Existe agregación genética y características clínicas compartidas con las psicosis. Más frecuentes en hombres que en mujeres.

#### Trastorno paranoide de personalidad

Sujetos desconfiados, **suspicaces**, siempre dispuestos a interpretar las relaciones en clave de perjuicio o como agresiones. Hipersensibles a agravios, rencorosos, posesivos. A menudo sienten su entorno como plagado de “conspiraciones” sin fundamento (**MIR**). Sospecha recurrente de infidelidad de la pareja.

La prevalencia se estima entre 2,5-4,4%. Relación con trastorno por ideas delirantes.

#### Trastorno esquizoide de personalidad

Son sujetos **aislados socialmente, sin interés** alguno por establecer contacto con los demás. Se sienten ajenos a las otras personas. Prefieren las actividades solitarias y son emocionalmente fríos e indiferentes. Les cuesta entender a los demás y establecer relaciones (**MIR 10, 150**). Se relaciona genética y clínicamente con la esquizofrenia. Prevalencia en población general de 0,5-2%.

#### Trastorno esquizotípico de personalidad

Se caracteriza por dificultades en la relación social –el sujeto quiere relacionarse, pero no consigue hacerlo de forma eficaz– asociado a **rasgos próximos a los de las psicosis**: tendencia a las ideas de referencia, creencias raras o pensamiento mágico, experiencias perceptivas inhabituales (ilusiones), pensamiento y lenguajes raros, suspicacia paranoide (**MIR**).

Son en general sujetos excéntricos, **peculiares**, desconfiados, con gusto por temas esotéricos o sobrenaturales, con dificultades para establecer y mantener relaciones. Pueden parecer tímidos o torpes.

La prevalencia general es del 3-5%.

Está muy próximo a la esquizofrenia. En el DSM-5 y el CIE-10 no se engloba entre los trastornos de personalidad sino entre los trastornos psicóticos.

### 13.2. Trastornos de la personalidad grupo B

Sujetos inestables e inmaduros, conflictivos. Comorbilidad frecuente con trastornos afectivos, de consumo de sustancias y somatomorfos.

#### Trastorno antisocial de personalidad

Llamado también psicopatía, sociopatía o trastorno disocial.

Consiste en un funcionamiento basado en la **irresponsabilidad**, impulsividad y tendencia a conductas de riesgo, con inclinación a la transgresión de la norma. Relacionado con conductas violentas y delictivas. Es característica la falta de empatía, la frialdad emocional y la **incapacidad para sentir remordimientos** (**MIR 16, 221**). Sus relaciones personales se basan en el engaño, **manipulación** y deseo de explotación del otro.



La mentira, las faltas injustificadas a clase, la huida del hogar, los robos, las riñas, el abuso de sustancias y la participación en actividades ilegales son experiencias habituales desde la infancia.

Es más frecuente en hombres (3%) que en mujeres (1%). Muy frecuente entre poblaciones reclusas.

Mayor prevalencia en medio urbano y estrato socioeconómico bajo.

### Trastorno límite de la personalidad

Lo fundamental es la **inestabilidad**, especialmente afectiva y también en las relaciones, con cambios rápidos y extremos entre la idealización y la devaluación, el amor entusiasta y el odio, la euforia y la ira (**MIR 14, 219; MIR 12, 156**).

Distorsionan sus relaciones porque consideran a las personas excesivamente buenas o absolutamente malas.

Su autoimagen es variable. Su estado de ánimo puede cambiar bruscamente. Puede haber episodios psicóticos breves. Son impulsivos y tienden a los gestos suicidas, a las autoagresiones y a trastornos por abuso de sustancias. La conducta autodestructiva tiene carácter movilizador o para canalizar el malestar. Se considera indicación de ingreso psiquiátrico las crisis con repercusión grave en la vida o en el entorno del paciente, con peligro para sí mismo (impulsividad, gestos suicidas) o para su entorno (**MIR**).

Las hipótesis sobre su génesis dan importancia a la existencia de antecedentes de trauma infantil. Presenta también importante comorbilidad con el trastorno de estrés postraumático.

Existen importantes hallazgos biológicos como alteraciones del eje hipotálamohipofisario adrenal, disminución de la MAO plaquetaria y disminución de la 5-HIAA.

La prevalencia oscila entre el 2 y 6% de la población general. Es más frecuente o diagnosticado en mujeres; se observa en el 10% de pacientes que realizan seguimiento psiquiátrico y en el 20% de los ingresos psiquiátricos.

### Trastorno histriónico de personalidad

Caracterizado por una **emotividad excesiva y necesidad de atención**. Tendencia al dramatismo, teatralidad, seducción y erotización de las relaciones. Búsqueda de aprobación, influenciabiles.

Prevalencia aproximada del 2%, quizá más frecuente en mujeres (posible sesgo diagnóstico).

### Trastorno narcisista de la personalidad

Basado en una **autoimagen grandiosa** y autoestima exagerada, con **egocentrismo** extremo que limita o impide la empatía y toma de consideración hacia los sentimientos de los demás, que son considerados inferiores. Fantasía y focalización en el éxito y **admiración externa**; suelen ser arrogantes, pretenciosos, envidiosos y con baja tolerancia a la frustración.

Prevalencia incierta, de menos del 1% al 6% de la población.

## 13.3. Trastornos de la personalidad grupo C

Sujetos tímidos, inseguros, tendentes a la pasividad. Se relacionan con los trastornos de ansiedad.

### Trastorno evitativo de la personalidad

Su característica fundamental es la **inhibición social**. **Desean establecer relaciones** pero se sienten inseguros y temerosos de ser rechazados o ridiculizados. Tienen baja autoestima. Evitan cualquier situación que implique riesgo.

Se relaciona con la fobia social. La prevalencia general es del 0,5-1%. No hay diferencias de género.

### Trastorno dependiente de la personalidad

Sujetos **sumisos**, muy **inseguros**, que buscan la adhesión a una figura en la que delegan la capacidad de decisión y las responsabilidades y en la que se refugian. Muy ansiosos en situaciones que impliquen compromiso social. Dificultades en el autocuidado, la autonomía personal y el trabajo. Se relaciona con el trastorno de ansiedad por separación de la infancia. Aunque se ha diagnosticado más en mujeres no parece haber diferencias de género.

### Trastorno obsesivo o anacástico de personalidad (**MIR 24, 84**)

El funcionamiento se caracteriza por una necesidad de orden y perfección. Son personas cognitivamente rígidas, escrupulosas, excesivamente moralistas y avaras (**MIR 16, 218**). Se relaciona con excesiva dedicación al trabajo e incapacidad para delegar, tienden a corregir al resto. La prevalencia estimada es del 2% al 8%.

| GRUPO A<br>(RAROS, EXTRAÑOS)             | GRUPO B<br>(INESTABLES EMOCIONALES)                            | GRUPO C<br>(ANSIOSOS, TEMEROSOS)     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Paranoide<br>Esquizoide<br>Esquizotípico | Antisocial<br>Límite (borderline)<br>Histriónico<br>Narcisista | Evitativo<br>Dependiente<br>Obsesivo |

Tabla 1. Trastornos de la personalidad.



# Trastornos de la infancia y adolescencia

**Autores:** Florencio García-Escribano Martín (21), Berta Pinilla Santos (21), Rafael Baena Mures (10), Ezequiel Jesús Pérez Sánchez (33), Rubén Galerón Guzmán (44).

### ENFOQUE MIR

Se han preguntado poco hasta el momento, pero con la aparición de la nueva especialidad de psiquiatría infanto-juvenil se prevé un aumento de preguntas. Los trastornos más importantes son TDAH y TEA.

### Recuerda...

En el DSM-5 y en la CIE-11 existe una categoría diagnóstica llamada "Trastornos del neurodesarrollo", que engloba aquellas enfermedades que tienen un inicio precoz en la infancia y que van a tener una importante repercusión en el desarrollo de la persona: discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, trastornos del espectro autista, TDAH, trastornos específicos del aprendizaje (dislexia y discalculia), trastornos motores y trastornos de tics (incluido el trastorno de Gilles de la Tourette).

### 14.1. Discapacidad intelectual (DSM-V) o trastorno del desarrollo intelectual (CIE-11)

Grupo de afecciones etiológicamente diversas, caracterizadas por estos tres criterios:

- Limitaciones significativas de las funciones intelectuales respecto al promedio.
- Deficiencias significativas en el comportamiento adaptativo respecto al promedio.
- Aparición de las deficiencias durante el periodo de desarrollo (**antes de los 18 años**).

En individuos menores de 5 años se usa el término de retraso global del desarrollo.

La prevalencia se estima en torno al 1-3% de la población.

### Etiología

Muy variada. Lo más frecuente es que sea desconocida. Dentro de las causas conocidas, las causas pueden ser genéticas (alteraciones cromosómicas, metabolopatías), adquiridas durante el embarazo y parto (rubeola, exposición a drogas, sífilis) y adquiridas durante la infancia (infecciones, traumatismos craneoencefálicos, hipoxia).

### Clínica

Los pacientes con discapacidad intelectual presentan pobreza de lenguaje, pensamiento, abstracción, autocuidado, interacción social, aprendizaje, etc.

Pueden presentar con frecuencia trastornos de conducta y agresividad.

De forma comórbida pueden asociarse trastornos del estado de ánimo, trastornos con déficit de atención e hiperactividad y estereotipias (repetición constante de movimientos y gestos). Los trastornos del humor se expresan a menudo como irritabilidad y agitación.

### Diagnóstico

Para el diagnóstico se exige que se cumplan los tres criterios que definen a este trastorno (limitación de funciones intelectuales, deficiencias en el comportamiento adaptativo, y aparición antes de los 18 años).

Es posible el empleo de pruebas de inteligencia estandarizadas. La más empleada es la escala de Weschler, en su versión para adultos (WAIS: 17-64 años) y de niños (WISC: 6-16 años).

Dichas pruebas traducen un valor numérico conocido como cociente intelectual o CI. Según dicho CI, se distinguen varias categorías de discapacidad intelectual:

#### CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CIE 10)

##### CI entre 50-69: discapacidad intelectual leve

Sujetos capaces de autocuidado y de aprendizaje en niveles poco avanzados.

##### CI entre 35-49: discapacidad intelectual moderada

Sujetos con graves defectos de aprendizaje, aunque pueden recibir formación muy básica. Necesitan ayuda en tareas de autocuidado, aunque pueden llevar a cabo por sí mismos la mayoría.

##### CI entre 20-34: discapacidad intelectual grave

Grave déficit de aprendizaje, limitado a pocas habilidades básicas. Déficit severo en autocuidado.

##### CI <20: discapacidad intelectual profunda

Escasísima o nula capacidad de aprendizaje. Dependencia completa de terceras personas para cualquier cuidado.

Tabla 1. Categorías de discapacidad intelectual según CIE-10.

En la actualidad, las categorías en el DSM-5 no se rigen por CI sino por funcionamiento adaptativo. En el caso de la CIE-11 se tiene en cuenta tanto el funcionamiento adaptativo como el CI medidos en desviaciones estándar respecto a la media (leve:  $\geq 2$ ; moderado: entre 3 y 4; grave y profundo:  $>4$ , distinguiéndose entre grave y profundo por las diferencias de comportamiento adaptativo).

### Tratamiento

- Fundamentalmente de rehabilitación y psicoeducativo.
- Si hay agitación, de elección antipsicóticos (**MIR**).
- Pueden usarse antidepresivos en trastornos del estado de ánimo, en retrasos leves y moderados.

## 14.2. Trastornos del espectro autista

### Recuerda...

En el DSM-5 y en la CIE-11, aparece por primera vez la categoría de **"trastornos del espectro autista (TEA)"**, la cual engloba los antiguos diagnósticos de: autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett y trastorno desintegrativo infantil, y no se hacen diferencias entre ellos. Además, se deben añadir los siguientes especificadores, si proceden: con déficit intelectual acompañante; con deterioro del lenguaje acompañante; asociado a una afección médica/genética u otro trastorno del neurodesarrollo; o con catatonia.

### Regla mnemotécnica

#### Trastornos que producen una pérdida progresiva de las habilidades adquiridas por el niño

En el síndrome **DESINTEGRATIVO** infantil existe una **DESINTEGRACIÓN** de las habilidades adquiridas por el niño.

En el síndrome de **RETT**, además, se produce una **RETT**ención del crecimiento del cráneo.

### Epidemiología

Son más frecuentes en **niños** que en niñas (**MIR**). La prevalencia aproximada es del **1%**. Es un trastorno con una contribución hereditaria significativa; es frecuente en contexto de síndromes genéticos (síndrome del cromosoma X frágil, esclerosis tuberosa) y metabopatías (fenilcetonuria). También está asociado con factores prenatales (padres de edad avanzada) y perinatales (hipoxia, rubeola congénita).

### Clínica

Las alteraciones en este grupo de trastorno se evidencian principalmente en dos ámbitos:

- Comunicación social: alteraciones de la comunicación a nivel verbal y no verbal y, por tanto, dificultades significativas para el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales.
- Conductas limitadas y repetitivas: patrón restringido de conductas, intereses y actividades.

A nivel verbal, pueden evidenciarse las siguientes alteraciones: alteración de la pragmática del lenguaje (más frecuente), inversión pronominal, ecolalias, frases estereotipadas, dificultades en la articulación verbal, mutismo y empleo de neologismos.

También aparecen deficiencias en la reciprocidad emocional (la capacidad para interactuar y compartir emociones y sentimientos), evidentes desde muy temprano. En cuanto a las relaciones sociales, es frecuente que los niños no presenten juego imaginativo o simbólico y que se ciñan a las reglas de forma inflexible. En los adultos, es frecuente la dificultad para entender qué comportamientos son

apropiados para cada situación o los diferentes usos del lenguaje (ironía, bromas...), así como inferir los estados emocionales de los otros (teoría de la mente).

En cuanto a las conductas repetitivas, se incluyen: estereotipias (repetición reiterada de un acto que carece de finalidad (**MIR 15, 153**): aleteo de manos, movimientos de balanceo...), manierismos, uso repetitivo de objetos (girar monedas, alinear juguetes), la inflexibilidad de rutinas y resistencia a los cambios. También es frecuente una restricción en los intereses (líneas de metro). Los niños con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual grave presentan marcadas conductas autolesivas y autoestimuladoras.

La asociación con **discapacidad intelectual es muy frecuente**, aunque algunos sujetos desarrollan hipertrofia de alguna capacidad concreta (**MIR**): dibujo, música, memoria, matemáticas...

También puede aparecer una respuesta alterada a estímulos sensoriales (p.ej.: molestia marcada ante estímulos sonoros neutros o escasa tolerancia a determinadas texturas de alimentos); algunos sujetos presentan una respuesta alterada al dolor.

### Diagnóstico

El diagnóstico es **clínico**, pero existen escalas útiles para realizar la evaluación (SCQ, ADI, ADOS), así como una escala de screening (M-CHAT).

### Tratamiento

Está básicamente dirigido a la **educación** y es fundamental la **intervención temprana** (**MIR 15, 177**). Los psicofármacos se emplean ante la aparición de trastornos de conducta (risperidona, aripiprazol), trastornos del estado de ánimo (ISRS) o insomnio (melatonina).

## 14.3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

### Epidemiología

Se trata de un trastorno del desarrollo muy prevalente (afecta al **5%** de los niños) (**MIR**). Es mucho más frecuente en varones (9:1).

### Etiología

- Factores genéticos. Heredabilidad del 75%, agregación familiar.
- Factores neuroquímicos. Disfunciones cerebrales mínimas, de posible origen perinatal. Existe hipofunción en la transmisión dopaminérgica, sobre todo frontal-talámica. También existe una alteración del sistema noradrenérgico a nivel central (locus cerúleo), y adrenérgico a nivel periférico.

- Factores evolutivos. Prematuridad, infecciones durante el embarazo, lesiones cerebrales tempranas (infecciones, traumatismos, inflamación).
- Factores psicosociales. El abuso crónico grave, el maltrato y la falta de cuidados se asocian con determinados síntomas conductuales que se superponen con el TDAH.

## Clínica

### Recuerda...

En el DSM-5 y en la CIE-11, se exige que los síntomas del TDAH hayan comenzado **antes de los 12 años**. Esto es un cambio importante respecto a las versiones previas de los manuales diagnósticos.

Se caracteriza por una serie de alteraciones en el comportamiento infantil, que, según su predominancia, dan lugar a los 3 subtipos de TDAH:

1. **TDAH de predominio inatento:** el niño no se concentra, se distrae, pierde objetos, no acaba sus tareas, parece como si le costase escuchar.
2. **TDAH de predominio hiperactivo-impulsivo.** Hiperactividad: tiende a moverse continuamente, correr y saltar. Impulsividad: actúa de forma apresurada, contesta sin dejar terminar la pregunta, actúa sin pensar, de manera a veces peligrosa y sin calibrar el riesgo. Puede ser agresivo con sus compañeros.
3. **TDAH mixto.** Combina la sintomatología previamente descrita.

Para que se pueda hacer el diagnóstico, esta sintomatología debe estar presente en 2 o más áreas (casa, colegio, ocio, etc.).

## Comorbilidad

Es muy frecuente la asociación con otros trastornos del aprendizaje (lectura, escritura o matemáticas), trastornos de conducta (trastorno negativista desafiante, trastorno disocial), trastornos de ansiedad y trastornos afectivos (depresión), como consecuencia de sus dificultades escolares y sociales.

## Evolución

Variable. Los síntomas persisten en la adolescencia en el 60-85%, y en la vida adulta en el 60%. Habitualmente, la hiperactividad es el primer síntoma en remitir y la inatención el último. En caso de persistir en edad adulta, es frecuente la comorbilidad con trastorno de personalidad antisocial y abuso de sustancias.

## Tratamiento (importante)

Fármacos estimulantes: **metilfenidato (primera elección)** (MIR 18, 206; MIR 12, 162) y lisdexanfetamina (segunda elección). Ambos son derivados anfetamínicos, y por tanto psicoestimulantes simpaticomiméticos. Sus efectos secundarios principales son cardiovasculares, por lo que antes de comenzar tratamiento se debe realizar exploración física y medición de TA y FC. Además, administrados crónicamente pueden producir un retraso en el crecimiento, por lo que es necesario registrar el peso y la talla al iniciar el tratamiento y realizar un seguimiento regular (MIR 11, 145).

Fármacos no estimulantes: atomoxetina (tiene acción noradrenérgica y es de tercera elección) y guanfacina (acción adrenérgica).

Antiguamente se aceptaba el uso de antidepresivos tricíclicos en el tratamiento, pero hoy en día no se utilizan.

Los sedantes y tranquilizantes están **contraindicados** (MIR).

Los antipsicóticos pueden ser eficaces en aquellos casos en los que predominan las alteraciones de conducta.

En todos los casos debe utilizarse la psicoterapia cognitivo-conductual, con técnicas de reeducación.

## 14.4. Trastornos del lenguaje

Se definen como dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje a través de las diferentes modalidades, debido a déficits en comprensión y/o producción. Incluyen las siguientes manifestaciones:

1. Vocabulario reducido (conocimiento y uso de palabras).
2. Limitada estructura de las frases (aptitud para juntar las palabras y la terminación de las palabras para formar frases basadas en las reglas de la gramática y la morfología).
3. Errores en el discurso (aptitud para usar el vocabulario y frases correctas para explicar o describir un tema o una serie de acontecimientos o tener una conversación).

El inicio de los síntomas ha de producirse en un momento temprano del desarrollo (etapa pre-escolar).

## 14.5. Trastornos del aprendizaje

Se basan en una dificultad en el aprendizaje y en las aptitudes académicas, y por tanto se diagnostican en edad escolar. Existen una mayor prevalencia de este trastorno en niños que en niñas. Existen 3 subtipos:

1. Dislexia: dificultades en la lectura, es el más frecuente (75%).
2. Disgrafía: dificultades en la expresión escrita.
3. Discalculia: dificultad en las matemáticas.

## 14.6. Trastornos de la eliminación

### Enuresis

Déficit de aprendizaje de control del esfínter urinario. Sólo se diagnostica a partir de los 5 años (MIR).

#### Etiología

- Agregación familiar, con mayor concordancia en gemelos monocigóticos.
- Causas orgánicas, como defectos en esfínter, uretra, etc.
- Trastornos de ansiedad, reacciones de estrés o trastornos del humor en los niños pueden cursar con enuresis.

#### Clínica

- Enuresis **primaria**: nunca se ha conseguido un control efectivo del esfínter.
- Enuresis **secundaria**: ha existido al menos 1 año de control antes del trastorno.

Ambas pueden ser nocturnas (mucho más frecuentes) o diurnas, que aparecen más como problemas de urgencia miccional.

#### Tratamiento

Es frecuente la desaparición espontánea.

El aprendizaje basado en el **condicionamiento** (despertadores con alarma, cuando hay pérdida nocturna) y en el **refuerzo positivo** es eficaz.

Pueden usarse en periodos cortos **antidepresivos tricíclicos** (por su efecto anticolinérgico) o **desmopresina** (DDVAP) **intranasal**.

### Encopresis

Déficit de aprendizaje de control del esfínter anal. Solo se diagnostica a partir de los 4 años de edad.

#### Clínica

- Encopresis **retentiva**: asociada a estreñimiento, se producen pérdidas fecales por rebosamiento. Suele haber causas orgánicas.
- Encopresis **no retentiva**: más frecuente. Puede darse solo en situaciones de estrés importante o bien de forma continua, más a menudo nocturna.

#### Tratamiento

Los tratamientos educativos y dirigidos a disminuir el estrés son eficaces.

## 14.7. Trastornos de tics

### Trastorno de Gilles de la Tourette (MIR 17, 189)

#### Clínica (MIR)

- **Tics motores**: simples o complejos.
- **Tics verbales** (repetir determinadas palabras) o **bucofonatorios** (toses, gruñidos). Los tics bucofonatorios se han considerado patognomónicos de este trastorno (MIR 12, 78), pero no es así, dado que existe dentro de la clasificación DSM-5 un trastorno por tics motores o vocales crónicos, que presenta dichos tics sin el resto de características del síndrome de Gilles de la Tourette.
- **Coprolalia**: emisión brusca de palabras soeces.

Suele iniciarse con tics faciales, orales o mandibulares a los 6-7 años de edad como tics motores simples, posteriormente desarrollan tics motores complejos. Los tics vocales simples (carraspeo, suspiros) comienzan alrededor de los 8-9 años, y la coprolalia suele aparecer en la adolescencia.

El resistir el impulso del tic cuesta un gran esfuerzo y causa a veces un aumento de los mismos.

La comorbilidad es frecuente con TDAH (50%) y TOC (40%). Tienden a cronificarse aunque los síntomas se atenúan con el crecimiento.

El 50% tiene secuelas sociales y fracaso escolar.

#### Epidemiología

Varones 3:1. Inicio antes de los 18 años.

#### Etiología

Genética (autosómico dominante).

Hiperfunción dopaminérgica.

#### Tratamiento

- Fármacos.
  - De elección, **antipsicóticos**.
  - **Antidepresivos** tricíclicos e ISRS si hay comorbilidad con TOC.
- Técnicas psicoterapéuticas de **modificación de conducta**.

## 14.8. Trastornos de ansiedad infantiles

### Trastorno de ansiedad por separación

Se calcula que la prevalencia aproximada del trastorno en niños y adolescentes jóvenes es del 5%. Este trastorno es más frecuente en niños pequeños que en adolescentes e incide en ambos sexos por igual. Se puede iniciar a la edad preescolar aunque suele hacerlo entre los 7 y 8 años de edad.

**Clínica** de angustia y ansiedad cuando se produce la separación del niño de las figuras familiares, especialmente la madre. Pueden experimentar una preocupación exagerada por la pérdida de las figuras de apego y por la posibilidad de que un suceso adverso pueda provocar la separación de una de las principales figuras de apego, por lo cual pueden desarrollar reticencia a ir a la escuela o a cualquier sitio por temor a la separación.

En la edad adulta puede desarrollar un trastorno de personalidad por dependencia y evitación.

El **tratamiento** se realiza con psicoterapia que implica a madre e hijo.

### Mutismo selectivo

Rechazo a hablar con personas que no sean familiares al niño. En la edad adulta puede desarrollar fobia social.

# Valores normales en Psiquiatría

| CONCEPTO                                   | VALORES NORMALES |
|--------------------------------------------|------------------|
| Duración Episodio Depresivo Mayor          | ≥2 semanas       |
| Duración Episodio Maníaco                  | ≥1 semana        |
| Duración Distimia                          | ≥2 años          |
| Duración Hipomanía                         | ≥4 días          |
| Cociente GOT/GPT (alcoholismo)             | ≥2               |
| Latencia efecto antidepresivo              | 4-6 semanas      |
| Litemia mantenimiento                      | 0,6-1,2 mEq/l    |
| Litemia rango óptimo                       | 0,8-1,2 mEq/l    |
| Litemia fase aguda                         | 1,0-1,5 mEq/l    |
| Litemia ventana terapéutica                | 0,4-1,5 mEq/l    |
| Litemia intoxicación potencialmente mortal | ≥2,5 mEq/l       |

Tabla 1. Valores normales en Psiquiatría.



# Reglas mnemotécnicas

## Psiquiatría

### Regla mnemotécnica

#### Síntomas negativos de esquizofrenia

Las **A**:

**A**patía  
**A**bulia  
**A**logia  
**A**nhedonia  
**A**planamiento afectivo  
**A**tención disminuida  
**A**utismo  
**A**islamiento social (pérdida de funcionamiento social)

### Regla mnemotécnica

En la esquizofrenia **P**aranoide predominan síntomas **P**ositivos, y es **P**ositivo tener este tipo de esquizofrenia (mejor pronóstico).

*Autora: Cintia Viktória Rétháti*

### Regla mnemotécnica

La **O**lanzapina y el resto de antipsicóticos atípicos producen **O**besidad y síndrome metabólico.

La **C**lozapina produce **C**itopenia en la serie blanca (agranulocitosis).

**A**ripiprazol es el único antipsicótico **A**gonista dopaminérgico.

### Regla mnemotécnica

El **Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)** se caracteriza por 3 cosas:

**S**uperfiebre  
**N**ivel de consciencia alterado  
**A**fectación **M**uscular (rigidez, hipertonía, CPK)

### Regla mnemotécnica

#### Orden de frecuencia (de mayor o menor) de riesgo de suicidio según patologías psiquiátricas

**DESI** fue a **ALCOH**ete ya que **ESTUVO ANTES AL LÍMITE** del suicidio (Alcohete es un hospital psiquiátrico de Guadalajara)

**DE**presión p**SI**cótica  
**ALCOH**olismo  
**ES**quizofrenia  
**A**norexia **N**erviosa  
Trastorno **Antisocial** de personalidad  
Trastorno **LÍMITE** de personalidad

### Regla mnemotécnica

#### Antidepresivos tricíclicos que se usan en ancianos

**DESI MIRA** al **NORTE**

**DESI**mipramina  
**MI**Anerina  
**NORT**riptilina

### Regla mnemotécnica

*El bupropion es muy propio*

Es un antidepresivo que solo tiene indicación en España para dejar el tabaco, no tiene nada que ver con el resto. Mecanismo de acción dopaminérgico y noradrenérgico:

**NADA** de tabaco  
**Nor**Adrenalina  
**Dop**Amina

### Regla mnemotécnica

*Si **TIC** no **TEC***

La **T**ensión **I**ntra**C**raneal aumentada contraindica la **T**erapia **E**lectro**C**onvulsiva

### Regla mnemotécnica

#### Benzodiacepinas de vida media ultracorta

Se **MID**en en un **TRI**s

**MID**azolam  
**TRI**azolam

#### Benzodiacepinas de vida media corta:

**AL LOROX** con el **TEMA**

**AL**prazolam  
**LOR**acepam  
**OX**acepam  
**TEMA**cepam

### Regla mnemotécnica

#### Hipnóticos puros o inductores del sueño (**ZZZ**...)

**Z**olpidem  
**Z**opiclona  
**Z**aleplon

# Reglas mnemotécnicas

## Psiquiatría

### Regla mnemotécnica

*El delirium es un **CAOs***  
Se afecta es el nivel de **C**onsciencia,  
la **A**tención y  
la **O**rientación

### Regla mnemotécnica

**TerroRES NOcturnos**  
Son **NO REM** (en sueño profundo),  
**NO** despiertan,  
**NO** recuerdan el episodio  
y se tratan con benzodiazepi**NOs**

### Regla mnemotécnica

- Las alucinaciones hipno**PONPIE**cas aparecen al **PON**erse en **PIE** (al despertar)
- Las alucinaciones hipn**ACO**gicas aparecen al **ACOS**tarse

*Autor: Beni Gómez Rodríguez*

### Regla mnemotécnica

**Trastornos que producen una pérdida progresiva de las habilidades adquiridas por el niño**

En el síndrome **DESINTEGRATIVO** infantil existe una **DESINTEGRACIÓN** de las habilidades adquiridas por el niño.

En el síndrome de **RETT**, además, se produce una **RETT**ención del crecimiento del cráneo.

### Regla mnemotécnica

La narcolepsia se asocia a HLA-**DR2** porque los pacientes se pasan el día **DoRmiDOS**

# Bibliografía

Asociación Española de Neuropsiquiatría, Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. (2017). VVAA. *Manual del Residente en Psiquiatría*. (3.ª edición) ENE Life, 2017.

Gelder, M.G., López-Ibor, J.J., Andreasen, N. (2003). *Tratado de Psiquiatría*, 1.ª edición. Ars Medica, 2003.

Sadock, B. J, Sadock V. A., Ruiz, P. (2015). *Kaplan & Sadock - Sinopsis de psiquiatría*. (11.ª edición). Wolters Kluwer-Lippincott Williams & Wilkins.

Vallejo-Ruiloba, J. (2015). *Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría*. (8.ª edición). Elsevier, 2015.



Sedes  
**AMIR**



---

**FILIACIÓN PROFESIONAL  
DE AUTORES**

- (1) H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid.
  - (2) H. U. La Paz. Madrid.
  - (3) H. U. Severo Ochoa. Madrid.
  - (4) H. U. Virgen del Rocío. Sevilla.
  - (5) H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
  - (6) Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Murcia.
  - (7) H. Infanta Cristina. Parla, Madrid.
  - (8) H. C. San Carlos. Madrid.
  - (9) H. U. 12 de Octubre. Madrid.
  - (10) H. U. Fundación Alcorcón. Alcorcón, Madrid.
  - (11) H. Clínic. Barcelona.
  - (12) H. U. de Fuenlabrada. Fuenlabrada, Madrid.
  - (13) H. U. i Politècnic La Fe. Valencia.
  - (14) H. Vithas Nuestra Señora de América. Madrid.
  - (15) H. U. de Getafe. Getafe, Madrid.
  - (16) H. U. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
  - (17) H. U. Doctor Peset. Valencia.
  - (18) H. U. Rey Juan Carlos. Móstoles, Madrid.
  - (19) H. U. Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid.
  - (20) H. Can Misses. Ibiza.
  - (21) Psiquiatra en ámbito privado. Madrid.
  - (22) Centre d'Ophtalmologie Sainte Odile. Alsacia, Francia.
  - (23) Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.
  - (24) H. U. Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes, Madrid.
  - (25) H. U. San Juan de Alicante. Alicante.
  - (26) H. Moisés Broggi. Sant Joan Despí, Barcelona.
  - (27) H. U. de Basurto. Bilbao.
  - (28) H. Virgen de los Lirios. Alcoy, Alicante.
  - (29) H. U. Central de Asturias. Oviedo.
  - (30) H. U. Vall d'Hebron. Barcelona.
  - (31) H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
  - (32) H. U. Infanta Elena. Valdemoro, Madrid.
  - (33) Salud Mental Brians 2, PSSJD. Barcelona.
  - (34) H. C. U. Lozano Blesa. Zaragoza.
  - (35) H. U. La Princesa. Madrid.
  - (36) H. G. U. de Alicante. Alicante.
  - (37) Directora Academic & Innovation, AMIR.
  - (38) H. U. de Torrejón, Torrejón de Ardoz, Madrid y H. HM Puerta del Sur, Móstoles, Madrid.
  - (39) H. C. U. de Valladolid. Valladolid.
  - (40) H. Infantil U. Niño Jesús. Madrid.
  - (41) Children's Hospital of Philadelphia. Philadelphia, Pensilvania, EEUU.
  - (42) H. U. de Torrejón. Torrejón de Ardoz, Madrid.
  - (43) Instituto Médico y Quirúrgico del Aparato Digestivo IMEQ. Madrid.
  - (44) H. U. Infanta Leonor. Madrid.
  - (45) H. U. del Henares. Coslada, Madrid.
  - (46) H. G. U. Gregorio Marañón, Madrid y Hospital HM Puerta del Sur, Móstoles, Madrid.
  - (47) H. U. Príncipe de Asturias Alcalá de Henares. Madrid.
  - (48) H. Clínico Universitario de Valencia. Valencia.
  - (49) Abogado Especialista en Derecho Sanitario y Medicina Legal. Madrid.
  - (50) H. U. HM Sanchinarro. Madrid.
  - (51) Médico Especialista en Aparato Digestivo. Madrid.
  - (52) Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL). Barcelona.
  - (53) H. U. San Pedro. Logroño, La Rioja.
  - (54) Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
-



[www.academiamir.com](http://www.academiamir.com)

**AMIR**



9 788419 592859

